

Вариативное меню в стационарных организациях социального обслуживания: право, данные, практика

Аналитический доклад. Вторая, расширенная и переработанная редакция

Е. В. Чистяков, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

5 октября 2026 г.

Содержание

Сведения о документе.....	6
Аннотация.....	7
Сокращения.....	8
Введение	9
1 Понятия и разграничения	11
1.1 Учреждения: два правовых режима одного стола	11
1.2 Четыре словаря	12
1.3 Три определения в разных слоях материалов	12
1.4 Три шкалы, которые нельзя склеивать.....	13
1.5 Питание как социальная услуга	14
1.6 Краткая история регулирования	14
2 Федеральное право	16
2.1 Конституционные и международные основания	16
2.2 Закон № 442-ФЗ.....	16
2.3 Примерный порядок (приказ № 935н).....	17
2.4 Правила организации деятельности (приказ № 305н).....	17
2.5 Нормы питания: приказ № 520н и методические рекомендации 2002 г.....	19
2.6 Таблица замен: где она находится в праве	21
2.7 Санитарные правила: переход от СанПиН 3590-20 к СанПиН 4282-26.....	22
2.8 Лечебное питание: граница компетенций	24
2.9 Закон № 3185-1 и питание в ПНИ	25
2.10 Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ	26
2.11 Ответственность.....	27
2.12 Итог по федеральному уровню	28
3 Региональные нормы питания	29
3.1 Архитектура регионального регулирования	29
3.2 Санкт-Петербург: постановление № 1284.....	29
3.3 Москва	34
3.4 Свердловская область	35
3.5 Нижегородская область	35
3.6 Омская область	36
3.7 Псковская область	37
3.8 Новосибирская область.....	37
3.9 Красноярский край.....	37
3.10 Ленинградская область.....	38
3.11 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	39
3.12 Брутто и нетто: почему региональные нормы нельзя сравнивать напрямую	39

3.13 Республика Татарстан: пример из здравоохранения.....	40
3.14 Сравнение.....	40
3.15 Что региональные нормы дают выбору	42
4 Российские практики: что известно из открытых источников.....	43
4.1 Метод и ограничения	43
4.2 Болотнинский психоневрологический интернат (Новосибирская область).....	43
4.3 Успенский психоневрологический интернат (Новосибирская область)	44
4.4 Каменский психоневрологический интернат (Новосибирская область)	45
4.5 Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область).....	45
4.6 Иркутская область: региональное сообщение и Чунский ДСО	46
4.7 Красавинский дом социального обслуживания (Вологодская область).....	47
4.8 ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург).....	48
4.9 «Добрый дом „Солнечногорский“» (Московская область)	49
4.10 Сводная таблица	49
4.11 Что следует из совокупности кейсов	50
5 Научные данные	52
5.1 Зачем доклад о праве обращается к исследованиям.....	52
5.2 Масштаб проблемы: недостаточность питания в учреждениях.....	52
5.3 Выбор и удовлетворённость.....	53
5.4 Как жители и персонал описывают выбор: качественные исследования.....	54
5.5 Выбор, среда приёма пищи и пищевой статус.....	54
5.6 Достоинство и приём пищи: национальные данные	56
5.7 Выбор и люди с тяжёлыми психическими расстройствами	56
5.8 Международные клинические рекомендации	57
5.9 Отходы с тарелки как измеритель	57
5.10 Текстуры и ограничения выбора.....	58
5.11 Организационные факторы	58
5.12 Время персонала: сколько стоит помощь при еде.....	59
5.13 Стоимость	60
5.14 Чего наука не знает	60
5.15 Сводная таблица	60
6 Зарубежное регулирование.....	63
6.1 Зачем и с какой осторожностью.....	63
6.2 Англия: регламент CQC	63
6.3 Шотландия: стандарты здравоохранения и социального ухода	64
6.4 США: федеральные требования к домам сестринского ухода	64
6.5 Канада, Онтарио: регламент о долговременном уходе.....	65
6.6 Австралия: усиленные стандарты качества	66
6.7 Германия и Австрия: стандарты профессиональных обществ.....	66

6.8 Швеция: национальные рекомендации и критерии влияния жителя	68
6.9 Дания: право отказаться от отдельного приёма пищи	69
6.10 Япония: управление питанием и «особое питание» по выбору	70
6.11 Сводная таблица	71
6.12 Выводы для российской дискуссии	72
7 Практика: шестнадцать операционных сценариев	73
7.1 Как читать раздел.....	73
7.2 Сценарий 1. Два вторых блюда в пределах нормы № 1284.....	73
7.3 Сценарий 2. Пары внутри одной группы продуктов	74
7.4 Сценарий 3. Заказ накануне или выбор в момент еды	74
7.5 Сценарий 4. Раздача и персонал	75
7.6 Сценарий 5. Санитарный паспорт каждого варианта	76
7.7 Сценарий 6. Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ	76
7.8 Сценарий 7. Комплект документов для проверяющего.....	77
7.9 Сценарий 8. Экономика: что можно утверждать и как измерять	78
7.10 Сценарий 9. Пилот на 90 дней.....	79
7.11 Сценарий 10. Невербальный выбор, отказ, пост и ночной интервал.....	80
7.12 Сценарий 11. Один день меню по нормам № 1284: две точки выбора и проверка по таблице замен.....	81
7.13 Сценарий 12. Лоты и договоры по 223-ФЗ под вариативное меню	82
7.14 Сценарий 13. Документальная цепочка одного дня: что меняется при двух вариантах	83
7.15 Сценарий 14. Персонал и время раздачи: расчёт для одного отделения	85
7.16 Сценарий 15. Жители, которые не могут выразить выбор	86
7.17 Сценарий 16. Пост по Правилам № 305н: неделя с таблицей замен.....	87
7.18 Инструменты измерения: что существует и что из этого применимо	88
8 Контроль: кто и что проверяет.....	92
8.1 Различие предметов контроля.....	92
8.2 Санитарно-эпидемиологический надзор	92
8.3 Государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания: кто проверяет государственный дом-интернат	92
8.4 Региональный государственный контроль: только негосударственные поставщики.....	93
8.5 Учредитель.....	94
8.6 Санкт-Петербург: оценка уровня организации социального питания.....	94
8.7 Контрольно-счётные органы	95
8.8 Прокуратура	95
8.9 Антимонопольный контроль.....	96
8.10 Независимая оценка и общественный контроль	96
8.11 Внутренний контроль	96

8.12 Как выбор проверяют за рубежом.....	97
8.13 Чек-лист наблюдения за приёмом пищи для внутреннего контроля.....	98
8.14 Документы для проверяющего: кто что смотрит.....	99
8.15 Пост как предмет проверки.....	100
8.16 Сводка.....	100
9 Противоречия и нерешённые вопросы.....	102
9.1 Принцип.....	102
9.2 Перечень.....	102
9.3 Что из этого следует для читателя.....	108
10 Предложения.....	109
10.1 Федеральный уровень.....	109
10.2 Региональный уровень.....	110
10.3 Уровень учреждения.....	111
11 Заключение.....	113
Список источников.....	116
Приложение А. Реестр нормативных и иных актов.....	129
Приложение Б. Нормы постановления № 1284: все столбцы для взрослых.....	135
Приложение В. Изменения по сравнению с первой редакцией.....	137
Дополнение второй редакции (октябрь 2026 г.).....	138
Третий проход: литературная правка и дополнительные источники (октябрь 2026 г.).....	139

Сведения о документе

Статус. Это аналитический доклад автора. Он не служит официальным толкованием законодательства и не выражает позиции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, его рабочей группы по вариативному меню или Правительства Санкт-Петербурга. Предложения раздела 10 — рекомендации автора, а не пересказ действующих норм.

Отношение к первой редакции. Доклад вырос из правового обзора «Вариативное меню: НПА» (литературная редакция 29.08.2026, данные на 16.07.2026; папка `raw/sources/variativnoe-menu-npa-2026/` репозитория) [1]. Из обзора взяты региональный анализ и часть источников; найденные в нём ошибки исправлены и перечислены в приложении В; разделы о научных данных, зарубежных нормах, российских кейсах и практических сценариях написаны заново. Там, где новая редакция расходится с первой, расхождение названо в тексте.

Дата актуальности. Нормативные акты сверены по открытым источникам на 05.10.2026. Санитарные требования даны в двух слоях: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — для периода до 31.08.2026 включительно (в том числе для материалов семинара 25–27.08.2026); СанПиН 2.3/2.4.4282-26 — с 01.09.2026 [2, 3].

Классы утверждений. Каждое существенное утверждение принадлежит одному из четырёх классов; если класс не ясен из контекста, он назван в тексте.

Класс	Что означает	Пример
Норма	Обязательное правило, установленное нормативным правовым актом; указаны акт и структурная единица	«Не менее трёх приёмов пищи в день» — подп. 11 п. 56 СанПиН 4282-26
Толкование	Вывод автора из текста нормы; может оспариваться	«Выбор блюда не запрещён, поскольку ни один акт его не ограничивает»
Рекомендация	Методический документ, научное руководство или предложение автора; не обязательно	ESPEN; методические рекомендации 2002 г.; раздел 10 доклада
Локальная форма	Акт или документ конкретного учреждения; обязателен только в нём	Приказ ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124

Источники указаны номерами в квадратных скобках; список помещён в конце доклада. Расчёты, помеченные словами «иллюстративная арифметика», показывают порядок величин и не являются данными учреждений.

Аннотация

Доклад посвящён вариативному меню — такому порядку питания, при котором житель стационарной организации социального обслуживания в момент еды видит перед собой не меньше двух вариантов блюда и сам влияет на то, какой получит. Речь идёт о правовых, организационных и доказательных основаниях этого порядка. Объект — дома социального обслуживания (бывшие дома-интернаты для престарелых и инвалидов) и психоневрологические интернаты России; предмет — нормы, которые решают, что, сколько и как подаётся на стол, и тот зазор, который они оставляют выбору.

Проанализированы федеральные законы и подзаконные акты (среди них не учтённые в первой редакции приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н и Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, утверждённые приказом Минтруда России от 14.05.2025 № 305н, а также СанПиН 2.3/2.4.4282-26, вступивший в силу 01.09.2026), региональные нормы питания десяти субъектов (тексты шести из них — Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Ленинградской области, ХМАО — Югры и Нижегородской области — прочитаны полностью) с подробным разбором постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284, практики восьми российских учреждений, описанные в открытых источниках, и сообщение министра Иркутской области, нормы и процедуры проверки десяти зарубежных систем и научная литература о недостаточности питания, выборе блюд, форме подачи и пищевых отходах в учреждениях долговременно-го ухода.

Основные выводы. Ни федеральное, ни проанализированное региональное право не знает понятия вариативного меню и не ограничивает числа вариантов блюда. Эквивалентная замена продуктов, которую принято называть правовой основой выбора, для взрослых закреплена лишь в методических рекомендациях 2002 г., а те ссылаются на приказ Минторга СССР 1980 г.; таблица замен санитарных правил формально стоит в разделе о питании детей. Научные данные о выборе блюд в домах ухода за пожилыми получены в основном в пилотных и наблюдательных исследованиях; они согласно показывают рост удовлетворённости и неоднозначное влияние на потребление и затраты. Рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрических учреждениях социального обслуживания не найдено. Российские учреждения сообщают о том, что выбор введён, но не о том, к чему он привёл. Практическая часть разбирает сценарии: два горячих блюда в пределах норм № 1284, санитарный контур второго варианта по СанПиН 4282-26, закупка по 44-ФЗ и 223-ФЗ, раздача лежачим, комплект документов для проверки, расчёт затрат и замер отходов, день меню с таблицей замен, лоты по 223-ФЗ, время персонала, выбор за жителей, не способных его выразить, и постное питание. Отдельно показано, что государственные дома-интернаты субъектов с 2021 г. проверяет Роструд и что его проверочный лист 2026 г. спрашивает о нормах питания и постах, но не о выборе.

Ключевые слова: вариативное меню; социальное обслуживание; приказ Минтруда № 305н; дом-интернат; психоневрологический интернат; нормы питания; СанПиН 2.3/2.4.4282-26; приказ Минтруда № 520н; выбор блюд; недостаточность питания; пищевые отходы.

Сокращения

Сокращение	Расшифровка
44-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
223-ФЗ	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
442-ФЗ	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
3185-1	Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»
ДСО	дом социального обслуживания (в Санкт-Петербурге — наименование ряда бывших домов-интернатов и ПНИ)
ИППСУ	индивидуальная программа предоставления социальных услуг
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КПИ	Конвенция ООН о правах инвалидов
ПНИ	психоневрологический интернат
РГ	рабочая группа Минтруда России по вариативному меню
СанПиН 3590-20	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (действовал до 31.08.2026)
СанПиН 4282-26	СанПиН 2.3/2.4.4282-26 с тем же названием (действует с 01.09.2026 до 01.09.2032)
СБКС	смесь белковая композитная сухая
ТТК	технико-технологическая карта
ESPEN	European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
М0–М5	модели организации раздачи (ось технологии стола), см. п. 1.4
Ступени 0–5	ступени участия жителя (ось контроля над едой), см. п. 1.4

Введение

Проблема. Только в психоневрологических интернатах России, по подсчёту проекта «Если быть точным», на 2024 г. было 466 учреждений и около 139 тыс. жителей, из которых 74 % признаны недееспособными [4]; к ним добавляются жители домов-интернатов общего типа, общее число которых в использованных источниках с проверяемыми реквизитами не найдено. Еда повторяется в их жизни несколько раз в день, и это та её часть, где выбор технически возможен. Тем не менее питание в таких учреждениях устроено как обеспечение: регион утверждает суточный набор продуктов в граммах, пищеблок составляет цикличное меню и меню-раскладку, отделение получает одинаковые порции. Выбор в этой конструкции не запрещён и не предусмотрен. Он появляется там, где его вводит само учреждение, и исчезает вместе с тем, кто его ввёл.

С 2024 г. в открытых источниках стали появляться сообщения о вариативном питании в психоневрологических интернатах Новосибирской области, в учреждениях Иркутской области и в ДСО «Серафимовский» Санкт-Петербурга [5–19]. В 2026 г. тема стала предметом работы рабочей группы Минтруда России и межрегионального семинара 25–27.08.2026. Вопрос директора прост: можно ли подавать два вторых блюда, не нарушив норм питания, санитарных правил и закупочного законодательства, и что держать в папке на случай проверки. Простого ответа нет, потому что три слоя права — социальный, санитарный и закупочный — писались независимо друг от друга и о выборе молчат все три.

Цель доклада — установить, какие нормы действующего права определяют питание в стационарных организациях социального обслуживания и сколько места они оставляют выбору блюд; собрать, что известно о последствиях выбора из исследований и практики; предложить организационные решения, которые можно проверить, не выдавая их за нормы.

Задачи:

1. развести понятия, которые в отраслевой речи смешиваются (цикличное меню, вариативное меню, таблица замен, персонализация питания), и шкалы, которыми описывают внедрение;
2. проанализировать федеральные акты, включая изменения 2022–2026 гг., и установить, где именно в праве находится механизм эквивалентной замены;
3. сопоставить региональные нормы питания, прежде всего постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1284;
4. описать российские практики с указанием того, что источник сообщает и чего не сообщает;
5. обобщить научные данные и зарубежные нормы о выборе блюд в учреждениях длительного ухода;
6. разобрать практические сценарии внедрения с опорой на действующие нормы;
7. перечислить противоречия и пробелы и сформулировать предложения с явной пометкой их статуса.

Методы и источники. Применены формально-юридический анализ текстов нормативных актов в действующих редакциях (официальные публикации, справочные системы «Гарант», «КонсультантПлюс», ведомственные сайты); сравнительно-правовой анализ региональных и зарубежных норм; структурированный поиск научной литературы в Europe PMC/PubMed и eLIBRARY/КиберЛенинке по запросам о выборе блюд, удовлетворённости питанием, форме подачи, недостаточности питания и пищевых отходах в учреждениях длительного ухода (поиск выполнен 05.10.2026; это целевой, а не систематический обзор); анализ публичных сообщений учреждений и органов власти. Вторичной базой послужили материалы репозитория семинара: первая редакция обзора [1], доклад «Не просто накормить» и сопровождающая его база знаний с реестром противоречий [20, 21]. Их утверждения перепроверены по первоисточникам; где проверить не удалось, это оговорено.

Ограничения. Доклад не назначает диет, текстур и лечебного питания: это решения врача, и подменять их доклад не берётся. Сведения о практике учреждений взяты из их публичных сообщений и аудитом не являются. Стоимость питания приводится только по опубликованным источникам, а расчёты без источника помечены как иллюстративные. Тексты нескольких региональных актов известны по первой редакции обзора и заново не сверялись; при их изложении это сказано.

Что нового во второй редакции. По сравнению с первой редакцией [1]: (а) введён анализ приказ Минтруда России № 520н — действующие федеральные рекомендуемые нормы питания; (б) санитарный блок переписан под СанПиН 4282-26 с постановочным сопоставлением; (в) установлено, что таблица замен СанПиН относится к разделу о питании детей, а нормы взаимозаменяемости методических рекомендаций 2002 г. содержатся в приложении № 7, а не № 6; (г) добавлен анализ Закона № 3185-1 для ПНИ; (д) исправлены ссылки на ограничение платы в 75 % и на статьи КоАП; (е) добавлены разделы о научных данных (около двадцати исследований и руководств), зарубежных нормах и восьми российских кейсах; (ж) практическая часть расширена до шестнадцати сценариев; (з) прочитаны полные тексты норм питания шести субъектов и показано, что нормы выражены в разных единицах (брутто и нетто); (и) добавлены тарифы Санкт-Петербурга на 2026 г., порядок государственного контроля по ст. 33 442-ФЗ, проверочный лист Роструда 2026 г. и выводы контрольно-счётной палаты о документальной цепочке питания; (к) перечень противоречий расширен до сорока позиций, включая две ошибки самой второй редакции, исправленные при дополнении. Полный перечень изменений — в приложении В.

1 Понятия и разграничения

1.1 Учреждения: два правовых режима одного стола

Стационарная форма социального обслуживания определена 442-ФЗ как предоставление социальных услуг при постоянном, временном или пятидневном круглосуточном проживании получателя в организации [22; 23, п. 11]. Внутри неё живут учреждения двух типов, и для нашей темы разница между ними существенна.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов действуют в режиме 442-ФЗ: права получателя определяются ст. 9 закона, объём услуг — индивидуальной программой и договором (ст. 16, 17), нормы питания — актом субъекта (ст. 8).

Психоневрологические интернаты подчиняются тому же закону, но к ним применяется ещё и Закон № 3185-1. Его ст. 43 распространяет на лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, права, предусмотренные частями второй и четвёртой ст. 37, а обязанности организации по созданию условий для их реализации относит к ст. 39 и законодательству о социальном обслуживании [24]. Среди прав ч. 2 ст. 37 — право «исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост», если это не нарушает внутренний распорядок [24]. Это единственная найденная норма федерального закона, которая прямо касается того, что лежит у жителя на тарелке: пост для жителя ПНИ — его право, а не милость кухни. С 01.09.2025 та же обязанность подзаконным актом распространена на все организации социального обслуживания: Правила, утверждённые приказом Минтруда России № 305н, обязывают их «обеспечивать условия для исполнения религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов, в том числе постов» (подп. 15 п. 20) [25] (подробнее — п. 2.4). Первая редакция обзора Закона № 3185-1 не упоминала [1]; для ПНИ это заметный пропуск.

Переименование ПНИ в дома социального обслуживания, к концу 2025 г. проведённое, по данным «Если быть точным», по меньшей мере в 41 регионе [4], опирается на федеральный акт: Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, действующие с 01.09.2025, называют среди видов стационарных организаций дом социального обслуживания, специальный дом-интернат и иные организации (п. 29), но не психоневрологический интернат [25]. Само по себе переименование правового режима Закона № 3185-1 не меняет. В Санкт-Петербурге, по сообщению Комитета по социальной политике от 22.07.2025, психоневрологических интернатов больше нет: все они переименованы в дома социального обслуживания, а их уставы обновляются [19]. Сайт ДСО «Серафимовский» до прекращения работы располагался на домене pni9.ru [26]. Для ст. 43 Закона № 3185-1 важно назначение организации, а не вывеска. В ДСО, где живут люди без психиатрического диагноза, опорой остаётся 442-ФЗ. Поэтому решения раздела 7 для бывшего ПНИ проверяются по двум законам, для дома-интерната общего типа — по одному.

1.2 Четыре словаря

Словами «вариативное меню» в отрасли называют по меньшей мере четыре разных явления. Из их смешения и вырастает большая часть споров — с проверяющими и с самими собой.

Циклическое меню — разнообразие во времени: набор блюд повторяется через 7, 10, 14 или 21 день. Циклическое меню обязательно в силу санитарных правил для детских организаций (не менее двух недель, п. 59 подп. 4 СанПиН 4282-26 [3]) а во взрослых учреждениях сложилось как привычка. Жителю оно ничего не предлагает выбрать: «четырнадцать дней без повторов» описывает меню, а не свободу человека.

Таблица замен (нормы взаимозаменяемости) — инструмент склада и раскладки: при отсутствии продукта он заменяется другим в эквивалентном по пищевой ценности количестве. Таблица защищает норму, а не выбор. Гречка, заменённая рисом «по остаткам», — замена, а не вариант. Где таблица замен для взрослых находится в праве, разобрано в п. 2.6.

Персонализация питания — индивидуальные решения по медицинским показаниям: диета, консистенция, обогащение, режим. Её основание — назначение врача, кухня его исполняет. Выбором в смысле доклада персонализация не является и подменять его не должна: житель с назначенной протёртой пищей имеет право на выбор среди протёртых блюд, но не на отмену назначения через «выбор».

Вариативное меню — организация питания, при которой житель в момент приёма пищи располагает не менее чем двумя вариантами блюда и влияет на то, какой получит. Это определение (толкование) принято в докладе «Не просто накормить» [20] и используется здесь как основное.

Четыре словаря различает один вопрос: что изменилось в тарелке конкретного жителя сегодня и кто это решил? Если решили регион и кухня — это цикл или замена. Если решил врач — персонализация. Если решил сам житель (или, при невозможности сказать, по наблюдаемым признакам его воли) — выбор.

1.3 Три определения в разных слоях материалов

В материалах, на которые опирается доклад, вариативное меню определено по-разному, и это расхождение нужно держать в поле зрения.

Слой	Определение (в пересказе)	Охват
«Не просто накормить», гл. 8.1 [20]	В момент еды у жителя не менее двух вариантов, и он влияет на то, какой получит	Узкое
Обзор НПА, § 1.2 [1]	Проживающему на каждый приём пищи (или на основные приёмы) предлагают выбор из двух и более вариантов блюд, гарниров, салатов или напитков в рамках утверждённых норм, «либо дают возможность заказать блюдо заранее из утверждённого ассортимента»	Шире: включает заказ на любой срок вперёд

Слой	Определение (в пересказе)	Охват
Предшествующий доклад семинара, гл. 4.1 [21]	Любое расширение выбора — от напитка до полной индивидуализации	Самое широкое

Узкое определение удобно проверять: его исполнение видно в журнале и на линии раздачи. Широкое удобно для отчёта: под него подходит почти любая перемена. Доклад пользуется узким определением и отдельно оговаривает случаи предварительного заказа. Заказ накануне (так устроена практика ДСО «Серафимовский» [19]) по узкому определению является выбором при условии, что заказанное блюдо фактически подаётся заказавшему; заказ на неделю вперёд — выбор с отсрочкой, при котором право изменить решение в день подачи становится отдельным вопросом.

1.4 Три шкалы, которые нельзя склеивать

Степень внедрения материалы семинара описывают тремя независимыми шкалами.

Модели раздачи М0–М5 — ось технологии стола [20, 21]:

Модель	Содержание	Публичные российские примеры
М0	Мономеню; при отказе — замена по таблице; остатки влияют на цикл	Фундамент, не вариативность
М1	Второй вариант одной ключевой позиции, не каждый день	Болотнинский ПНИ [5]; ДСО «Серафимовский» (заказ накануне) [19]
М2	Два варианта основных позиций ежедневно	Успенский ПНИ [7]; сообщение по Иркутской области [13]
М3	Житель сам комплектует тарелку на линии	Линия самообслуживания ДДСОЛ [27]
М4	Семейная подача: блюда на столе, жители накладывают сами	Зарубежные исследования [28]; в России публично не описано
М5	Жители готовят сами (учебная квартира)	Сопровождаемое проживание; не массовая модель

Ступени участия 0–5 — ось жителя: насколько контроль над едой возвращён человеку (0 — еду определили регион, кухня и смена; 1 — спросили, тарелка та же; 2 — выбор дошёл до тарелки; 3 — добавились время и место; 4 — житель влияет на меню через совет; 5 — еда снова часть жизни, а не процедуры) [20, 21].

Пять моделей обзора НПА (§ 4.2) — организационные формы: двухвариантное меню; меню-заказ на неделю; шведский стол; смешанная модель (выбор несколько раз в неделю); событийная (праздничные меню) [1].

Шкалы меряют разное. Дом может работать по М2 (два вторых ежедневно), а жители отделения милосердия при этом остаются на ступени 0, если выбор существует только в столовой, куда они не спускаются. Нумерации не совпадают: «модель 1» обзора НПА не равна М1, «ступень 2» не равна М2. В первой редакции обзора Болотнинский

ПНИ одновременно отнесён к модели 1 и модели 4 [1]; по шкале М0–М5 это М1, а по пятичленной шкале обзора — смешанная модель (выбор несколько раз в неделю). Шкалу моделей обзора НПА доклад приводит только в цитатах.

1.5 Питание как социальная услуга

Обеспечение питанием относится к социально-бытовым услугам, перечень которых устанавливает субъект Российской Федерации на основании ст. 8 и ст. 20 442-ФЗ [22]. Федеральный Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме (приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н) содержит два положения, прямо относящихся к питанию [23]:

- при расчёте объёма услуг учитываются нормы и нормативы, в том числе нормы питания, установленные в соответствии с 442-ФЗ; если нормы не установлены, объём услуги не может быть меньше предусмотренного индивидуальной программой и договором (п. 16) — **норма**;
- при оценке качества социально-бытовых услуг оценивается питание, «которое должно быть приготовлено из доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателей социальных услуг по калорийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам» (подп. 5 п. 19) — **норма**.

В том же п. 19 есть красноречивое соседство. Мягкий инвентарь должен соответствовать «по возможности, их запросам по фасону и расцветке» (подп. 4) [23]. Предпочтения получателя федеральный критерий качества учитывает для одежды, но не для еды: питание оценивают по доброкачественности, калорийности и соответствию нормам. Запрета учитывать вкус отсюда не следует. Следует лишь, что критерий качества этого не требует, и учреждение, вводящее выбор блюд, опирается не на п. 19, а на общие права получателя (ст. 9 442-ФЗ) и на свои локальные акты (толкование).

1.6 Краткая история регулирования

Хронология нужна потому, что в сегодняшней практике одновременно работают документы пяти десятилетий.

Год	Акт	Значение для темы
1980	Приказ Минторга СССР от 12.12.1980 № 310	Нормы взаимозаменяемости продуктов; извлечение из него до сих пор приложено к методическим рекомендациям 2002 г. [29]
1992	Закон РФ № 3185-1	Права жителей ПНИ, включая соблюдение поста (ст. 37, 43) [24]

Год	Акт	Значение для темы
2002	Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12	Методические рекомендации по организации питания; рекомендуемые наборы, меню-раскладки для ПНИ и прочих учреждений, нормы взаимозаменяемости [29]
2007	Приказ Минздравсоцразвития от 04.06.2007 № 397	Новая редакция рекомендаций 2002 г. [29]
2013	442-ФЗ	Нормы питания утверждает субъект (ст. 8) [22]
2014	Приказы Минтруда № 552н и № 935н	Первые федеральные рекомендуемые нормы питания; Примерный порядок [23, 30]
2014	Постановление Правительства СПб № 1284	Нормы питания Санкт-Петербурга с 01.01.2015 [31]
2020	СанПиН 3590-20	Единые санитарные требования к общественному питанию, в том числе в организациях социального обслуживания [2]
2022	Приказ Минтруда № 520н	Новые рекомендуемые нормы; № 552н утратил силу [30]
2025	Приказ Минтруда от 14.05.2025 № 305н	Правила организации деятельности организаций социального обслуживания с 01.09.2025 (вместо приказа № 940н 2014 г.); обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов; ПНИ нет в перечне видов организаций [25]
2026	СанПиН 4282-26	С 01.09.2026 заменяет СанПиН 3590-20 без переходного периода [3]

Первая редакция обзора строила федеральный методический блок на постановлении № 12 от 2002 г., назвав его «действующим, но морально устаревшим» [1]; приказа № 520н, принятого двадцатью годами позже, она не упоминает. Номер «774н», встречающийся в одном из академических слоёв материалов семинара [21], по открытым источникам не подтверждён и в докладе не используется.

2 Федеральное право

2.1 Конституционные и международные основания

Конституция Российской Федерации о питании прямо не говорит. Для темы важны три её положения: охрана достоинства личности, которое ничто не может умалять (ст. 21), социальное государство, гарантирующее государственную поддержку пожилых граждан и инвалидов (ст. 7, 39), и право на охрану здоровья (ст. 41) [32]. Права на два вторых блюда из них не вывести; выводится другое — ограничения в повседневной жизни жителя должны иметь основание, а не вырастать из удобства организации (толкование).

В Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Россией в 2012 г., к делу относятся три нормы: право на самостоятельный образ жизни и вовлечённость в местное сообщество (ст. 19), на здоровье (ст. 25) и на достаточный жизненный уровень, «включающий достаточное питание» (ст. 28) [33]. Комитет ООН по правам инвалидов в Замечании общего порядка № 1 (2014) к ст. 12 разъяснил, что замещающее принятие решений должно уступать место поддерживаемому [34]. Для ПНИ, где большинство жителей признаны недееспособными [4], это значит, что вопрос «может ли этот человек выбрать» надо ставить как вопрос «какая поддержка ему нужна, чтобы выбор был его», а не закрывать ссылкой на недееспособность (толкование; правовые последствия Замечания для российских судов не исследуются).

2.2 Закон № 442-ФЗ

По 442-ФЗ содержимое тарелки определяет субъект Российской Федерации. Органы государственной власти субъекта утверждают нормы питания в организациях социального обслуживания (ст. 8), перечень социальных услуг, порядок их предоставления и тарифы [22] — **норма**. Федеральный центр устанавливает примерный порядок (приказ № 935н) и рекомендуемые нормы питания (приказ № 520н), но регион не обязан их повторять (толкование, основанное на рекомендательном характере обоих актов).

Для выбора блюд важны следующие положения закона [22] — **нормы**:

- социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства (ч. 1 ст. 4);
- получатель имеет право на уважительное и гуманное отношение, на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах, о видах и условиях социальных услуг, на отказ от предоставления социальных услуг, на участие в составлении индивидуальной программы, на условия пребывания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, и на надлежащий уход (ст. 9);
- индивидуальная программа определяет форму, вид, объём, периодичность и условия предоставления услуг (ст. 16), договор — их состав и стоимость (ст. 17);

- размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание рассчитывается на основе тарифов, но не может превышать 75 % среднедушевого дохода получателя (ч. 4 ст. 32).

К последнему положению материалы семинара дают две разные ссылки: доклад «Не просто накормить» относит ограничение в 75 % к ч. 4 ст. 32 442-ФЗ, первая редакция обзора — к п. 35 приказа № 935н [1, 20]. Сверка текстов показала, что верны обе: п. 35 Примерного порядка дословно повторяет закон [23]. Источник нормы — закон, приказ её воспроизводит. Противоречия нет; есть разная глубина ссылки.

Для вариативного меню существеннее другое. Право на отказ от услуги (ст. 9) охватывает отказ от конкретного блюда (толкование), но закон не говорит, что учреждение должно предложить взамен. Право на участие в составлении ИППСУ позволяет внести в программу пищевые предпочтения, но федеральная форма программы для этого не предназначена; прямого права на ежедневный выбор блюда закон не содержит [21]. В 442-ФЗ выбор возможен, но не гарантирован.

2.3 Примерный порядок (приказ № 935н)

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н утверждает Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме [23]. Он устанавливает, что объём услуг рассчитывается с учётом норм питания (п. 16), а качество социально-бытовых услуг оценивается, в частности, по питанию из доброкачественных продуктов, удовлетворяющему потребности по калорийности и соответствующему нормам и санитарным требованиям (подп. 5 п. 19). Критерии полноты, своевременности и результативности (п. 18) общие для всех услуг. Как показано в п. 1.5, критерий качества упоминает «запросы» получателя применительно к одежде, но не к питанию.

Со статусом приказа нужна точность: Примерный порядок — ориентир для субъектов, а не прямой регулятор учреждения. Порядок предоставления услуг утверждает субъект (ст. 8 442-ФЗ) [22]. Поэтому ссылка «по п. 19 приказа № 935н питание должно быть разнообразным» неверна дважды: пункт этого не говорит, и учреждение подчиняется региональному порядку (толкование).

2.4 Правила организации деятельности (приказ № 305н)

С 01.09.2025 действуют Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утверждённые приказом Минтруда России от 14.05.2025 № 305н (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2025 № 82485; действует до 01.09.2031) [25]. Приказ издан на основании п. 6 ч. 2 ст. 7 442-ФЗ и признал утратившим силу приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н с изменениями. Ни первая редакция обзора, ни прежние материалы семинара этого акта не рассматривали [1, 20, 21], хотя для темы он весит больше Примерного порядка: в отличие от приказа № 935н, Правила обращены прямо к организациям, а не к субъектам как образец.

Для питания и выбора существенны четыре группы положений — **нормы**, если не указано иное:

- нормы питания в организациях, находящихся в ведении субъекта, устанавливаются актами субъекта в рамках полномочий по ст. 8 442-ФЗ (п. 15) — федеральный акт подтверждает распределение компетенции, а не вводит собственных норм;
- организация обязана предоставлять услуги в соответствии с индивидуальными программами и договорами (подп. 2 п. 20), бесплатно и в доступной форме информировать получателей о видах, порядке и условиях услуг (подп. 4 п. 20), создавать «комфортные безопасные условия пребывания», в том числе в помещениях для принятия пищи (подп. 13 п. 20), и размещать получателей в спальнях с учётом пола, возраста, «интересов и предпочтений, личностных особенностей» (подп. 10 п. 20);
- организация обязана «обеспечивать условия для исполнения религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов, в том числе постов» (подп. 15 п. 20) — для всех организаций социального обслуживания, а не только для ПНИ, как по ст. 43 Закона № 3185-1;
- стационарные организации создаются для разнополого состава получателей и подразделяются на дом социального обслуживания (в том числе детский), специальный дом-интернат и иные организации (п. 29); вид «психоневрологический интернат» в перечне отсутствует.

Приложение № 2 к Правилам — рекомендуемый перечень оборудования стационарных организаций — содержит отдельную позицию «помещение для приготовления пищи получателями социальных услуг» с обеденным столом и стульями по числу одновременно пользующихся, бытовым холодильником, кухонным гарнитуром, бытовой техникой (варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, мультиварка, микроволновая печь, блендер и др.), кухонной и столовой посудой, специальной посудой, адаптированной под потребности инвалидов, аксессуарами для сервировки стола и фартуками [25] — **рекомендация**. Это первое найденное в федеральном акте признание того, что житель стационара может сам готовить себе еду; модель М5 шкалы раздачи (п. 1.4) — жители готовят сами — получает тем самым опору в федеральном перечне оборудования, пусть и рекомендательную. Позиция не уточняет, предназначено ли помещение для повседневного питания или для обучения бытовым навыкам; в последнем случае она относится к подготовке к сопровождаемому проживанию, а не к организации основного питания.

Последствия для вариативного меню (толкование). Во-первых, обязанность обеспечить условия для соблюдения поста превращает постное блюдо из пожелания в предмет государственного контроля (надзора) по ст. 33 442-ФЗ во всех стационарных организациях — федерального (Роструд) для организаций субъекта и регионального для негосударственных поставщиков; с 24.02.2026 этот вопрос прямо включён в проверочный лист Роструда (п. 8.3) [35]: учреждение должно уметь показать, как житель, соблюдающий пост, получает питание в пределах норм. Самый простой способ — постный вариант в составе вариативного меню; альтернативы — индивидуальная замена по заявлению или отдельный постный рацион. Юрист проекта «Регион забо-

ты» А. Гаганов в комментарии к приказу сделал тот же вывод: норма «склоняет интернаты к необходимости обеспечивать вариативное питание хотя бы во время религиозных постов» [36]. Во-вторых, выбора блюд как такового Правила не требуют; обосновывать приказом № 305н ежедневный выбор из двух вторых значило бы толковать его расширительно. В-третьих, предпочтения получателя упоминаются в Правилах применительно к размещению по спальням, но не к питанию — та же асимметрия, что в критериях качества приказа № 935н (п. 1.5).

2.5 Нормы питания: приказ № 520н и методические рекомендации 2002 г.

2.5.1 Приказ № 520н

Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» признал утратившим силу приказ от 13.08.2014 № 552н и, согласно письму Минюста России от 18.10.2022 № 01/119931-АБ, не нуждается в государственной регистрации [30]. Он содержит две таблицы: для получателей 18 лет и старше и для детей от одного года до 18 лет в пяти возрастных группах. Нормы выражены в граммах (миллилитрах) брутто и нетто на человека в сутки.

Это **рекомендация** федерального уровня: субъект, утверждая свои нормы, вправе от неё отступить. В первой редакции обзора приказ № 520н отсутствует; федеральной опорой норм там названо постановление № 12 от 2002 г. [1]. С 2022 г. федеральный ориентир по продуктовому набору для взрослых — № 520н, а не таблицы 2002 г.

Два свойства приказа № 520н важны для выбора блюд.

Во-первых, смесь белковая композитная сухая (27 г) и витаминно-минеральные комплексы (50–100 % физиологической нормы) отмечены в нём сноской «по медицинским показаниям» [30]. Федеральная рекомендация не вводит специализированные продукты в рацион каждого жителя, а связывает их с назначением. Петербургская норма, как видно из п. 3.2, устроена иначе.

Во-вторых, приказ задаёт продукты группами («крупы (рисовая, гречневая, пшённая, манная, овсяная и другие); горох, фасоль, чечевица» — 80 г; «овощи свежие (свёкла, морковь, капуста, лук репчатый, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зелёная стручковая)» — 340 г нетто) [30]. Какой продукт взять внутри группы, норма не говорит. Отсюда и берётся главное законное пространство для вариантов: две каши из одной группы круп не требуют пересчёта нормы (толкование).

2.5.2 Постановление № 12 от 2002 г.

Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 04.06.2007 № 397) по данным справочных систем не отменено [29]. Оно содержит рекомендуемые продуктовые наборы, подробные меню

раскладки для учреждений, кроме ПНИ (приложение № 4), и для ПНИ (приложение № 6), а также «Нормы взаимозаменяемости некоторых продуктов при изготовлении блюд» — извлечение из приказа Минторга СССР от 12.12.1980 № 310 (приложение № 7) [29]. Первая редакция обзора называла нормы взаимозаменяемости приложением № 6 [1]; по действующей редакции в системе «Гарант» это приложение № 7. В действующей редакции есть и второй инструмент замены — приложение № 8 «Замена продуктов по белку и углеводам» (в первоначальной редакции — таблица замены продуктов по основным пищевым веществам из приказа Минздрава СССР от 12.06.1984 № 666) [29]. Для вариативного меню приложение № 8 полезнее приложения № 7: нормы Минторга описывают замену сырья при изготовлении одного и того же блюда, а таблица по белку и углеводам позволяет сопоставить разные блюда.

Пункт 3 рекомендаций формулирует требования, которые прямо касаются выбора: ежедневное включение в меню мяса или рыбы, зерновых, хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, молочных продуктов и сахара, а остальных продуктов — еженедельно по семидневному меню; коррекция рациона включением 10–20 % легкоусвояемого белка специализированных продуктов (СБКС); недопущение длительных перерывов между приёмами пищи, «особенно между ужином предыдущего и завтраком последующего дня» [29]. Первое требование задаёт рамку выбора: житель может выбрать между мясным и рыбным блюдом, но день без обоих рекомендации не предусматривают. Пункт 4 рекомендует учреждениям использовать приложения № 1–9 «для самостоятельного составления меню» [29] — меню составляет учреждение, а не вышестоящий орган. Отдельно Минтруд России утвердил методические рекомендации по организации диетического (лечебного) питания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (постановление от 25.12.2003 № 90) [37]; их содержание для доклада не анализировалось.

По вторичному источнику, рекомендации 2002 г. (в части, не опубликованной в открытой версии справочной системы) допускают при наличии медицинских показаний назначение дополнительного питания с увеличением калорийности, пищевой ценности, количества продуктов и выхода блюд на 10–15 %, а также установление индивидуального объёма выдаваемой пищи [38]. Если это положение подтвердится по первоисточнику, оно — единственное найденное федеральное упоминание индивидуального объёма порции в социальном обслуживании (текст рекомендаций целиком в ходе подготовки доклада не получен; положение приведено по цитате в научной статье).

Как соотносятся два федеральных документа, формально не урегулировано: № 520н не отменяет № 12, и оба носят рекомендательный характер. Разумно читать их так (толкование): продуктовый набор — по № 520н как более позднему и специальному; организационные приёмы, меню-раскладки и нормы взаимозаменяемости — по № 12, пока не принято иное. В академическом слое материалов семинара упоминается приказ «№ 774н» как акт о нормах питания [21]; по открытым источникам этот номер не подтверждён.

2.5.3 Нормы физиологических потребностей

Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» служат ориентиром для расчёта пищевой ценности рациона [39]. Они не устанавливают продуктовых наборов и не регулируют порядок подачи — **рекомендация**.

2.6 Таблица замен: где она находится в праве

Почти все отраслевые материалы, включая обе прежние работы семинара, утверждают, что таблицы замен «легализуют» вариативность: если вариант Б эквивалентен варианту А по таблице, норма соблюдена [1, 20]. Сверка с источниками показывает: по смыслу это верно, но адрес нужно уточнить.

СанПиН. Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учётом пищевой ценности — приложение № 11 к СанПиН 4282-26 (как и ранее приложение № 11 к СанПиН 3590-20). Отсылка к ней содержится в подп. 4 п. 59 СанПиН 4282-26 («Допускается замена одного вида пищевой продукции... в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учётом её пищевой ценности (приложение № 11)») [3]; в СанПиН 3590-20 аналогичная норма — п. 8.1.4 [2]. Оба пункта расположены в разделе VIII «Особенности организации общественного питания детей». Раздел VII об особых требованиях к питанию взрослого населения, включая организации социального обслуживания (п. 56), на таблицу замен не ссылается [3]. Буквально таблица замен СанПиН — норма для детских организованных коллективов, а для взрослых — допустимый ориентир, применяемый по аналогии (толкование). Свердловская область сделала эту аналогию нормой регионального уровня, указав в своём акте о нормах питания замену по приложению № 11 [1, 40].

Методические рекомендации 2002 г. Нормы взаимозаменяемости приложения № 7 к постановлению № 12 — единственный найденный федеральный документ о замене продуктов, адресованный именно учреждениям социального обслуживания взрослых [29]. Его содержание восходит к приказу Минторга СССР 1980 г. — **рекомендация**.

Региональные акты. Омский приказ № 171-п отсылает к нормам взаимозаменяемости рекомендаций 2002 г.; московский приказ № 228, по описанию первой редакции обзора, предусматривает замену «по нормам взаимозаменяемости» [1]. Постановление Санкт-Петербурга № 1284 в действующей редакции положений о замене продуктов не содержит (проверено по тексту редакции от 27.06.2022 [31]). В текстах норм Красноярского края (ред. от 14.10.2021), Ленинградской области (приказ от 30.12.2021 № 04-58, прил. 3) и Новосибирской области (приказ № 1164 в ред. от 25.05.2023), прочитанных для этой редакции, положений о взаимозаменяемости продуктов для совершеннолетних также не найдено [41–43]. Там, где региональный акт молчит, таблицу замен вводит локальный акт: например, положение об организации питания нижегородского ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» допускает при отсутствии продукта замену «при сохранении химического состава и энергетической ценности» по двум собственным приложениям — таблице взаимо-

заменяемости продуктов и таблице норм замены по белкам и углеводам [44]. Это локальная форма, а не норма, но она показывает: механизм, нужный вариативному меню, во многих учреждениях уже есть — для вынужденных замен.

Медицинское право. Подп. 2 п. 56 СанПиН 4282-26 требует «в дни замены пищевой продукции и блюд» подсчитывать химический состав и пищевую ценность диет, но этот подпункт адресован медицинским организациям [3].

Вывод (толкование): механизм эквивалентной замены для взрослых в социальном обслуживании существует, но держится на документах рекомендательного характера, на аналогии с детским разделом санитарных правил и на региональных актах там, где они это предусмотрели. Директору отсюда следует практическое правило: таблица замен, которой пользуется учреждение, должна быть утверждена его локальным актом со ссылкой на источник — приложение № 7 к рекомендациям 2002 г., приложение № 11 к СанПиН 4282-26 или региональный акт. Голая ссылка «по СанПиН» во взрослом учреждении уязвима.

2.7 Санитарные правила: переход от СанПиН 3590-20 к СанПиН 4282-26

2.7.1 Хронология и действие во времени

СанПиН 2.3/2.4.4282-26 утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18, зарегистрирован Минюстом России 02.06.2026 (№ 86854), вступил в силу 01.09.2026 и действует до 01.09.2032 [3]. Тем же постановлением признаны утратившими силу постановление от 27.10.2020 № 32 об утверждении СанПиН 3590-20 и постановление от 22.08.2024 № 9 о внесении в него изменений. Переходного периода постановление не предусматривает.

Отсюда два правила (толкование по общему принципу действия акта во времени). Журналы, технологическая документация и программа производственного контроля, оформленные до 31.08.2026 по формам СанПиН 3590-20, законны в том виде, в каком они составлены; переоформлять их задним числом не требуется и вредно. С 01.09.2026 действуют формы и требования СанПиН 4282-26; документы, ссылающиеся на пункты утратившего силу акта, должны быть перепривязаны. Первая редакция обзора, подготовленная до опубликования нового СанПиН, указывала, что СанПиН 3590-20 действует до 01.01.2027 [1]; эта дата утратила значение.

2.7.2 Что изменилось для организаций социального обслуживания

Предмет	СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026)	СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026)
Кратность и диетическое питание	Не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям (раздел VII, п. 7.1.11 по нумерации, приводимой в [1, 21])	То же: подп. 11 п. 56 [3]

Предмет	СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026)	СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026)
Привлечение стороннего организатора питания	Требования к суточным пробам и помещению (п. 7.1.12–7.1.14 по [21])	При использовании готовых блюд выделяется помещение для приёма и отбора суточных проб; пробы отбирает ответственный работник пищеблока по подп. 4 (подп. 12 п. 56)
Бракераж	—	Блюдо при нарушении технологии или неготовности не выдаётся до устранения; результат — в журнале бракеража по приложениям № 4 и 5 (подп. 13 п. 56)
Распространение на сторонние предприятия	—	Требования п. 56 распространяются на привлекаемые предприятия общественного питания (подп. 14 п. 56)
Рекомендательные нормы	—	Оценка соблюдения рекомендательных норм не может быть предметом федерального санитарного надзора (п. 3)
Технологические документы	Требование существовало	Изготовление — по технологическим документам, утверждённым руководителем; наименования блюд в меню должны соответствовать технологическим документам (п. 11)
Время на раздаче	—	Не более 3 часов с момента изготовления для блюд, требующих разогревания; запрет реализации готовых блюд на следующий день и замораживания нереализованных блюд (п. 32)

Левый столбец заполнен по нумерации, приводимой в материалах семинара, и не сверялся с текстом СанПиН 3590-20 по каждой строке; правый — по тексту СанПиН 4282-26 [3]. Прочерк в левом столбце означает, что сопоставимое требование в материалах семинара не приводилось, а не то, что его не было.

2.7.3 Что новый СанПиН говорит о выборе

Ни СанПиН 3590-20, ни СанПиН 4282-26 не ограничивают число вариантов блюда и не обязывают предоставлять выбор [2, 3] — **толкование**, основанное на отсутствии соответствующих норм в обоих текстах. Для вариативного меню существенны четыре положения нового СанПиН.

1. **Технологическая карта на каждый вариант** (п. 11). Каждое блюдо, указанное в меню, должно иметь технологический документ, утверждённый руководителем, с тем же наименованием. Второй вариант без ТТК — нарушение, как бы хорош он ни был.
2. **Три часа на раздаче** (п. 32). Ограничение касается блюд, требующих разогревания перед употреблением, и считается с момента изготовления. Для варианта, приготовленного «с запасом» в ожидании спроса, это прямой предел. Остат-

ки нельзя реализовать на следующий день и нельзя заморозить для последующей реализации.

3. **Бракераж каждого блюда** (подп. 13 п. 56). Поскольку бракераж проводится по блюду, второй вариант требует собственной записи в журнале.
4. **Суточные пробы** (подп. 4 и 12 п. 56). Подп. 4 сформулирован для пищеблоков медицинских организаций; к организациям социального обслуживания отсылка сделана в подп. 12 — для случая готовых блюд от стороннего предприятия. Обязанность учреждения с собственным пищеблоком отбирать суточную пробу каждого блюда прямо в п. 56 не сформулирована; на практике её следует сохранять, поскольку суточная проба от каждой партии — общая практика производственного контроля по принципам ХАССП (п. 4) и требование, которое проверяющий будет ожидать (толкование; вопрос стоит уточнить у территориального органа Роспотребнадзора).

Отдельно о п. 3. Санитарный надзор не оценивает соблюдение рекомендательных норм [3]. Продуктовые наборы приказа № 520н и рекомендаций 2002 г. рекомендательны; региональные нормы — нет, но их соблюдение проверяет не Роспотребнадзор, а государственный контроль в сфере социального обслуживания: для организаций субъекта — Роструд, для негосударственных поставщиков — орган субъекта (п. 8.3–8.4; толкование). Вопрос «почему сегодня два вторых» поэтому не относится к предмету санитарного надзора; вопросы «где ТТК на второе Б», «где проба» и «сколько часов оно стоит на линии» — относятся.

2.7.4 Подп. 5 п. 56: кто раздаёт пищу

Подп. 5 п. 56 СанПиН 4282-26 требует, чтобы раздачу пищевой продукции пациентам медицинских организаций производили назначенные ответственные лица; иной персонал к раздаче не допускается [3]. Для организаций социального обслуживания прямого аналога нет; общий запрет п. 32 касается привлечения к приготовлению, порционированию и раздаче «посторонних лиц, включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности» [3]. Если вариативное меню организуется с раздачей в отделениях силами младшего медицинского персонала или помощников по уходу, раздача должна быть включена в их должностные инструкции (толкование; практическое следствие разобрано в п. 7.5).

2.8 Лечебное питание: граница компетенций

СанПиН требует организовать в стационарной организации социального обслуживания «диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям» [3]. Как это сделать, санитарные правила не говорят. Номенклатура стандартных диет и порядок лечебного питания установлены актами Минздрава России для медицинских организаций: приказ от 05.08.2003 № 330 (с изменениями, последнее — приказ от 19.02.2024 № 70н), приказ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания», приказ от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием» [3, сноска 13 и 23; 45–47].

Применимость этих актов к организациям социального обслуживания прямо не установлена. Учреждение с медицинской лицензией и врачом в штате фактически применяет их по аналогии; учреждение без врача — нет. Первая редакция обзора назвала это «недостаточной связностью социального и медицинского регулирования» [1], и формулировка точна. Правило для вариативного меню (толкование): кухня не назначает и не отменяет диету, житель с назначенной диетой выбирает внутри неё. Какие диеты и консистенции кому назначать, доклад не рассматривает — это решает врач.

Клинические рекомендации «Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста» (Российская ассоциация геронтологов и гериатров, 2020; опубликованы в 2021 г.) предусматривают активный скрининг недостаточности питания у пожилых [48]. Для социального учреждения это ориентир организации медицинской части, а не норма кухни.

2.9 Закон № 3185-1 и питание в ПНИ

Для ПНИ к перечисленному добавляется Закон № 3185-1 [24]:

- ст. 5 ч. 2 — лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства (общая гарантия; материалы семинара выводят из неё недопустимость лишения еды как меры воздействия [21] — **толкование**);
- ст. 37 ч. 2 в силу ст. 43 — право исполнять религиозные обряды и соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, если это не нарушает внутренний распорядок — **норма**;
- ст. 37 ч. 3 — временные ограничения прав, в том числе на получение посылок и на приобретение предметов первой необходимости, допускаются решением заведующего отделением или главного врача по рекомендации лечащего врача; порядок устанавливается Правительством РФ — **норма** (применимость ч. 3 к жителям ПНИ сомнительна, поскольку ст. 43 отсылает только к ч. 2 и 4 ст. 37; это **толкование**).

Последний пункт касается продуктовых передач. Перечни продуктов, «запрещённых к передаче» в ПНИ, которые публикуют учреждения [49], — локальные формы. Их законность зависит от того, обоснованы ли запреты санитарными или медицинскими причинами; ст. 43 Закона № 3185-1 не распространяет на жителей ПНИ ограничения ч. 3 ст. 37 (толкование).

Для поста следствие прямое: постный вариант блюда — не «вариативность по желанию кухни», а условие осуществления права, закреплённого законом. Если житель имеет медицинские назначения, соблюдение поста согласуется с врачом; отказ от поста — такое же право в любой день.

2.10 Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ

Питание зависит от закупки сильнее, чем от рецептуры: спецификация решает, окажется ли на складе второй продукт группы. Государственное бюджетное учреждение закупает по 44-ФЗ [50]. Автономное учреждение относится к заказчиком по 223-ФЗ (п. 1 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ) и закупает по своему положению о закупке; при размещении положения применяется 44-ФЗ [51]. Положения 44-ФЗ распространяются на закупки автономного учреждения за счёт субсидий на капитальные вложения (ч. 4 ст. 15 44-ФЗ) [50]. Применимость 44-ФЗ к закупкам автономного учреждения за счёт субсидии на выполнение государственного задания — предмет многолетнего спора; Минфин России разъяснял порядок использования автономными учреждениями бюджетных средств в письме от 29.12.2014 № 02-02-08/68298 [52]. В 2025–2026 гг. спор получил судебную иллюстрацию, которую отраслевая печать пересказывает шире, чем она есть.

В деле № А73-20917/2024 краевое государственное автономное учреждение заключило по 223-ФЗ без конкурентных процедур договор на авиационные услуги для тушения лесных пожаров на территории Хабаровского края за счёт субсидии на выполнение государственного задания; Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 05.12.2025 № Ф03-3556/25 согласился с признанием договора недействительным [53]. Мотив суда — не источник денег, а цель закупки: она «произведена автономным учреждением во исполнение государственного задания и по поручению государственного органа для обеспечения публичного интереса и удовлетворения государственных нужд... а не нужд учреждения»; 223-ФЗ применим, «когда закупка осуществляется для нужд самих поименованных в данном законе юридических лиц, в том числе автономных учреждений» [53]. Ход дела по тексту постановления таков: решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.06.2025 иск прокурора удовлетворён; постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2025 решение отменено и в иске отказано; кассационная инстанция по жалобе прокурора отменила апелляционное постановление [53].

Отраслевой блог сообщает, что определением Верховного Суда РФ от 28.01.2026 № 303-ЭС25-15393 в передаче кассационной жалобы учреждения отказано, и подаёт это как «окончательную точку» в споре, называя ключевым критерием источник финансирования [54]. Пересказ блога расходится с текстом постановления округа в проверяемых деталях: предмет договора назван «поставкой товаров» (в деле — авиационные услуги по тушению пожаров), а апелляционная инстанция описана как поддержавшая первую (в деле она её отменила) [53, 54]. Под тем же номером 303-ЭС25-15393 в открытой базе судебных актов найдено только определение судьи Верховного Суда от 29.12.2025 об отсрочке учреждению уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы до окончания производства по ней [55]; определения по существу жалобы в открытых источниках найти не удалось, и цитата из него в блоге не проверяема. Юридический комментарий ГАРАНТ.РУ к тому же постановлению делает более узкий вывод: если в рамках задания учреждение оказывает услуги конкретным заявителям, закупка удовлетворяет нужды самого учреждения и вопросов с применением 223-ФЗ «не возникало» бы; 44-ФЗ обязателен, когда учреждению поручена реализация полномочий органа власти в интересах неограниченного круга лиц [56].

Для стационарной организации социального обслуживания это различие решает дело (толкование). Продукты для жителей закупаются, чтобы оказать социальную услугу конкретным получателям по их индивидуальным программам, то есть для нужд самого учреждения как поставщика социальных услуг, а не для реализации полномочий учредителя в интересах неопределённого круга лиц. По логике постановления № Ф03-3556/25 такая закупка автономного учреждения остаётся в контуре 223-ФЗ. Иначе может обстоять дело с закупками, которые учредитель поручает учреждению сверх его уставной деятельности (оборудование по региональной программе, мероприятия для населения района): здесь риск переквалификации в 44-ФЗ реален. Это толкование: оно не заменяет правовой экспертизы учредителя и не опирается на определение Верховного Суда по существу жалобы, текст которого не найден.

В Санкт-Петербурге оба контура соседствуют в одной отрасли: ДСО «Серафимовский» (автономное учреждение) закупает по 223-ФЗ, ДСО «Тесовый берег» (бюджетное учреждение) — по 44-ФЗ; пример последнего — извещение № 0372200070825000244 от 24.11.2025 об открытом конкурсе на поставку продуктов питания [57]. Сравнение закупочных решений для вариативного меню — в п. 7.7.

2.11 Ответственность

Санитарная. Общий состав — ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия); специальный — ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) [58]. Первая редакция обзора называет ст. 6.3 [1], доклад «Не просто накормить» — ст. 6.6 [20]. Противоречия здесь нет — это соотношение общей и специальной нормы: для нарушений при организации питания применяется ст. 6.6. Прокуратура применяла её к учреждениям социального обслуживания, в том числе к социально-реабилитационному центру в Кашине [59]. Верховный Суд РФ в постановлении от 21.02.2019 № 11-АД19-4 переквалифицировал нарушение с ст. 6.6 на ст. 6.7 КоАП применительно к организации, где специальной была норма об условиях воспитания и обучения [60]; выбор состава зависит от вида организации.

Антимонопольная. Сырьё для социальных учреждений — сфера с публичными картельными делами: ФАС России в 2024 г. сообщила о картеле на 543 торгах поставки социально значимых продуктов на сумму 4,7 млрд руб. [61]; УФАС по Челябинской области в 2025 г. — о картеле на 27 тендерах школьного питания со штрафом 5,1 млн руб. [62]. Вывод для вариативного меню узок: избыточно детализированная спецификация, написанная «под второе блюдо», сама может ограничить конкуренцию; спецификация строится по группам продуктов, а не по поставщику (толкование).

2.12 Итог по федеральному уровню

Утверждение	Класс	Основание
Питание в стационаре — не менее 3 раз в день, включая диетическое по медицинским показаниям	Норма	Подп. 11 п. 56 СанПиН 4282-26 [3]
Нормы питания утверждает субъект	Норма	Ст. 8 442-ФЗ [22]
Федеральные продуктовые нормы	Рекомендация	Приказ № 520н [30]; рекомендации 2002 г. [29]
Число вариантов блюда не ограничено	Толкование	Отсутствие норм в СанПиН 3590-20 и 4282-26 [2, 3]
Обязанность предоставлять выбор блюда	Отсутствует	Ни в одном проанализированном федеральном акте
Таблица замен СанПиН	Норма для детских организаций; для взрослых — ориентир по аналогии	Подп. 4 п. 59, прил. 11 СанПиН 4282-26 [3]
Нормы взаимозаменяемости для социального обслуживания взрослых	Рекомендация	Прил. 7 к постановлению № 12 [29]
ТТК на каждый вариант с тем же наименованием	Норма	П. 11 СанПиН 4282-26 [3]
Не более 3 ч на раздаче для блюд, требующих разогрева	Норма	П. 32 СанПиН 4282-26 [3]
Право жителя ПНИ соблюдать пост	Норма	Ст. 37 ч. 2, ст. 43 Закона № 3185-1 [24]
Ограничение платы 75 % среднедушевого дохода	Норма	Ч. 4 ст. 32 442-ФЗ [22]; п. 35 приказа № 935н [23]

3 Региональные нормы питания

3.1 Архитектура регионального регулирования

С 1 января 2015 г. каждый субъект Российской Федерации живёт по собственным актам о социальном обслуживании. Первая редакция обзора описала их типовую структуру в четыре уровня: закон субъекта о социальном обслуживании; перечень социальных услуг; нормы питания (суточные продуктовые наборы в граммах брутто и нетто); порядки, стандарты и тарифы [1]. Для нашей темы главный уровень — нормы питания: они определяют, из чего кухня может приготовить два варианта.

Ни один из проанализированных региональных актов не закрепляет права жителя на выбор блюда и не устанавливает числа вариантов [1]. Во второй редакции этот вывод проверен по текстам актов Санкт-Петербурга, Новосибирской и Нижегородской областей, Красноярского края, Ленинградской области и ХМАО — Югры, а для Москвы — по открытой части приказа № 228 [31, 41–43, 63–65]; для остальных субъектов он взят из первой редакции. Вариативное меню в России, следовательно, везде остаётся организационной инициативой учреждения: нормы его допускают, но не предписывают (толкование).

Первая редакция обзора предложила классификацию норм по степени дифференциации: «многовариантная» (наборы различаются по типу учреждения и по состоянию здоровья, пример — Санкт-Петербург), «типовая» (только по типу учреждения, пример — Псковская область) и «укрупнённая» (единый набор с оговорками о замене по медицинским показаниям) [1]. Классификация полезна, но вывод, который из неё делали, — «чем богаче нормативный ассортимент, тем шире легальное пространство выбора» — требует поправки. Дифференциация по диагнозам расширяет пространство персонализации, а не выбора: житель с диабетом получает другой набор, но не получает права выбирать между наборами. Пространство выбора создаёт другое свойство нормы: позиции сформулированы группами продуктов, а не конкретными продуктами (толкование, см. п. 2.5).

3.2 Санкт-Петербург: постановление № 1284

3.2.1 Реквизиты и структура

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» вступило в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015; изменено постановлениями от 27.07.2017 № 616, от 19.12.2019 № 929 и от 27.06.2022 № 561 [31, 66]. Постановлением № 929 приложение изложено в новой редакции с 01.01.2020 [66]; постановлением № 561 изменены, в частности, нормы по крупам и мясу (отметки «в ред. Постановления... от 27.06.2022 N 561» у соответствующих строк) [31].

Приложение состоит из нескольких самостоятельных норм [31]:

1. нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме — в четырёх столбцах: учреждения, кроме ПНИ; ПНИ; лица с сахарным диабетом; лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
2. нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов в ПНИ **без смеси белковой композитной сухой** — отдельная таблица;
3. нормы питания беременных женщин и кормящих матерей;
4. нормы питания детей первого года жизни, проживающих с матерями;
5. нормы питания детей от 1 года до 18 лет;
6. нормы специализированного лечебного энтерального питания для получателей от 4 лет, в том числе на длительном зондовом питании, с индивидуальным расчётом по формуле действительного расхода энергии.

Для полустационарной формы установлена структура рациона в процентах от стационарной нормы: завтрак — 30 %, обед — 40 %, полдник — 10 %, ужин — 20 % [31].

3.2.2 Две нормы для ПНИ

Первая редакция обзора привела нормы для ПНИ по столбцу таблицы 1 и указала, что ПНИ-норма Санкт-Петербурга включает 27 г СБКС [1]. Это верно, но неполно: в постановлении есть вторая, самостоятельная норма для ПНИ — без СБКС (таблица 2). Сравнение двух ПНИ-норм показывает, чем региональный нормотворец «заменил» 27 г белковой смеси [31]:

Продукт (нетто, г/сут)	ПНИ, табл. 1 (с СБКС 27 г)	ПНИ, табл. 2 (без СБКС)	Разница
Хлеб ржаной	150	200	+50
Хлеб пшеничный	200	250	+50
Крупы, бобовые	49,6	70	+20,4
Мясо (говядина, свинина)	70,5	85,2	+14,7
Птица потрошёная	36,5	35	-1,5
Масло сливочное	20	23	+3
Масло растительное	20	23	+3
Маргарин	10	4	-6
Овощи, картофель, фрукты, молоко, творог, рыба	без изменений	без изменений	0

Постановление не указывает, в каких случаях применяется каждая из двух норм (проверено по тексту [31]). Наиболее естественное прочтение (толкование): учреждение вправе обеспечивать жителей ПНИ либо по норме с СБКС, либо по норме без неё, компенсируя белковую смесь хлебом, крупами и мясом. Для вариативного

меню это прецедент: региональный акт сам содержит пару эквивалентных наборов. Выбирает между ними учреждение, а не житель, но логика «два пути к одной пищевой ценности» заложена в саму норму.

3.2.3 Петербургская норма и федеральная рекомендация

Если положить общую норму Санкт-Петербурга (столбец «учреждения, кроме ПНИ») рядом с рекомендуемыми нормами приказа № 520н, видно, что петербургская норма не выведена из федеральной: она старше (принята в 2014 г., последняя редакция — от 27.06.2022; приказ № 520н издан 13.09.2022) и устроена иначе [30, 31].

Продукт (нетто, г/сут на человека)	Приказ № 520н, 18+ [30]	СПб № 1284, кроме ПНИ [31]	СПб № 1284, ПНИ (табл. 1) [31]
Хлеб ржаной	150	150	150
Хлеб пшеничный	150	100	200
Мука пшеничная	15	45	45
Макаронные изделия	20	20	25
Крупы, бобовые	80	80	49,6
Картофель	200	168	268
Овощи (все группы, включая зелень, солёные и консервированные)	394,5 ¹	318	380
Фрукты свежие	150	200	100
Соки	100 мл	60	60
Мясо	90	90	70,5
Птица	22,2	40	36,5
Колбаса, сосиски	12	25	25
Рыба, рыбопродукты	32,5	41,8	46,7
Творог	20	40	50
Сыр	15	14	9,3
Яйцо	½ шт./сут (3,5 шт./нед)	4 шт./нед	4 шт./нед
Молоко	200 мл	200	200
Кисломолочные продукты	121 мл	200	200
Масло сливочное	20	20	20
Масло растительное	20 мл	20	20
Сметана	15	10	15
Сахар и кондитерские изделия	50 (вместе)	57 + 15 = 72	57 + 15 = 72
Соль	8	10	10
СБКС	27 — по медицинским показаниям	27 — в общей норме	27 — в общей норме

Продукт (нетто, г/сут на человека)	Приказ № 520н, 18+ [30]	СПб № 1284, кроме ПНИ [31]	СПб № 1284, ПНИ (табл. 1) [31]
Витаминно-минеральные комплексы	50–100 % физиол. нормы — по медицинским показаниям	1 драже 3 раза в неделю	1 драже 3 раза в неделю

¹ Сумма строк приказа № 520н: овощи свежие 340 + солёные и маринованные 15 + зелень 14,8 + консервированные 24,7 (иллюстративная арифметика автора; в приказе группы приведены раздельно).

Сопоставление даёт три наблюдения.

Первое. По ряду позиций петербургская норма щедрее федеральной рекомендации: птица (40 против 22,2 г), творог (40 против 20 г), кисломолочные продукты (200 против 121), рыба (41,8 против 32,5), фрукты (200 против 150). По другим — скромнее: картофель (168 против 200), овощи (318 против 394,5), соки (60 против 100). Запас у выбора, построенного на петербургской норме, — именно в белковых позициях, и это облегчает пары «мясо — птица — рыба» (толкование) [30, 31].

Второе. Специализированные продукты (СБКС и витаминно-минеральные комплексы) в Санкт-Петербурге входят в общую норму каждого проживающего, а в федеральной рекомендации — только по медицинским показаниям [30, 31]. Это решение регионального нормотворца, а не противоречие: регион вправе установить набор шире федерального. Но оно рождает практический вопрос, который решает врач, а не кухня: вводить ли смесь в блюда всем или выдавать по назначению.

Третье. Пункты, сформулированные группами («крупы, бобовые» 80 г; «овощи свежие, овощи солёные и маринованные, овощи консервированные, зелень» 318 г; «говядина, свинина» 90 г), оставляют внутри группы свободу выбора конкретного продукта. Две каши из одной группы, два салата из одной группы овощей, котлета из говядины и тефтели из свинины — варианты, не требующие пересчёта нормы. Пары между группами (мясо — рыба, картофель — крупа) требуют таблицы замен, которой в постановлении № 1284 нет (п. 2.6) [31].

3.2.4 Порядок и тарифы

Петербургские нормы питания работают в связке с двумя другими актами. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 утверждены порядки предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, в том числе в стационарной форме [67]. Тарифы на социальные услуги ежегодно утверждает Комитет по социальной политике: на 2025 г. — распоряжением от 13.12.2024 № 1366-р, на 2026 г. — распоряжением от 15.12.2025 № 1155-р [68, 69].

Тарифы на услугу «обеспечение питанием согласно утверждённым нормативам» в стационарной форме для совершеннолетних зеркальны нормам постановления № 1284 и разбиты по тем же категориям [68, 69]. Тарифы 2026 г. утверждены распоряжением № 1155-р во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 о порядке утверждения тарифов на основании подушевых нормативов финансирования и распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 29.05.2025 № 92-р о подушевых нормативах на

2026–2028 гг. [69]. Распоряжение опубликовано в виде графического образа; значения ниже прочитаны распознаванием текста и сверены визуально по изображению страницы.

Категория (стационарная форма, 18+)	2025 г., руб. в день [68]	2026 г., руб. в день [69]	Изменение, % (иллюстративная арифметика)
Кроме ПНИ (в 2026 г. — кроме ПНИ и ДСО)	560,87	581,33	+3,6
Кроме ПНИ и ДСО, нормы без СБКС	—	539,74	новая категория
ПНИ (в 2026 г. — ПНИ и ДСО)	571,63	574,43	+0,5
ПНИ (в 2026 г. — ПНИ и ДСО), нормы без СБКС	480,86	531,22	+10,5
Сахарный диабет	549,77	592,32	+7,7
Заболевания ЖКТ	423,36	466,22	+10,1

Для вариативного меню в таблице важны четыре обстоятельства.

Первая. Тариф рассчитан на норму, а не на меню; он не содержит составляющей на организацию выбора ни в 2025, ни в 2026 г. [68, 69].

Вторая. Цена решения «27 г белковой смеси или компенсация хлебом, крупами и мясом» за год изменилась почти вдвое: разница между двумя ПНИ-тарифами составляла 90,77 руб. в день в 2025 г. и 43,21 руб. в 2026 г.; для учреждений, кроме ПНИ, в 2026 г. появилась собственная пара тарифов с разницей 41,59 руб. (иллюстративная арифметика: 571,63 – 480,86; 574,43 – 531,22; 581,33 – 539,74) [68, 69]. Сами нормы постановления № 1284 за этот период не менялись (последняя редакция — 27.06.2022 [31]). Значит, изменился расчёт стоимости набора (цены продуктов, методика подушевого норматива), а не содержание нормы; документы, по которым это можно проверить, не опубликованы.

Третья. В 2025 г. тариф для ПНИ был выше общего (571,63 против 560,87), в 2026 г. соотношение обратное (574,43 против 581,33) [68, 69]. При том что ПНИ-норма по ряду позиций больше общей (хлеб пшеничный 200 против 100 г, картофель 268 против 168 г, творог 50 против 40 г [31]), а по другим меньше (мясо 70,5 против 90 г, фрукты 100 против 200 г), смена знака разницы при неизменных нормах может отражать изменение цен отдельных групп продуктов или методики расчёта; различить эти причины по опубликованным документам нельзя. Это наблюдение, а не вывод о методике: методика расчёта душевых нормативов в доступных источниках не раскрыта.

Четвёртая. Рост тарифа ПНИ на 0,5 % за год — ориентир для учреждения, которое рассчитывает расширить выбор за счёт продуктового бюджета: в 2026 г. такого запаса в тарифе нет, и выбор в ПНИ и ДСО Санкт-Петербурга возможен только как перераспределение внутри нормы (сценарии 1, 2 и 11 гл. 7) (толкование).

3.2.5 Что первая редакция сообщала о петербургской практике

Первая редакция обзора называла практику петербургских учреждений «циклическими меню с альтернативными позициями» и ссылалась на пилотный проект «Система свободного выбора „Вариативное меню“» по данным доклада Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 г. [1, 70]. Проект, о котором говорит этот доклад, касается школьного питания в образовательных организациях и к социальному обслуживанию взрослых отношения не имеет. Сведения о вариативном меню в ДСО «Серафимовский», опубликованные Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 22.07.2025 [19], в первой редакции не использованы.

3.3 Москва

Нормы питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания Москвы утверждены приказом Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от 22.03.2021 № 228, вступившим в силу с 01.04.2021 [63]. Приказ утверждает шесть приложений: нормы для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных организациях; для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации; для детей первого года жизни; для женщин в кризисных центрах; для организаций социально-медицинской реабилитации; для полустационарной формы [63].

Для нашей темы важнее приложений п. 2.1 самого приказа: «При разработке и применении циклических меню необходимо соблюдать установленные нормы, в соответствии с возрастом и контингентом питающихся. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам» [63]. Это единственная найденная в ходе подготовки доклада региональная норма, которая для совершеннолетних получателей социальных услуг прямо разрешает оценивать выполнение норм по среднему за неделю. Для вариативного меню она важна дважды: подтверждает, что исходная модель регионального нормотворца — циклическое меню, и даёт законную опору недельному контролю, без которого выбор между блюдами разной калорийности не учесть (толкование). Формулировка касается калорийности по приёмам пищи, а не групп продуктов, поэтому вопрос о групповом балансе при замене мяса рыбой (сценарий 1 гл. 7) она не снимает. Остальная часть текста приказа (приложения, положения о замене) в открытой версии справочной системы недоступна и не сверялась; утверждение первой редакции о замене «по нормам взаимозаменяемости» [1] остаётся непроверенным.

В правовом навигаторе фонда «Обнажённые сердца» московские нормы для ПНИ цитируются по другому акту — приказу Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 24.12.2014 № 1068, с нормой «хлеб пшеничный, в т.ч. мелкоштучные выпечные изделия 175, хлеб ржано-пшеничный 150» г в сутки [71]. Был ли приказ № 1068 отменён или заменён приказом № 228, по доступным источникам установить не удалось (п. 9, противоречие 24).

Первая редакция обзора описывала московскую практику как «циклическое меню с элементами выбора», дегустации и опросы удовлетворённости в пансионатах [1]. Источника у этой характеристики в обзоре нет, и вторая редакция не повторяет её как факт. Повторный поиск публичных описаний вариативного меню в московских государственных организациях социального обслуживания (сайты учреждений и Департамента, отраслевые СМИ) в ходе подготовки этой редакции результата не дал.

3.4 Свердловская область

Нормы питания утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП, заменившим постановление № 1037-ПП [40]. По данным первой редакции обзора, акт включает СБКС (27 г) и витаминно-минеральные комплексы в суточный набор и устанавливает замену продуктов по таблице приложения № 11 к СанПиН 3590-20 со ссылками на весь действовавший массив санитарных правил [1]. Если пересказ точен, свердловский акт — единственный из проанализированных, где детская таблица замен для взрослых возведена в региональную норму. После 01.09.2026 ссылки акта на СанПиН 3590-20 требуют актуализации на СанПиН 4282-26 (таблица замен в новом СанПиН сохранила номер приложения — 11) [3].

3.5 Нижегородская область

Нормы питания утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 20.10.2014 № 709; ведомственным актом в сфере социального обслуживания назван приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214 [72]. По описанию первой редакции, наборы дифференцированы по видам учреждений; диетическое питание — по медицинским показаниям с заменой по нормам взаимозаменяемости [1]. Утверждение первой редакции о том, что «на уровне учреждений... элементы выбора блюд внедряются по инициативе учреждений», источником не подкреплено и здесь не воспроизводится как факт.

Действующая редакция норм для взрослых установлена постановлением Правительства Нижегородской области от 30.08.2019 № 617, которое изложило нормы № 709 заново и вступило в силу 01.01.2020 [64]. Наборы для домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов-интернатов и ПНИ выражены в граммах нетто: в общем наборе говядина I категории — 100 г, куры — 25 г, рыба (филе) — 60 г, колбасные изделия — 12 г, картофель — от 200 до 250 г в зависимости от сезона, прочие овощи — 290 г, фрукты — 150 г [64]. Положений о выборе блюд и о замене продуктов текст не содержит (проверено по тексту); брутто приводится только в наборах для детей, с пояснением, что масса брутто рассчитана на норму отходов 25 % [64]. Вносились ли изменения после 2020 г., установить не удалось.

Публичных описаний вариативного меню в нижегородских учреждениях найти не удалось. Нашёлся другой документ, для доклада не менее полезный, — опубликованное на сайте положение об организации питания ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (учредитель по данным страницы — министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области; дата

утверждения положения на странице не указана) [44]. Он подробно описывает, как устроено единое меню в типичном доме-интернате, — ту исходную точку, от которой отсчитывается любой выбор:

- сводное 14-дневное меню и картотека блюд утверждаются директором на основе среднесуточного набора продуктов; замена продуктов при их отсутствии — по таблицам взаимозаменяемости и замены по белкам и углеводам, утверждённым самим положением [44];
- ответственный за организацию питания — медицинская диетическая сестра; суточный расход продуктов ведётся «строго в соответствии со среднесуточными наборами» [44];
- документальная цепочка: порционник по форме № 1-84 (дежурная медицинская сестра, ежедневно) → сводные сведения о численности → меню-раскладка по форме 0504202 на следующий день (подписывают диетическая сестра, бухгалтер и повар, утверждает директор) → требование на выдачу продуктов со склада по форме № 45-МЗ → карточка-раскладка на каждое блюдо по форме № 1-85 [44];
- режим: четырёхразовое питание и второй ужин, по две смены на каждый приём пищи (завтрак 8:30 и 9:00, обед 12:30 и 13:00, полдник 15:00 и 15:30, ужин 18:00 и 18:30, второй ужин 20:00) [44];
- контроль: проверка готовой пищи директором раз в месяц и ежедневно старшей и диетической сёстрами; порционные блюда взвешиваются по 10 порций, допустимое отклонение средней массы — не более 3 %; суточная проба — «от каждой партии приготовленных блюд», отдельно каждое блюдо, 48 часов при +2...+6 °С; раздача — не позднее двух часов после приготовления [44].

Практический вывод для вариативного меню (толкование): в учреждении с такой документальной цепочкой выбор меняет не одну бумагу, а все звенья сразу. Порционник должен считать не только численность, но и распределение по вариантам; меню-раскладка — содержать оба варианта с ожидаемым числом порций; требование на склад — суммировать продукты обоих вариантов; бракераж и суточная проба — вестись по каждому варианту (по смыслу положения, где проба отбирается от каждой партии, это требование уже выполнено, если вариант — самостоятельная партия). Сценарий 13 гл. 7 разбирает эту цепочку как пакет документов.

3.6 Омская область

Нормы утверждены приказом от 11.11.2014 № 171-п [73]. По данным первой редакции, акт отсылает к нормам взаимозаменяемости методических рекомендаций 2002 г., к СанПиН 3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, а диетическое питание связывает со ст. 25.5 29-ФЗ и ст. 39 323-ФЗ [1]. Омские учреждения публикуют на сайтах сведения о питании и перечни продуктов, ограниченных к передаче [49]. Опубликованные меню и правила нужны вариативному меню в любом регионе: житель и семья должны знать, из чего выбирают.

3.7 Псковская область

Нормы питания утверждены приказом Комитета по социальной защите населения Псковской области от 14.07.2020 № 206 [74]. Наборы дифференцированы по категориям учреждений (дома-интернаты, дома ветеранов, ПНИ), диетическое питание организуется со ссылкой на приказы Минздрава России № 395н и № 330 [1]. Псковский акт показывает общую закономерность: диетологическую логику региональные нормы берут из здравоохранения.

3.8 Новосибирская область

Из Новосибирской области происходит большая часть публичных сообщений о вариативном питании (п. 4.2–4.4), поэтому её норму стоит прочитать внимательно. Нормы утверждены приказом министерства социального развития Новосибирской области от 06.10.2014 № 1164; приложения изложены в новой редакции приказом министерства труда и социального развития от 25.05.2023 № 769-НПА, преамбула которого ссылается на приказы Минтруда России № 520н и № 519н и на СанПиН 3590-20 [43]. Таблица 1 устанавливает нормы для совершеннолетних в стационарной форме в граммах **брутто** по четырём типам организаций: дома-интернаты общего типа и специальные (вместе с геронтологическими центрами и рядом других), психоневрологические интернаты, комплексные социально-оздоровительные центры и дома-интернаты (отделения) милосердия [43].

Для домов-интернатов общего типа и ПНИ нормы почти совпадают: говядина 110 г, птица 45 г, рыба 60 г, творог 21 г, кисломолочные напитки 125 г, молоко 211 г, картофель 300 г, овощи свежие 424,2 г, фрукты 150 г; различаются хлеб пшеничный (150 и 200 г) и сахар с кондитерскими изделиями (60 и 70 г) [43]. СБКС (27 г) включена в нормы этих типов учреждений со сноской «по медицинским показаниям»; витаминно-минеральные комплексы — 50–100 % физиологической нормы [43]. Тем самым новосибирская норма воспроизводит федеральную конструкцию № 520н (смесь — по показаниям), а не петербургскую (смесь — в общей норме).

Показательно: в регионе с самой развитой практикой выбора норма ни словом не упоминает ни выбор, ни варианты блюд, ни замену продуктов (проверено по тексту [43]). Новосибирские учреждения строили вариативное питание на той же нормативной основе, что и все остальные (толкование).

3.9 Красноярский край

Нормы питания в краевых учреждениях социального обслуживания утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п; текст в редакции от 14.10.2021 № 730-п (изменения 2015, 2016, 2018, 2019 и двумя постановлениями 2021 г.) воспроизведён на сайте одного из краевых учреждений [41]. Раздел 1 устанавливает норму для домов-интернатов, отделений комплексных центров и специальных домов-интернатов; примечание прямо называет её «нормы расхода (закладки) продуктов питания массой брутто» [41]. Основные позиции: хлеб ржаной и пшеничный по 150 г, крупы и бобовые 70 г, макаронные изделия 20 г, картофель

250 г, овощи 365 г, фрукты 200 г, соки 60 г, кисломолочные продукты 200 г, молоко 200 г, творог 40 г, сыр 15 г, говядина 80 г, колбасные изделия 25 г, куры 45 г, рыба 76 г, яйцо 4 шт. в неделю, сахар 57 г, поливитамины — одно драже три раза в неделю [41]. СБКС в норме нет; отдельная норма установлена для лиц с сахарным диабетом (в докладе не рассматривается).

После этой редакции акт менялся ещё дважды [75]. Постановление от 06.02.2024 № 74-п (в силу с 09.02.2024) уточнило наименование акта и изложило преамбулу заново — теперь она ссылается на приказы Минтруда России № 519н и № 520н, приказы Минздрава России № 330 и № 395н и на СанПиН 3590-20. Постановление от 14.10.2025 № 892-п (в силу с 01.01.2026) переименовало разделы: раздел 1 теперь относится к «пансионатам, отделениям стационарного социального обслуживания комплексных центров (центров) социального обслуживания населения, специальным домам-интернатам», раздел 2 — к «домам социального обслуживания, социально-реабилитационным центрам» [75]. Раздел 2, в публичной редакции 2016 г. адресованный психоневрологическим интернатам, содержит для них отдельную, более крупную норму брутто: хлеб ржаной 200 г, пшеничный 250 г, картофель 400 г, овощи 420 г, говядина 100 г, куры 40 г, рыба 85 г, творог 50 г, фрукты 100 г [75]. Меняли ли поправки 2024–2025 гг. сами граммы, по доступным фрагментам установить не удалось; числа раздела 1 выше даны по редакции 2021 г. и совпадают с публичной редакцией 2016 г.

На той же странице учреждение-публикатор описывает собственную организацию питания: четырёхразовое питание, обеденный зал на 101 посадочное место, на пищеблоке четыре повара и четыре официанта, меню на день вывешивается на стенде у входа в столовую [41]. Так учреждение само раскрывает минимум сведений о питании; о выборе блюд в них ничего нет.

3.10 Ленинградская область

В материалах семинара нормы Ленинградской области названы «постановлением Правительства Ленинградской области № 458» [20]. Такого акта найти не удалось. Действующие нормы питания совершеннолетних получателей социальных услуг утверждены приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 30.12.2021 № 04-58 (приложение 3), изданным на основании ст. 8 442-ФЗ и областного закона от 30.10.2014 № 72-оз; по данным поисковых систем приказ изменялся в 2022 и 2023 гг., а 04.08.2025 в него внесены изменения приказом № 04-81 (опубликован 06.08.2025); тексты изменений не прочитаны [42, 76]. Расхождение реквизитов вынесено в гл. 9 (противоречие 31).

Ленинградская норма — единственная из прочитанных, где каждая позиция дана одновременно брутто и нетто: говядина 127,7/90 г, птица 25/22,2 г, рыба 59,1/32,5 г, творог 20,4/20 г, кисломолочные напитки 125/121 г, картофель 300/200 г, овощи свежие 366,7/290 г с разбивкой по видам (свёкла, морковь, капуста, лук, огурцы и помидоры, прочие), фрукты 150 г, соки 100 г [42]. СБКС (27 г) и витаминно-минеральные комплексы (50–100 %) включены в норму стационарного обслуживания без оговорки о медицинских показаниях [42]. Значения нетто почти совпадают с приказом № 520н (говядина 90, птица 22,2, рыба 32,5, творог 20, кисломолочные 121 г), хотя ле-

нинградский приказ издан раньше, 30.12.2021, а № 520н — 13.09.2022 [30, 42]. Вероятное объяснение — общий источник обоих актов в более ранней федеральной рекомендации; это предположение, текст предшествующего федерального акта для доклада не сверялся.

3.11 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Нормы установлены постановлением Правительства ХМАО — Югры от 22.08.2014 № 306-п; прочитана редакция постановления от 06.09.2014 № 327-п [65]. Нормы для совершеннолетних даны нетто: картофель 200 г, овощи свежие 290 г, фрукты 200 г, соки 100 г, говядина 90 г, птица 22,2 г, колбасные изделия 12 г, рыба 32,5 г, творог 20 г, кисломолочные напитки 121 г, сахар и кондитерские изделия 50 г, СБКС 27 г, витаминно-минеральные комплексы 50–100 % [65]. Изменения 2024 г., найденные поиском, касаются норм для несовершеннолетних; действующая редакция для совершеннолетних не проверена.

То, что эти числа совпадают с ленинградскими нетто и с № 520н уже в 2014 г., подкрепляет предположение об общем федеральном источнике, предшествовавшем № 520н (толкование). Отличие — фрукты: 200 г в ХМАО против 150 г в Ленинградской области и в № 520н [30, 42, 65].

3.12 Брутто и нетто: почему региональные нормы нельзя сравнивать напрямую

Из прочитанных актов два (Красноярский край, Новосибирская область) выражены в брутто, три (Санкт-Петербург, ХМАО, Нижегородская область) — в нетто, один (Ленинградская область) — в обеих величинах [31, 41–43, 64, 65]. Прямое сопоставление «говядина 110 г в Новосибирской области против 90 г по № 520н» ошибочно: первая цифра — масса закладки до очистки и обвалки, вторая — масса после. Ленинградская норма даёт коэффициенты перевода, заложенные самим нормотворцем, и по ним брутто-нормы можно ориентировочно привести к нетто.

Продукт	Коэффициент нетто/брутто по ЛО [42]	НСО, брутто [43]	НСО, ≈ нетто	Красноярский край, брутто [41]	Красноярский край, ≈ нетто	СПб, кроме ПНИ, нетто [31]	№ 520н, нетто [30]
Говядина (мясо)	0,705	110	77,5	80	56,4	90	90
Птица	0,888	45	40,0	45	40,0	40	22,2
Рыба	0,550	60	33,0	76	41,8	41,8	32,5
Картофель	0,667	300	200,0	250	166,7	168	200
Овощи свежие	0,791	424,2	335,5	365	288,7	318 ¹	340
Творог	0,980	21	20,6	40	39,2	40	20
Кисломолочные	0,968	125	121,0	200	193,6	200	121

¹ В Санкт-Петербурге — все группы овощей вместе (п. 3.2.3).

Пересчёт — иллюстративная арифметика автора: коэффициенты ленинградского приказа зависят от вида сырья и способа обработки, и другой нормотворец мог закладывать другие. С этой оговоркой таблица даёт три наблюдения. Во-первых, красноярская норма после пересчёта почти совпадает с петербургской по рыбе (41,8 г), птице (40 г), картофелю (≈ 167 и 168 г), творогу и кисломолочным продуктам, но существенно уступает ей по мясу (≈ 56 против 90 г). Во-вторых, новосибирская норма после пересчёта близка к № 520н по рыбе, картофелю и молочным продуктам, по мясу ниже (≈ 78 против 90 г), по птице выше. В-третьих, «запас в белковых позициях», который облегчает пары «мясо — птица — рыба» (п. 3.2.3), в разных регионах распределён по-разному: в Красноярском крае он в рыбе и птице, в Санкт-Петербурге — в птице, рыбе и твороге, в Новосибирской области — в птице. Учреждению, которое переносит чужой опыт выбора, отсюда простой совет: проверять пары по своей региональной норме и в тех же единицах (брутто или нетто), в которых она выражена.

3.13 Республика Татарстан: пример из здравоохранения

Первая редакция обзора включила в региональный раздел аудит организации питания в республиканской клинической психиатрической больнице, проведённый контрольным органом Республики Татарстан: стоимость питания составила около 224–310 руб. на койко-день, фактические рационы были занижены против рекомендуемых норм [1, 77]. Это учреждение здравоохранения, и его цифры на стоимость питания в социальном обслуживании прямо не переносятся. Ценен методический вывод аудита: наличие норм не гарантирует их исполнения, и проверка должна сопоставлять нормы с фактической закладкой. Ссылка первой редакции на «акт Минтруда Республики Татарстан» о нормах питания дана без реквизитов [1] и во второй редакции не используется.

3.14 Сравнение

Субъект	Акт	Единицы	Дифференциация	СБКС/ВМК в общей норме	Замена продуктов	Статус сведений
Санкт-Петербург	Пост. от 29.12.2014 № 1284 (ред. № 561 от 27.06.2022)	Нетто	По типу учреждения и состоянию здоровья; две нормы для ПНИ	Да	Не предусмотрена в тексте	Проверено по тексту [31]
Москва	Приказ ДТС-ЗН от 22.03.2021 № 228	Нет данных	По видам организаций (6 приложений)	Нет данных	Не проверено; есть норма о ± 5 % калорийности по приёмам при соблюдении среднего за неделю	Преамбула и п. 1–2.1 проверены [63]

Субъект	Акт	Единицы	Дифференциация	СБКС/ВМК в общей норме	Замена продуктов	Статус сведений
Свердловская обл.	Пост. от 10.11.2022 № 765-ПП	Нет данных	По видам учреждений	Да (по [1])	По прил. 11 СанПиН (по [1])	По первой редакции
Нижегородская обл.	Пост. от 20.10.2014 № 709 (ред. № 617 от 30.08.2019); приказ от 21.04.2022 № 214	Нетто	По видам учреждений	Нет данных	По нормам взаимозаменяемости (по [1]); локальные таблицы замен в учреждении [44]	Нормы в ред. № 617 проверены по тексту [64]; локальная форма проверена
Омская обл.	Приказ от 11.11.2014 № 171-п	Нет данных	По видам учреждений	Нет данных	По рекомендациям 2002 г. (по [1])	По первой редакции
Псковская обл.	Приказ КСЗН от 14.07.2020 № 206	Нет данных	По видам учреждений	Нет данных	Нет данных	По первой редакции
Новосибирская обл.	Приказ МСР от 06.10.2014 № 1164 (ред. № 769-НПА от 25.05.2023)	Брутто	По четырём типам организаций	СБКС — по медицинским показаниям; ВМК 50–100 %	Не предусмотрена в тексте	Проверено по тексту [43]
Красноярский край	Пост. от 17.12.2014 № 607-п (ред. от 14.10.2021; изм. № 74-п от 06.02.2024 и № 892-п от 14.10.2025)	Брутто	Раздел 1 — дома-интернаты (с 2026 г. — пансионаты) и спецдома; раздел 2 — ПНИ (с 2026 г. — ДСО); отдельно — диабет	СБКС нет; поливитамины 3 раза в неделю	Не предусмотрена в тексте	Раздел 1 проверен по ред. 2021 г. [41]; изменения 2024–2025 гг. — по реквизитам и наименованиям разделов [75]
Ленинградская обл.	Приказ КСЗН от 30.12.2021 № 04-58, прил. 3	Брутто и нетто	Единая норма для стационаров с постоянным проживанием	Да	Не предусмотрена в тексте	Проверено по тексту; изменения 2022–2025 гг. (в т. ч. приказ № 04-81 от 04.08.2025) не прочитаны [42, 76]
ХМАО — Югра	Пост. от 22.08.2014 № 306-п (ред. № 327-п от 06.09.2014)	Нетто	По возрастным группам	Да	Нет данных	Проверено по редакции 2014 г. [65]

3.15 Что региональные нормы дают выбору

Региональная норма отвечает на вопрос «сколько», а не «что и как». Она задаёт точное количество продуктов по группам и почти никогда — набор блюд, число вариантов, время и место подачи. Остаётся широкое поле организационной свободы, и на практике его занимает привычка: одно меню на всех, потому что так проще считать раскладку (толкование).

Учреждению, вводящему выбор, региональная норма ставит четыре практических условия. Первое: суммарная закладка за отчётный период (неделя, декада, месяц) соответствует норме по каждой группе. Второе: варианты внутри группы продуктов норму не затрагивают, а варианты между группами требуют утверждённой учреждением таблицы замен со ссылкой на источник. Третье: контроль по среднему за период, а не по каждому дню, допустим. Федеральной нормы, которая разрешала бы его для взрослых, нет: в СанПиН он закреплён для детей (подп. «в» подп. 2 п. 59 СанПиН 4282-26 допускает отклонение по приёмам пищи ± 5 % при соблюдении среднего за неделю [3]). Из прочитанных региональных актов прямую опору даёт только московский приказ № 228, допускающий отступление от норм калорийности по отдельным приёмам пищи ± 5 % при соответствии нормам среднего за неделю [63]. В остальных регионах способ контроля следует закрепить локальным актом (рекомендация); московскую формулировку разумно использовать как образец, оговорив, что она касается калорийности, а для групп продуктов нужен собственный порядок учёта замен.

Четвёртое условие следует из п. 3.12: таблица замен и все расчёты должны вестись в тех же единицах (брутто или нетто), в которых выражена региональная норма; смешение единиц при переносе чужих пар блюд даёт ошибку, сравнимую по величине с самим эффектом замены (иллюстративная оценка по коэффициентам ленинградского приказа: для мяса 0,705, для рыбы 0,550 [42]).

4 Российские практики: что известно из открытых источников

4.1 Метод и ограничения

В этом разделе собраны публичные сообщения о вариативном питании в российских стационарных организациях социального обслуживания, найденные к 05.10.2026. Каждое сообщение прочитано в два слоя: что источник говорит и о чём молчит. Новость учреждения или органа власти удостоверяет только то, что так было сказано на дату публикации; проверкой она не является. Ни к одному из кейсов ниже не приложены данные о весе, потреблении, отходах или затратах, поэтому кейсы показывают организационные решения, но не доказывают эффекта.

По сравнению с первой редакцией, где был описан один российский кейс (Болотнинский ПНИ) [1], здесь рассмотрены восемь учреждений и одно региональное сообщение. Часть сведений получена при повторной проверке сайтов учреждений в октябре 2026 г.; она уточняет и первую редакцию, и рабочую базу знаний проекта [21].

Место каждого кейса на шкале раздачи (M0–M5, п. 1.4) определено автором по тексту сообщений; это толкование.

4.2 Болотнинский психоневрологический интернат (Новосибирская область)

Что сообщает источник. Публикация ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» от 16.08.2024: с 2024 г. «несколько раз в неделю введено вариативное питание»; в такие дни в меню на завтрак и обед включены несколько вариантов блюд; на завтрак — чай, какао или кофейный напиток, молочная каша либо суп; в обед — «разнообразие салатов и вторых блюд, а также десерт, фрукты и творог»; перечень блюд определяет медицинская сестра диетическая; учреждение планирует расширить вечернее меню [5]. Повторная публикация от 03.09.2026 описывает обед с выбором между курицей (жареной или отварной) с гречкой и салатами; суп указан один [6].

Чего источник не сообщает. Доли жителей, участвующих в выборе; способа выбора для неговорящих жителей; изменений в закупках и штате; данных о потреблении. Первая редакция обзора утверждала, что выбор в Болотнинском ПНИ делается накануне и «без изменения норм питания» [1]; в тексте сообщения 2024 г. ни того, ни другого нет. Во второй редакции эти детали сняты.

Модель. Выбор в момент еды из ограниченного перечня, формируемого диетсестрой, — M1 по шкале раздачи (несколько дней в неделю). Публикация 2026 г. показывает, что через два года практика жива.

4.3 Успенский психоневрологический интернат (Новосибирская область)

Что сообщает источник. Публикация ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» от 13.08.2024 (рассказ начальника отдела питания): в марте 2024 г. «все отделения перешли на вариативное меню»; жители выбирают из двух видов вторых блюд, салатов и напитков, «составляя свой обед или ужин»; например, два рыбных или два мясных блюда, салаты из свежих или отварных овощей (винегрет, салат из свёклы). Перед внедрением проведены опрос жителей и анкетирование, по результатам которого блюда «расставлены по балльной системе в зависимости от степени спроса». Сотрудники опасались, что части жителей трудно будет подойти к линии раздачи и выбрать блюдо; опасения не оправдались. Заодно обновили посуду и провели занятия по застольному этикету. Меню — перспективное семидневное летне-осеннее [7].

Публикация регионального информационного агентства от 23.10.2025 со ссылкой на министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщает, что к проекту «Шведский стол» присоединилось третье отделение интерната: жители «сами решают, что и сколько съесть»; руководство планирует распространить практику на все отделения; заместитель министра отметил улучшение аппетита [8].

Следующий этап описывают два сообщения от 27.07.2026 — новость самого интерната (со словами начальника отдела питания) и интервью директора региональному изданию [10, 11]. В 2026 г. интернат «полностью перешёл на „шведский стол“»; 24.07.2026 установлена четвёртая линия раздачи, рассчитанная, по словам директора, на 380 проживающих; её стоимость — «более 3 миллионов рублей» («3 с чем-то миллиона»), и это самая дорогая из линий учреждения (столешица из искусственного камня, подсветка). Внедрение формата начато в мае 2025 г. и распространялось на пищеблоки поэтапно [10]. По словам начальника отдела питания, из обеденного зала убрали около 40 посадочных мест, а «время приёма пищи за счёт самообслуживания сократилось с 2,5 часов до 50 минут» [11]. Директор приводит пример свободы комбинирования: салат из 5–6 ингредиентов, из которых житель берёт 2–3 в своих пропорциях; оба источника сообщают, что жители «стали более аккуратными и самостоятельными» [10, 11].

Чего источники не сообщают. Сведений о затратах на продукты и об изменении производственных отходов; о жителях, которые не могут выбрать сами и не подходят к линии; о том, кто и как контролирует количество взятого при свободе порции. Как измеряли сокращение времени приёма пищи (что считали началом и концом, для скольких смен), не сказано; это остаётся утверждением учреждения. Стоимость названа только для одной, «самой дорогой» линии; затраты на три предыдущие не раскрыты. Сообщение 2024 г. не уточняет, ежедневен ли выбор (в рабочей базе знаний проекта он описан как ежедневный [21] — это прочтение, а не цитата). Утверждение заместителя министра об аппетите не подкреплено данными измерений.

Модель и противоречие слоёв. В 2024 г. — М2 (два варианта нескольких блюд на линии раздачи во всех отделениях). В 2025 г. в части отделений — формат самообслуживания со свободой порции, ближе к М3. Рабочая база проекта фиксирует Успенский ПНИ как М2 с пометкой «шведской линии в источнике нет» [21]; для сообще-

ния 2024 г. это верно, для сообщения 2025 г. — уже нет. Слои описывают разные даты и друг другу не противоречат, если дату называть. Сообщения 2026 г. фиксируют переход всех пищеблоков к МЗ [11].

Значение для операционных решений. Успенский кейс — единственный российский источник, где названы одновременно стоимость оборудования (более 3 млн руб. за линию), его расчётная мощность (380 жителей) и операционный эффект (время приёма пищи с 2,5 ч до 50 мин, минус 40 посадочных мест) [10, 11]. Переносить эти числа на другое учреждение как норматив нельзя, но порядок величин для сценария 14 гл. 7 они задают: самообслуживание может сокращать раздачу, а не удлинять её, если жители способны подойти к линии. Для тех, кто к линии не подходит, вопрос открыт (п. 7.16).

4.4 Каменский психоневрологический интернат (Новосибирская область)

Что сообщает источник. Публикация ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» от 19.08.2024: «с июля месяца два раза в неделю» проживающие могут выбирать блюда из меню «исходя из собственных предпочтений и особенностей здоровья»; повара готовят несколько вариантов меню; приведён отзыв жителя о том, что у него «улучшился аппетит» [9].

Чего источник не сообщает. Какие блюда и в каком приёме пищи выбираются, сколько жителей участвует, как учитываются «особенности здоровья» и кто их оценивает.

Модель. Выбор два дня в неделю — М1 по шкале раздачи (толкование). Лучший аппетит — слова одного жителя, а не измерение. Каменский интернат — третье учреждение Новосибирской области, сообщившее о вариативном питании летом 2024 г. (вместе с Болотнинским и Успенским); близость дат публикаций (13, 16 и 19 августа 2024 г.) наводит на мысль об общем региональном импульсе, но документа регионального органа, который бы это подтверждал, найти не удалось (открытая новостная лента министерства труда и социального развития Новосибирской области при проверке была недоступна) [5, 7, 9].

4.5 Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область)

Что сообщают источники. Учреждение (в публикациях 2024 г. — Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», ныне ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания») опубликовало четыре сообщения [12]:

- 27.09.2024: с сентября «постепенное введение вариативного меню»; на начальном этапе — для жителей, посещающих столовую; проведён «подробный опрос», продукты и блюда сгруппированы «по уровню их популярности», чтобы избежать однообразия и сохранить сбалансированность; в первый день жители выбирали на линии раздачи салат и второе блюдо, «остальной набор меню был... как всегда, накрыт»;

- 17.12.2024: пример обеда — выбор гарнира (рис или гречка) и второго блюда (гуляш мясной или печень по-строгановски); в учреждении работает экспертная комиссия по питанию, которая вносит изменения в перспективное меню и оценивает качество методом опроса и наблюдения; с 01.01.2025 ассортимент планировалось расширить (выпечка с начинкой по выбору, пельмени или вареники, напитки);
- 13.02.2025: пищеблок ежедневно готовит на 220 человек «по восьми видам меню с правом выбора в обед»; меню цикличное 14-дневное, питание шестизачное;
- 09.02.2026: заседание совета по питанию; внештатный нутрициолог проанализировала «вариативное цикличное меню» и рекомендовала, в частности, заменить хлеб размооченными гренками для лиц с нарушенным глотанием; фельдшер предложила рассчитывать энергетическую потребность по формуле Миффлина — Сан Жеора; поставлена задача скорректировать меню для граждан 60+.

Чего источники не сообщают. Как выбирают жители, не посещающие столовую; есть ли выбор вне обеда; затраты; данные о потреблении.

Значение кейса. Только здесь из найденных российских практик публично описаны все четыре стадии: исследование предпочтений до запуска, поэтапный старт с наиболее мобильной группы, коллегиальный орган, который пересматривает меню, и внешняя экспертиза через полтора года. Сочетание «циклического 14-дневного меню» и «права выбора в обед» наглядно показывает: цикличность и вариативность — разные свойства одного меню (п. 1.2). Совет нутрициолога о текстуре хлеба — пример клинического вопроса, который возникает при расширении выбора и решается не кухней, а специалистом (рекомендация учреждения, не норма).

Учреждение — бывший дом-интернат для престарелых и инвалидов, а не ПНИ. Рабочая база проекта относит «четыре публичных кейса Новосибирской и Иркутской областей» к ПНИ [21]; для Усть-Илимска это неточно.

4.6 Иркутская область: региональное сообщение и Чунский ДСО

Что сообщают источники. Пересказ на агрегаторе новостей сообщения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14.02.2025: в стационарных учреждениях региона организовано вариативное питание с выбором из двух первых, двух вторых блюд и гарниров [13]. Оригинал сообщения на сайте министерства найти не удалось; агрегатор при повторной проверке в октябре 2026 г. был закрыт защитой от автоматического доступа, текст по нему не перепроверен. Сообщение пресс-службы правительства Иркутской области от 26.11.2025 о Чунском доме социального обслуживания (ранее Чунский психоневрологический интернат «Радуга», 255 мест) называет вариативное питание среди условий проживания [14].

Повторный поиск первоисточника (сайт министерства, архив веб-страниц) результата не дал: агрегатор недоступен для автоматического чтения, снимков страницы в веб-архиве нет. Вместо него найдено прямое высказывание министра социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области В. А. Родионова в интервью «Областной газете» (04.02.2026): «В прошлом году запустили вариативное питание, в планах внедрение элементов шведского стола» [17]. В том же интервью сообщается, что в регионе 50 стационарных учреждений, а психоневрологические интернаты в 2025 г. переименованы в дома социального обслуживания [17]. Интервью подтверждает устами должностного лица факт и год запуска (2025), но не формат «два первых, два вторых и гарниры» — он держится только на пересказе агрегатора.

Что известно о нормативной рамке. Акт Контрольно-счётной палаты Иркутской области по проверке расходов на питание в Ново-Ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов (07.07.2023) сообщает, что нормы питания в домах-интернатах региона утверждены приказом министерства от 28.11.2014 № 184-мпр, включают 43 наименования продуктов и пересматривались 13.05.2015, 23.12.2015, 14.01.2016 и 10.03.2023 [18]. Там же воспроизведён стандарт социальной услуги «обеспечение питанием»: не реже трёх раз в день для совершеннолетних, с обслуживанием и сервировкой стола в обеденном зале, для маломобильных — в комнате; стандарт услуги «помощь в приёме пищи» — до пяти раз в день и до 15 минут на каждое кормление [18]. О выборе блюд ни нормы, ни стандарт в изложении акта не говорят.

Чего источники не сообщают. Сколько из 50 стационарных учреждений перешло на выбор; закреплено ли это региональным актом; с какой периодичностью. В открытом доступе не найден региональный правовой акт Иркутской области, который предписывал бы вариативное питание; порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме (приказ министерства от 11.12.2014 № 193-мпр) содержит лишь общую обязанность обеспечивать питание по нормам [15].

4.7 Красавинский дом социального обслуживания (Вологодская область)

Что сообщает источник. Сообщение информационного агентства от 05.07.2026: в июне 2026 г. в Вологодской области создана межрегиональная методическая площадка для внедрения вариативного меню и «шведского стола»; организатор — Красавинский дом социального обслуживания, интегрировавший вариативное меню в 2025 г.; представители Новосибирской, Тюменской областей и Удмуртской Республики рассказали об организации питания через аутсорсинг, о формате «шведского стола» и о применении инфоматов для выявления вкусовых предпочтений; мероприятие связано с национальным проектом «Семья» [16].

Чего источник не сообщает. Модели выбора, охвата, затрат. Учреждение имеет организационно-правовую форму автономного учреждения (АОУ), что предполагает закупки по 223-ФЗ, если учреждение приняло положение о закупке (толкование; положение не анализировалось).

Значение. Межрегиональная площадка показывает, что к 2026 г. практика вышла за стены отдельных учреждений и стала предметом методической работы региональных ведомств. Упоминание инфоматов для сбора предпочтений — первое в найденных российских источниках указание на технический канал выбора, кроме устного [16].

4.8 ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург)

Автор доклада — директор этого учреждения; конфликт интересов раскрыт. Ниже — только сведения из публичных источников; внутренние данные учреждения в доклад не включены.

Что сообщают источники. Сообщение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025 о заседании рабочей группы по реформированию психоневрологических интернатов Санкт-Петербурга: руководитель ДСО «Серафимовский» представил первые результаты внедрения вариативного меню для части жителей; в течение нескольких месяцев проживающим предлагалось накануне выбрать рацион на следующий день из предложенного меню; учреждение закупило дополнительное оборудование и добавило сотрудников для организации питания; жители «с энтузиазмом восприняли» эксперимент, но полный переход «крайне затруднителен с точки зрения соблюдения всех норм питания по сбалансированности и учёта особенностей здоровья проживающих»; жители «склонны к выбору популярных, но не самых полезных продуктов» [19].

Приказом учреждения от 10.03.2026 № 124 утверждены правила внутреннего распорядка, в которых закреплено заказное питание (вариативное меню), в том числе для маломобильных жителей с приёмом пищи в жилых комнатах [26]. Сайт учреждения прекратил работу; правила доступны в веб-архиве (копия от 15.04.2026). По данным архивной копии сайта (февраль 2026 г.), учреждение обслуживало 1 004 человека, питание шестизаровое, с поздним вторым ужином [21, 26].

Чего источники не сообщают. Доли жителей, пользующихся заказом; числа добавленных ставок и стоимости оборудования; данных о потреблении и отходах.

Независимое упоминание петербургской практики есть в исследовании проекта «Если быть точным» (09.04.2026): со слов С. Мамоновой (БО «Перспективы»), «в одном из петербургских интернатов небольшой группе наиболее самостоятельных подопечных позволили самим выбирать еду из предложенных вариантов меню», при этом такие изменения «не носят массового характера» [4]. Учреждение в публикации не названо, и отождествлять это свидетельство с ДСО «Серафимовский» нельзя; оно подтверждает лишь, что в 2025–2026 гг. выбор в петербургских ПНИ оставался уделом узкой группы жителей.

Модель и классы утверждений. Заказ накануне из предложенного меню — М1 по шкале раздачи: выбор есть, но сделан не в момент еды (п. 1.4). Приказ № 124 — **локальная форма**: он показывает, что учреждение может закрепить вариативное питание в правилах внутреннего распорядка, но нормой ни для других учреждений, ни для проверяющего не служит.

В сообщении Комитета две оценки, которые часто цитируют порознь: жители приняли выбор с энтузиазмом, и полный переход затруднителен. Вторая оценка — суждение руководителя учреждения, а не результат измерения; данные о влиянии выбора на состав фактического потребления в сообщении не приводятся. Научные данные здесь противоречивы (п. 5.3): в исследовании Wheeler и соавт. переход к выбору в момент еды сопровождался чуть большим потреблением белковых продуктов и овощей и меньшим — углеводных в расчёте на приём пищи [78].

4.9 «Добрый дом „Солнечногорский“» (Московская область)

Что сообщает источник. Страница «Питание» сайта ГАСУСО МО «Добрый дом „Солнечногорский“» (ранее Солнечногорский ПНИ): утверждены «зимнее» и «летнее» 14-дневное меню с пяти- и шестirazовым лечебным и профилактическим питанием; меню разработано с учётом норм питания в ПНИ, утверждённых распоряжением министерства социального развития Московской области от 13.04.2017 № 19РВ-32; работает совет по питанию со ссылкой на приказ Минздрава России № 330; «по желанию получателей социальных услуг и по согласованию с лечащим врачом» совет рассматривает замену или введение новых блюд; обеденный зал рассчитан на 120 мест, маломобильные жители едят в обеденных зонах жилых корпусов; приём пищи поточный, жители могут самостоятельно обслуживаться на раздаточной линии; на сайте опубликовано «14-дневное вариативное меню» [27].

Чего источник не сообщает. Есть ли ежедневный выбор между блюдами при каждом приёме пищи; как устроен выбор в жилых корпусах.

Классификация. Механизм «замена блюда по желанию через совет с согласия врача» — это персонализация меню, а не выбор в момент еды (п. 1.2). Самообслуживание на линии само по себе не означает выбора между вариантами: линия может выдавать одно блюдо. Рабочая база проекта называет распоряжение № 19РВ-32 медицинским «мостиком» к лечебному питанию [21]; по тексту сайта это нормы питания в ПНИ Московской области, а ссылка на приказ № 330 относится к совету по питанию. Вторая редакция это уточняет.

4.10 Сводная таблица

Учреждение	Тип	Дата первого сообщения	Что выбирают	Когда выбирают	Модель (толкование)	Опубликованные измерения
Болотнинский ПНИ	ПНИ	16.08.2024	Напиток, каша/суп; салаты, вторые, десерт	В момент еды, несколько дней в неделю	М1	Нет
Успенский ПНИ	ПНИ	13.08.2024	Два вторых, два салата, два напитка; с 2025 г. — самообслуживание, в 2026 г. — на всех четырёх пищеблоках	В момент еды	М2 → М3	Нет (названы стоимость линии и время приёма пищи — без метода измерения)
Каменский ПНИ	ПНИ	19.08.2024	Несколько вариантов меню	Два дня в неделю	М1	Нет
Усть-Илимский ДСО	Бывший дом-интернат общего типа	27.09.2024	Салат и второе; гарнир	В момент еды, обед	М1 → М2	Нет (есть экспертиза меню 2026 г.)

Учреждение	Тип	Дата первого сообщения	Что выбирают	Когда выбирают	Модель (толкование)	Опубликованные измерения
Учреждения Иркутской обл.	Разные	14.02.2025 (запуск в 2025 г. подтверждён министром 04.02.2026)	Два первых, два вторых, гарниры (по пересказу)	Не указано	Не определяется	Нет
Чунский ДСО	Бывший ПНИ	26.11.2025	Не указано	Не указано	Не определяется	Нет
Красавинский ДСО	Не указано	05.07.2026	Не указано (вариативное меню, «шведский стол» на площадке)	Не указано	Не определяется	Нет
ДСО «Серафимовский»	Бывший ПНИ	22.07.2025	Рацион следующего дня из предложенного меню	Накануне	М1	Нет
«Добрый дом „Солнечногорский“»	Бывший ПНИ	Не датировано	Замена блюда по желанию через совет	По заявке	Персонализация	Нет

4.11 Что следует из совокупности кейсов

В сообщениях разных учреждений повторяются четыре элемента. Первое: изучение предпочтений до запуска (опрос и балльное ранжирование в Успенском ПНИ, опрос и группировка по популярности в Усть-Илимске). Второе: ограниченный старт — по дням недели (Болотнинский, Каменский), по группе жителей (Усть-Илимск, Серафимовский), по отделениям (Успенский в 2025 г.). Третье: выбор ограничен одним-двумя блюдами приёма пищи, остальное подаётся по общему меню. Четвёртое: коллегиальный орган — совет или комиссия по питанию — появляется в Усть-Илимске и в «Солнечногорском».

Расходятся кейсы в ресурсах. Новосибирские сообщения 2024 г. и иркутские сообщения не упоминают дополнительного персонала или оборудования; петербургское сообщение их называет [19]; Успенский интернат в 2026 г. назвал стоимость одной линии раздачи — более 3 млн руб. [10]. Первая редакция обзора утверждала, что опыт «показывает возможность введения выбора без существенного роста затрат» [1], и одновременно — в разделе о рисках — что вариативное меню «объективно дороже» [1]. Ни одно из этих утверждений не опирается на опубликованные расчёты. Честный вывод скромнее: стартовый формат (выбор из двух блюд в момент еды в одном приёме пищи) в ряде учреждений был введён без публично названных дополнительных ресурсов; заказ накануне и обслуживание маломобильных в комнатах потребовали ресурсов в учреждении, сообщившем о них (толкование).

Ни одно учреждение не опубликовало данных о весе жителей, потреблении или отходах до и после внедрения. Это главный пробел российской практики: без таких данных спор о пользе и вреде выбора остаётся спором мнений, а довод «популярное не самое полезное» нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

5 Научные данные

5.1 Зачем доклад о праве обращается к исследованиям

В российских учреждениях спор о вариативном меню ведут в основном двумя доводами: «выбор улучшает качество жизни» и «выбор ухудшит питание, потому что жители предпочтут вкусное вредное полезному». Оба довода эмпирические, и оба можно проверить. Раздел излагает, что о них известно из рецензируемой литературы. Поиск велся в Европе PMC, PubMed, Кокрейновской библиотеке и eLIBRARY/КиберЛенинке по запросам о выборе блюд (menu choice, food choice, mealtime choice), автономии при приёме пищи, мальнутриции, отходах с тарелки и качестве жизни в учреждениях длительного ухода. В текст вошли только работы, библиографические данные и основные числа которых сверены по аннотации или полному тексту.

5.2 Масштаб проблемы: недостаточность питания в учреждениях

Самая полная оценка распространённости недостаточности питания у пожилых по инструменту MNA (Mini Nutritional Assessment) — метаанализ Cereda и соавт. 2016 г.: 240 исследований, 113 967 человек. Распространённость составила 3,1 % у живущих дома, 17,5 % (95 % ДИ 14,3–20,6) в домах престарелых (nursing homes), 28,7 % (21,4–36,0) в учреждениях длительного ухода (long-term care) и 22,0 % в больницах [79]. Доля лиц в зоне риска в учреждениях выше доли лиц с установленной недостаточностью в несколько раз.

Российских популяционных данных по стационарным организациям социального обслуживания в рецензируемой литературе нет. Ближе всего по смыслу — исследование Горелика С. Г. и соавт. (2020) в учреждении для пожилых: из 97 обследованных по MNA недостаточность питания выявлена у 10,4 %, риск недостаточности — у 72,1 %, нормальный статус — у 17,5 %; у 17,9 % суточное потребление жидкости было ниже 750 мл. После коррекции рациона улучшение нутритивного статуса отмечено у 73,5 % [38]. Ограничения велики: одно учреждение, средний возраст 64,7 года, нет контрольной группы, и «улучшение у 73,5 %» нельзя приписать конкретному вмешательству. Для нашей темы ценна цифра риска: почти три четверти жителей одного российского учреждения находились в зоне риска по питанию.

Российская ассоциация геронтологов и гериатров в клинических рекомендациях 2020 г. по недостаточности питания у пожилых предусматривает скрининг по MNA и комплекс мер, включающий обогащение рациона и устранение причин сниженного потребления [48]. Рекомендации обращены к медицинским работникам; в социальном обслуживании они применимы в той мере, в какой учреждение оказывает медицинскую помощь (толкование, см. п. 2.8).

5.3 Выбор и удовлетворённость

Самая известная работа о выборе в институциональном питании — исследование Wright, Connelly, Capra и Hendrikz (2013, Brisbane). Обследованы 103 пациента больницы и 210 жителей девяти домов престарелых. Удовлетворённость питанием была связана с количеством предлагаемых вариантов и с моментом выбора: чем ближе выбор к приёму пищи и чем больше вариантов, тем выше удовлетворённость ($P < 0,01$). Авторы рекомендовали сокращать разрыв между выбором и подачей еды [80]. Это одна из немногих работ, где самостоятельным фактором выделено время выбора, а не только число вариантов; отсюда довод в пользу того, чтобы различать на шкале раздачи M1 (выбор накануне) и M2 (выбор в момент еды).

Abbey, Wright и Capra (2015) описали, как выбор на деле устроен в австралийских домах престарелых. Исследование включало национальный опрос учреждений о планировании меню (247 учреждений), анализ меню (161) и наблюдение 36 приёмов пищи. Выбора оказалось мало во всей выборке, особенно у жителей на протёртой пище; меню редко планировали с расчётом на альтернативы. Авторы предложили усилить регулирование и мониторинг выбора в рамках национальных стандартов аккредитации [81]. Вывод прямо касается российских ПНИ и домов-интернатов: два блюда на линии раздачи ещё не значат, что выбор доступен жителю на протёртой пище или тому, кто не может выразить желание словами.

Wheeler, Abbey и Capra (2025) сравнили в одном австралийском учреждении две системы: традиционную (меню, выбираемое заранее) и систему, в которой житель выбирает из семи горячих блюд в момент подачи. Удовлетворённость выросла с 3,60 до 4,57 балла по пятибалльной шкале. По сравнению со стандартным блюдом приём пищи из нового меню давал чуть больше белковых продуктов (+5 г) и овощей (+11 г) и меньше углеводов (–38 г). Производственные отходы выросли с 55 до 90 г на жителя в день. Стоимость питания выросла с 9,20–11,14 до 11,01–12,15 австралийского доллара на жителя в день [78]. Качественное исследование той же группы, основанное на интервью с 20 жителями до и 18 после перехода, показало, что жители связывали возможность выбора в момент еды с ощущением контроля и самостоятельности [82].

Для российского спора эти данные важны дважды. Во-первых, они не подтверждают опасения, что выбор неизбежно портит состав потребления: в исследовании съеденные блюда из нового меню содержали чуть больше белковых продуктов и овощей. Во-вторых, они называют цену: выбор в момент еды увеличил производственные отходы и стоимость. Вывод о росте стоимости не переносится на российские условия напрямую (другие структура затрат, уровень цен, штат), но направление эффекта надо учитывать (толкование).

Близкий результат получен в больничном питании. В частной больнице Брисбена переход к модели room service — пациент заказывает блюда из ресторанного меню по телефону и получает их приготовленными под заказ — по данным ретроспективного анализа аудитов и сравнения «до/после» сопровождался ростом потребления пищи и удовлетворённости при снижении отходов и стоимости питания на пациен-

та [83]. Больничный контекст отличается от учреждения долговременного проживания (короткое пребывание, другой состав пациентов), поэтому результат приведён как аналогия, а не как доказательство для ДСО и ПНИ.

5.4 Как жители и персонал описывают выбор: качественные исследования

Количественные работы отвечают на вопрос «сколько», качественные — на вопрос «почему выбор не случается, даже когда его хотят». Три работы разных лет и стран описывают барьеры сходно.

Wang и соавт. (2020) провели углублённые интервью с семьёю жителями и семьёю сотрудниками двух австралийских учреждений; анализ строился на теории самодетерминации. Выделены три темы: «питание на массу» (catering for the masses), организационные барьеры для выбора и влияние еды на благополучие [84]. Авторы называют недостаточный выбор «давней проблемой», требующей внимания и обязательств учреждения. Bailey и соавт. (2017) в феноменологическом исследовании шести жителей двух учреждений показали, что жители в основном не знали о пищевых регламентах и рисках, которыми обосновываются ограничения, но хотели сами принимать решения; их рассказы о еде в учреждении были противоречивыми, что авторы связывают с трудностью совместить индивидуальные предпочтения и минимизацию рисков, предписанную регулятором; название статьи — цитата жителя: «я лучше умру счастливым» [85].

Mondkar и соавт. (2025) опросили 17 человек (жители, руководители, сотрудники ухода и кухни) в четырёх домах одного лондонского округа. Предпочтения в еде собирались при поступлении вместе со сведениями об образе жизни и распорядке, и персонал старался их поддерживать «где возможно» [86]. Но фактическая широта выбора зависела от того, способен ли и готов ли житель попросить альтернативу, есть ли у него деньги на собственные продукты, может ли он выйти за пределы учреждения и приносить ли еду родные [86]. Здесь прямо назван механизм неравенства, который вариативное меню может не устранить, а закрепить: выбор, построенный на вопросе «что вы хотите?», достаётся тем, кто способен ответить и настоять (толкование; ср. п. 7.16).

Для российского учреждения эти работы ценны как список проверочных вопросов, а не как доказательство эффекта (рекомендация): кто из жителей реально пользуется выбором; кто не пользуется и почему; какие ограничения объясняются жителям, а какие просто действуют; что меняется, если у жителя нет денег и родственников.

5.5 Выбор, среда приёма пищи и пищевой статус

Кластерное рандомизированное исследование Nijls и соавт. (2006, Нидерланды; 178 жителей пяти домов без деменции) сравнило семейный стиль приёма пищи (общий стол, блюда на столе, жители накладывают себе сами, персонал ест вместе с ними) с обычной индивидуальной подачей. Через шесть месяцев качество жизни в основной

группе было выше на 6,1 балла (95 % ДИ 2,1–10,3), масса тела — на 1,5 кг (0,6–2,4) [28]. Семейная подача — это М4 по шкале раздачи, и исследование показывает эффект целого комплекса перемен, а не одного выбора.

Croghan и соавт. (2013, США) сравнили два дома престарелых со сходным составом жителей: в одном (33 участника) внедрили систему доставки и выбора блюд Eat Right, другой (28 участников) служил группой сравнения. В основной группе выросли удовлетворённость питанием, уровень преальбумина ($p = 0,001$) и масса тела ($p = 0,029$) [87]. Дизайн пилотный, без рандомизации; результат правдоподобен, но не доказателен.

Divert и соавт. (2015, Франция) в серии из 12 экспериментальных обедов для 42 жителей домов престарелых проверили по отдельности четыре фактора: название блюда в меню, размер и разнообразие порции овощей, приправы на столе, декор и фоновую музыку. Удовлетворённость и потребление мяса или овощей росли, когда изменение касалось непосредственно того, что съедается (разнообразие на тарелке, приправы на столе); названия блюд и декор эффекта не дали [88]. Авторы исходят из того, что во французских домах престарелых меню, время, место приёма пищи и место за столом обычно навязаны жителю. Работа полезна как перечень дешёвых мер — с подтверждённым эффектом и без него.

Kenkmann и соавт. (2010, Великобритания, графство Норфолк) оценили в шести домах ухода (120 из 213 жителей) пакет изменений, близкий к российскому «шведскому столу»: улучшенная обстановка столовой, большой выбор блюд, удлинённые часы работы «ресторана», доступные закуски и автоматы с напитками — в трёх домах, при трёх контрольных [89]. Население было хрупким (средний возраст 87 лет, 71 % женщин; 43 % получали психотропные препараты). Частота падений (первичный исход) в основной группе снизилась относительно контрольной на 24 %, но различие не достигло статистической значимости (скорректированное отношение частот 0,76; 95 % ДИ 0,57–1,02; $p = 0,06$) [89]. Авторы признают, что рутинные данные удалось использовать лишь частично, а потери наблюдения и пропуски были велики. Работа поучительна как пример: учреждение может оценивать изменение питания по данным, которые оно и так собирает (падения, масса тела, обращения), но без строгого дизайна и при малой выборке такой анализ даёт лишь направление, а не доказательство.

Систематические обзоры осторожнее отдельных исследований. Abbott и соавт. (2013) проанализировали 37 работ о вмешательствах в среде приёма пищи у пожилых в учреждениях; эффект на массу тела в объединённом анализе был статистически незначим, а изменения среды приёма пищи были связаны с увеличением потребления энергии на 181 ккал/сут (95 % ДИ от –5 до 367; $p = 0,06$) [90]. Кокрейновский обзор Herke и соавт. (2018) по вмешательствам в среде и организации приёма пищи у людей с деменцией в учреждениях включил 9 исследований (1502 участника) и оценил доказательность как низкую или очень низкую [91]. Общий итог: перемены в организации питания, включающие выбор, скорее улучшают удовлетворённость и потребление, чем ухудшают, но эффект на пищевой статус невелик и плохо измерен.

5.6 Достоинство и приём пищи: национальные данные

Самые крупные данные о связи среды приёма пищи с чувством достоинства получены в Швеции. Roos и соавт. (2022) проанализировали национальные опросы жителей учреждений для пожилых во всех 290 муниципалитетах страны за 2016, 2017 и 2018 гг. (13 763, 13 251 и 12 620 ответов; медиана возраста 88 лет, 69 % женщин) [92]. Более высокие шансы быть удовлетворённым аспектами достоинства и благополучия имели жители, которые хорошо оценивали своё здоровье, не имели диагноза деменции, не сталкивались с неуважительным отношением персонала и находили приятной обстановку в помещениях, на улице и во время приёма пищи [92]. Обстановка приёма пищи в этом исследовании измерялась вместе с другими элементами среды, поэтому вклад именно питания не выделяется; дизайн ретроспективный и наблюдательный. И всё же это первое из найденных национальных исследований, где среда приёма пищи вошла в число изменяемых факторов, связанных с достоинством жителя, — в одну модель с отношением персонала.

Вывод для доклада ограниченный, но существенный (толкование): довод «выбор — вопрос достоинства», которым обосновывают вариативное меню, имеет эмпирическую опору на популяционном уровне, но опора касается среды приёма пищи в целом, а не числа вариантов блюд.

5.7 Выбор и люди с тяжёлыми психическими расстройствами

Опасение, высказанное в петербургском сообщении, — жители «склонны к выбору популярных, но не самых полезных продуктов» [19] — опирается на данные, но не на те, что ему обычно приписывают. Метаанализ Teasdale и соавт. (2019; 58 исследований) показал, что люди с психотическими расстройствами и биполярным расстройством потребляют в среднем на 1332 кДж (около 318 ккал) в сутки больше энергии (95 % ДИ 487–2178 кДж) и на 322 мг больше натрия, чем контрольные группы; более высокое потребление энергии и натрия было связано с худшим качеством рациона [93]. Метаанализ объединяет исследования в разных условиях и не выделяет учреждения с нормированным продуктовым набором; он говорит о риске, но не о том, что вариативное меню в таком учреждении этот риск воспроизведёт. В учреждении выбор ограничен блюдами, которые составлены по нормам: житель выбирает между двумя блюдами из одной раскладки, а не между салатом и фастфудом (толкование).

Качественные исследования в учреждениях для людей с интеллектуальными нарушениями описывают тот же конфликт с другой стороны. В 17 полуструктурированных интервью с сотрудниками трёх небольших жилых домов (community homes) сотрудники стремились поощрять здоровое питание и одновременно уважать автономию жителей, особенно когнитивно нарушенных и получающих психотропные препараты; этому мешали нехватка знаний, времени и разноречивые подходы [94]. В швейцарском исследовании трёх учреждений (13 интервью с сотрудниками и родителями и 4 интервью об институциональной пищевой среде) на пищевое поведение жителей влияли степень самоопределения в питании, участие в приготовлении еды, подход учреждения к контролю массы тела и ресурсы, а на межличностном уровне

— представления сотрудников и родителей о питании [95]. Оба исследования заключают: ответ на риск нездорового выбора — обучение персонала и работа с пищевой средой, а не отказ от выбора.

Практический вывод для российского ПНИ (рекомендация): если врач видит у конкретного жителя метаболический риск, он принимает решение о назначениях для этого жителя; ограничивать выбор всем жителям из-за риска части из них — непропорциональная мера, не основанная на данных.

5.8 Международные клинические рекомендации

Рекомендации Европейского общества клинического питания и метаболизма (ESPEN) по клиническому питанию и гидратации в гериатрии (Volkert и соавт., 2022) содержат 82 рекомендации. Для нашей темы в них важны две линии: питание пожилых в учреждениях должно быть привлекательным и соответствовать индивидуальным предпочтениям, а ограничительных диет у пожилых с недостаточностью питания или её риском следует избегать [96]. Рекомендации ESPEN по питанию при деменции (Volkert и соавт., 2024) содержат 40 рекомендаций, из них семь посвящены условиям в учреждениях: подготовка персонала, привлекательная еда с возможностью выбора, приятная среда приёма пищи [97].

Юридически это рекомендации профессионального общества для клиницистов, а не нормы; в российском праве они не действуют. Ценны они тем, что фиксируют профессиональный консенсус: выбор и индивидуальные предпочтения рассматриваются как элемент профилактики недостаточности питания, а не как угроза ей.

5.9 Отходы с тарелки как измеритель

Обзорное (scoping) исследование Roulston и соавт. (2026) систематизировало 33 источника (20 рецензируемых и 13 источников «серой» литературы) о пищевых отходах в учреждениях длительного ухода. Чаще всего измеряли отходы с тарелки (14 источников), обычно взвешиванием (10) или визуальной оценкой (6); интервенционных исследований по снижению отходов нашлось только три [98]. Для сравнения обзор приводит больничные данные: по нарративному обзору Williams и Walton (2011), медиана отходов с тарелки в 32 исследованиях составила 30 % [99]; в больничной литературе допустимым называют уровень 5–20 % в зависимости от системы подачи. Разброс в самих учреждениях ухода велик: в австралийском отчёте Byles и соавт. (2009), включённом в обзор, отходы с тарелки составили 7,5–24 % при первом и 4–15 % при втором измерении; в шведской работе Eriksson и соавт. (2017) — 23 % (13–34 %) [98]. Общепринятого целевого уровня для учреждений длительного ухода обзор не устанавливает.

Отходы с тарелки измеряют не только для оценки меню, но и для расчёта фактически съеденного. Японское исследование CLEVER (Nishida и соавт., 2020) проверило этот расчёт на 46 жителях учреждений длительного ухода, сравнив потребление энергии, вычисленное по рецептурам и отходам с тарелки за 14–15 дней, с потреблением, определённым методом дважды меченой воды [100]. Расчёт по рецептурам и отходам превышал фактическое потребление в среднем на 232 ккал в сутки

(15,3 %); в подгруппе, наблюдавшейся 12 месяцев, у жителей, терявших массу, расчётный «запас» энергии был меньше (медиана 152 ккал/сут), чем у набиравших массу (350 ккал/сут) [100]. Вывод авторов: потеря массы возможна, даже если расчёт по меню и отходам показывает положительный баланс. Для доклада отсюда двойное предупреждение: выполнение норм по раскладке не гарантирует, что житель съел положенное, а снижение отходов после введения выбора — ещё не доказательство роста потребления (толкование).

Отходы с тарелки — самый доступный российскому учреждению показатель результата: их можно измерять визуальной шкалой или взвешиванием без лабораторных исследований и без медицинской лицензии. Сопоставление отходов до и после введения выбора — минимальная доказательная база, которую учреждение может собрать само (рекомендация, см. п. 7.9).

5.10 Текстуры и ограничения выбора

Канадское поперечное исследование M3 (Making the Most of Mealtimes; 32 дома длительного ухода в четырёх провинциях) показало, что пища изменённой консистенции назначена 47 % из 639 участников (298 человек); такие жители чаще имели дисфагию, риск недостаточности питания, деменцию и зависимость в повседневной активности [101]. Число дано как контекст, а не как оценка для России: публично долю таких жителей в российском ПНИ или доме-интернате никто не измерял. Вместе с работой Abbey и соавт. [81] оно показывает, что вариативное меню, придуманное для ходячих и говорящих жителей, может не дойти до половины дома. Решения о консистенции — клинические и в этом докладе не рассматриваются.

5.11 Организационные факторы

Porter, Ottrey и Huggins (2017) проанализировали защищённое время приёма пищи (protected mealtimes) — запрет на неотложные процедуры во время еды; доказательства его эффекта на потребление оказались неоднородными [102]. Namasaki и соавт. (2023, Япония) в когорте из 2909 жителей 235 домов длительного ухода на данных страховых требований префектуры Ибараки (2018–2019) показали, что большее число диетологов в штате связано с меньшей вероятностью потенциально предотвратимых госпитализаций в первые 180 дней после поступления (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97) [103]. Связь наблюдательная и причинности не доказывает, но согласуется с мыслью, что качество питания зависит от кадров не меньше, чем от норм. Keller и соавт. (2022) переложили рекомендации по питанию в учреждениях длительного ухода на 27 практических мер и оценили их осуществимость: высоко осуществимыми признаны 6 мер, умеренно — 12, низко — 9, главным образом из-за потребности в дополнительном или квалифицированном персонале, финансировании и инфраструктуре; авторы делают вывод, что без государственного финансирования, политики и стандартов улучшение питания в учреждениях ограничено [104].

5.12 Время персонала: сколько стоит помощь при еде

В учреждениях, где много жителей не едят самостоятельно, судьба вариативного меню решается персоналом. Самые подробные данные о нужном для этого времени получены группой Simmons и Schnelle в американских домах сестринского ухода в 2001–2008 гг. Во всех работах исследовательский персонал оказывал помощь по стандартизированному протоколу, включавшему социальное взаимодействие во время еды и предоставление выбора блюд и напитков, а время измерялось прямым наблюдением.

Работа	Выборка	Время при протоколе помощи	Время при обычном уходе	Доля жителей, ответивших ростом потребления
Simmons и соавт., 2001 [105]	74 жителя, 3 дома	38 мин на жителя за приём пищи	9 мин	50 %
Simmons, Schnelle, 2004 [106]	134 жителя, 3 дома	35 ± 8 мин за приём пищи; 12 ± 6 мин за перекус между приёмами	6 ± 9 мин; 1 ± 4 мин	46 % (помощь во время еды); 44 % остальных (перекусы); 90 % — на одно из двух вмешательств
Simmons, Schnelle, 2006 [107]	91 житель, 6 домов	35–40 мин за приём пищи при любом уровне зависимости	—	Отобраны ответившие
Simmons и соавт., 2008 [108]	76 жителей, 4 дома; перекрёстное контролируемое исследование, 24 недели	42 мин за приём пищи; 13 мин за перекус	5 мин; менее 1 мин	Рост калорийности рациона и стабилизация или прирост массы в периоде вмешательства

Для российского учреждения из этих работ следуют три наблюдения. Первое: жителю, которому нужна только словесная подсказка и присутствие сотрудника, требовалось столько же времени (35–40 минут на приём пищи), сколько физически зависимому [107]; авторы заключают, что американская система оплаты ухода, учитывающая главным образом физическую зависимость, недооценивает это время. Второе: разрыв между временем, которое реально тратилось (5–9 минут), и временем, которое давало эффект (35–42 минуты), составлял четыре-восемь раз [105, 106, 108]. Третье: перекус между приёмами пищи с выбором требовал втрое-вчетверо меньше времени, чем помощь во время еды, и помогал почти половине тех, кому не помогла помощь во время еды [106, 108]; авторы считают его более осуществимым в повседневной практике.

Перенос на российские условия ограничен (толкование): другие штатные нормативы, другой состав жителей, исследования проведены 18–25 лет назад. Но порядок величин помогает проверить реализм замысла. Если в отделении 30 жителей и треть из них нуждается в подсказке или помощи, протокол уровня Simmons потребовал бы около 6–7 часов рабочего времени персонала на один приём пищи (иллюстра-

тивная арифметика: 10 × 38–42 мин). Вариативное меню само по себе этого времени не создаёт и не отменяет: выбор между двумя блюдами для жителя, которого нужно кормить, требует сначала времени на помощь, а уже потом — на выбор (п. 7.15).

5.13 Стоимость

Hugo и соавт. (2018) опросили 817 австралийских учреждений длительного ухода. Средняя стоимость кейтеринга составила 8,00 австралийского доллара на жителя в день, из них на продукты (сырьё) — 6,08 доллара [109]. В докладе «Не просто накормить» 8 долларов названы стоимостью сырья [20]; по тексту статьи это стоимость всего кейтеринга. Вторая редакция это уточняет.

Прямо пересчитывать австралийские цифры в рубли нельзя: различаются цены, состав затрат и устройство учреждений. Значимо соотношение: в исследовании Wheeler и соавт. переход на выбор в момент еды увеличил стоимость примерно на 9–20 % (нижняя граница диапазона выросла на 20 %, верхняя — на 9 %; расчёт автора по данным [78]). Российских опубликованных расчётов стоимости вариативного меню не найдено.

5.14 Чего наука не знает

Рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрических учреждениях длительного пребывания, аналогичных российским ПНИ, найти не удалось. Почти все данные получены в домах престарелых Австралии, Европы и Северной Америки, где жители старше, а доля людей с психическими расстройствами без деменции ниже. Перенос выводов на ПНИ — экстраполяция.

Нет исследований, сравнивающих разные числа вариантов (два, три, семь) в одном дизайне. Нет данных о том, как выбор влияет на пищевое поведение людей с интеллектуальными нарушениями в учреждениях; опасение, что такие жители будут систематически выбирать «вредное», остаётся непроверенным предположением. Все исследования стоимости проведены в странах, где питание финансируется иначе, чем через российское государственное задание. Расчёты времени персонала на помощь при еде (п. 5.12) получены в американских домах сестринского ухода 2001–2008 гг. и в российских учреждениях не воспроизводились. Наконец, нет исследований, которые измеряли бы, получает ли выбор житель, не способный его выразить, — качественные работы лишь описывают, что такие жители выбором пользуются реже [86].

5.15 Сводная таблица

Работа	Страна, дизайн	Выборка	Ключевой результат	Ограничения
Cereda и соавт., 2016 [79]	Метаанализ	240 иссл., 113 967 чел.	Недостаточность питания 17,5 % в домах престарелых, 28,7 % в LTC	Разнородность выборок

Работа	Страна, дизайн	Выборка	Ключевой результат	Ограничения
Горелик и соавт., 2020 [38]	Россия, наблюдение	97	Риск 72,1 %, недостаточность 10,4 %	Нет контроля
Wright и соавт., 2013 [80]	Австралия, поперечное	313	Больше вариантов и выбор ближе к еде — выше удовлетворённость	Поперечный дизайн
Abbey и соавт., 2015 [81]	Австралия, поперечное	247 учреждений; 161 меню; 36 приёмов пищи	Выбор низок, особенно при протёртой пище	Описательный дизайн
Nijs и соавт., 2006 [28]	Нидерланды, кластерное РКИ	178	КЖ +6,1; масса +1,5 кг	Без деменции; комплексное вмешательство
Croghan и соавт., 2013 [87]	США, два дома, без рандомизации	61 (33 + 28)	Рост преальбумина и массы	Без рандомизации
Divert и соавт., 2015 [88]	Франция, эксперимент	42 жителя, 12 обедов	Разнообразие на тарелке и приправы помогают; названия и декор — нет	Малая выборка
Abbott и соавт., 2013 [90]	Систематический обзор	37 работ	+181 ккал/сут ($p = 0,06$); масса — без эффекта	Неоднородность
Herke и соавт., 2018 [91]	Кокрейновский обзор	9 РКИ, 1502	Низкая доказательность	Деменция
Wheeler и соавт., 2025 [78]	Австралия, до/после	Одно учреждение	Удовлетворённость 3,60 → 4,57; белок +5 г на приём пищи; стоимость +9–20 %	Одно учреждение
Roulston и соавт., 2026 [98]	Обзор	33 источника	Отходы с тарелки — основной измеритель; интервенций всего три	Разные методы измерения
Hamasaki и соавт., 2023 [103]	Япония, когорта	2909	Больше диетологов — меньше предотвратимых госпитализаций (HR 0,72)	Наблюдательный дизайн
Teasdale и соавт., 2019 [93]	Метаанализ	58 исследований	При ТПР энергия +1332 кДж/сут, натрий +322 мг	Не учреждения; не выбор
McCray и соавт., 2018 [83]	Австралия, больница, до/после	Аудиты	Room service: потребление и удовлетворённость выше, отходы и стоимость ниже	Больничный контекст

Работа	Страна, дизайн	Выборка	Ключевой результат	Ограничения
Kenkmann и соавт., 2010 [89]	Великобритания, 3 + 3 дома, до/после	120	Падения –24 % (RR 0,76; p = 0,06) при пакете «выбор, ресторан, закуски»	Пропуски данных, малая мощность
Wang и соавт., 2020 [84]	Австралия, качественное	7 жителей + 7 сотрудников	«Питание на массу», организационные барьеры выбору	Две организации
Bailey и соавт., 2017 [85]	Австралия, качественное	6 жителей	Желание решать самим при незначении регламентов о рисках	Малая выборка
Mondkar и соавт., 2025 [86]	Великобритания, качественное	17 человек, 4 дома	Выбор зависит от способности попросить, денег, мобильности, родных	Один округ
Roos и соавт., 2022 [92]	Швеция, национальные опросы	12 620–13 763 в год	Приятная среда приёма пищи связана с удовлетворённостью достоинством	Наблюдательный; среда в целом
Nishida и соавт., 2020 [100]	Япония, сравнение методов	46	Расчёт по меню и отходам превышает потребление на 232 ккал/сут (15,3 %)	Малая выборка
Simmons и соавт., 2001–2008 [105–108]	США, серия исследований	74–134	Эффективная помощь при еде 35–42 мин на жителя за приём пищи против 5–9 мин при обычном уходе	Исследовательский персонал; давность

6 Зарубежное регулирование

6.1 Зачем и с какой осторожностью

Зарубежные нормы в России не действуют, и ссылкой на них нельзя заменить российское основание для решения учреждения. Ценны они другим: показывают, какие формулировки права на выбор оказались юридически работоспособными, какие измеримые требования к питанию в учреждениях длительного ухода ставят другие порядки и где эти требования упираются в те же противоречия, что и у нас. Первая редакция обзора упоминала зарубежный опыт кратко и включала раздел о «практике стран СНГ» без источников [1]; вторая редакция этот раздел не повторяет, а зарубежный блок строит по первоисточникам.

6.2 Англия: регламент CQC

Регламент 2014 г. о регулируемой деятельности в здравоохранении и социальном уходе (The Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014), надзор за исполнением которого осуществляет Care Quality Commission, в регламенте 14 «Meeting nutritional and hydration needs» определяет потребности в питании как совокупность четырёх элементов: получение подходящей и питательной пищи и питья, достаточных для поддержания жизни и здоровья; получение парентерального питания и пищевых добавок по назначению специалиста; удовлетворение «любых разумных требований» получателя услуг к еде и питью, вытекающих из его предпочтений или религиозной и культурной принадлежности; помощь в еде и питье, если она нужна [110].

Конструкция поучительна тремя чертами. Предпочтения названы частью «потребности в питании», а не дополнительной услугой. Требования ограничены критерием разумности. Регламент 14(3) ставит пределы: обязанность не применяется, если её исполнение нарушило бы требование о согласии (регламент 11) или противоречило бы наилучшим интересам человека, определяемым по Закону о дееспособности 2005 г. [110]. Коллизию «выбор против здоровья» английское право решает процедурой оценки наилучших интересов, а не запретом выбора.

Как регламент раскрыт в руководстве регулятора. Руководство CQC к регламенту 14 (в редакции страницы от 16.05.2025), которое поставщики обязаны принимать во внимание, переводит общую формулу в конкретные ожидания: у поставщика должна быть стратегия питания; «люди должны иметь возможность делать выбор в отношении своего рациона»; религиозные и культурные потребности выявляются при оценке потребностей в питании и должны быть удовлетворены, а при клинических противопоказаниях обсуждаются с человеком, чтобы он мог сделать информированный выбор; этические требования, например вегетарианство, «должны быть полностью учтены и удовлетворены»; следует прилагать все усилия, чтобы учитывать предпочтения, в том числе о времени, месте подачи и количестве еды [111]. Там же — организационные требования, прямо относящиеся к раздаче: если человек отсутствовал или спал во время приёма пищи, ему должны обеспечить еду в другое время; между приёмами пищи должны быть доступны перекусы для тех, кто предпочи-

тает есть «понемногу и часто»; еда должна сохранять нужную температуру в течение всего приёма пищи; каждому, кому нужна помощь, должно хватать времени [111]. Нарушение регламента 14, повлёкшее предотвратимый вред или значительный риск вреда, позволяет CQC возбудить уголовное преследование без предварительного предупреждения [111].

Российскому читателю здесь важно соотношение уровней: выбор закреплён не в отдельном «стандарте меню», а в определении потребности в питании, нарушение которой может иметь уголовные последствия. Российский аналог по месту в системе — стандарт социальной услуги по обеспечению питанием в региональном порядке, но его содержание в проанализированных регионах ограничивается нормами продуктов (п. 3.15) (толкование).

6.3 Шотландия: стандарты здравоохранения и социального ухода

Стандарты здравоохранения и социального ухода Шотландии (Health and Social Care Standards, 2017) сформулированы от первого лица. Стандарт 1.33: «Я могу выбирать подходящие, хорошо поданные и здоровые блюда и перекусы, включая свежие фрукты и овощи, и участвовать в планировании меню». Соседние стандарты 1.34–1.39 касаются достойной помощи при еде, возможности есть не спеша, совместной еды, учёта культурных и религиозных потребностей, возможности готовить самому и доступа к воде в любое время [112]. Методические материалы Care Inspectorate по питанию в учреждениях ухода содержат практические ориентиры, в том числе интервал не менее четырёх часов между основными приёмами пищи [112].

Шотландские стандарты — прецедент формулировки права, удобной для проверки: проверяющий спрашивает жителя, может ли он выбирать, и сопоставляет ответ с наблюдением. Российские нормы, напротив, обращены к учреждению и измеряются граммами.

6.4 США: федеральные требования к домам сестринского ухода

Требования к домам сестринского ухода, участвующим в программах Medicare и Medicaid (42 CFR § 483.60), обязывают обеспечить каждому жителю питательную, вкусную, сбалансированную диету «с учётом предпочтений каждого жителя» [113]. Меню должны составляться заранее и соблюдаться, отражать религиозные, культурные и этнические потребности и мнения жителей и их объединений, пересматриваться диетологом; при этом прямо сказано, что ничто в требованиях к меню не ограничивает права жителя на личный выбор в питании (§ 483.60(c)(7)). Жителю, который отказывается от поданного блюда или просит другое, должны предлагаться привлекательные альтернативы сходной пищевой ценности (§ 483.60(d)(5)). Пища должна учитывать аллергии, непереносимость и предпочтения. Между полноценным ужином и завтраком должно проходить не более 14 часов; если перед сном подаётся питательный перекус и группа жителей согласна, — до 16 часов. Жителям, желающим есть вне установленного времени, должны предоставляться подходящие альтернативные блюда и перекусы [113].

Американская норма — самый точный зарубежный аналог российского «вариативного меню»: она требует не выбора из двух блюд на каждый приём пищи, а гарантированной альтернативы «сходной пищевой ценности» по запросу. Вопрос о соблюдении норм тем самым снят: альтернатива по определению равноценна основному блюду.

Как требование проверяется. Руководство для инспекторов CMS (приложение PP к State Operations Manual) раскрывает § 483.60(d)(4)–(5) в позиции F806 «Аллергии, предпочтения и замены жителя» [114]. Замена должна соответствовать «обычному ассортименту» учреждения: пример руководства — вместо грейпфрутового сока предложить другой цитрусовый или богатый витамином С сок, который житель любит [114]. Процедура проверки: наблюдать за раздачей и, если житель отказывается от блюда или напитка, установить, предложили ли ему замену; опросные вопросы — как еда соответствует предпочтениям жителя, предлагают ли замену при отказе, как жителям сообщают об альтернативах, как сведения о предпочтениях доходят до персонала [114]. При выявлении нарушения инспектору предлагается проверить смежные требования: учтены ли предпочтения при комплексной оценке жителя, включены ли в план ухода, пересматривался ли план с участием жителя или его представителя [114]. Форма наблюдения за приёмом пищи (CMS-20053) отдельно предписывает начинать наблюдение с первого приёма пищи после прибытия проверяющих, в первую очередь в залах, где больше всего жителей, нуждающихся в помощи, и в разделе «Выбор» — выяснять реакцию персонала на отказ идти в столовую, отказ от блюда или просьбу о замене [115]. В той же форме перечислены признаки соблюдения достоинства: всем за столом подают одновременно; посуда и приборы не одноразовые; тарелки не убирают, пока за столом не доели все; помогающий сидит рядом, а не стоит над жителем, и разговаривает с ним, а не с коллегами; жителю дают столько времени, сколько ему нужно [115].

Американская процедура показывает, что выбор можно проверить, не считая блюд в меню: предмет проверки — ответ учреждения на отказ конкретного жителя, наблюдаемый в реальном приёме пищи и подтверждаемый опросом.

6.5 Канада, Онтарио: регламент о долговременном уходе

Регламент Онтарио O. Reg. 246/22 к Закону о совершенствовании долговременного ухода 2021 г. (Fixing Long-Term Care Act) в разделе 77 устанавливает требования к меню [116]. Цикл меню должен длиться не менее 21 дня и включать меню для обычного, лечебного и изменённого по консистенции питания; на каждом приёме пищи и перекусе предлагается выбор напитков; на каждом из трёх основных приёмов — не менее одного основного блюда и гарнира, а также выбор других основных блюд и гарниров, «чтобы удовлетворить конкретные потребности или пищевые предпочтения жителей»; на обед и ужин — десерт и выбор других десертов; выбор перекусов днём и вечером. До введения в действие каждый цикл рассматривается советом жителей, оценивается менеджером по питанию и диетологом и утверждается диетологом с учётом предпочтений жителей и норм потребления; результаты оценки документируются. Время приёма пищи согласуется с советом жителей; еда и напитки,

включая воду, соответствующие рациону жителей, доступны круглосуточно; для жителя, чьи потребности не покрываются циклом, разрабатывается индивидуальное меню [116].

Онтарийская норма показывает, что выбор и цикличность совместимы: цикл в 21 день сам предусматривает альтернативы на каждом приёме пищи. Видно в ней и разграничение, которого нет в российском праве: вариативность (выбор в рамках цикла для всех) и персонализация (индивидуальное меню для того, кому цикл не подходит) закреплены в разных пунктах одного раздела.

Протокол проверки. Протокол инспекции «Наблюдение за приёмом пищи» Министерства здравоохранения и долгосрочного ухода Онтарио (редакция мая 2019 г., составлен ещё по прежнему регламенту O. Reg. 79/10; на 05.10.2026 на портале министерства размещена именно она, обновлённой редакции по O. Reg. 246/22 найти не удалось) переводит требования к меню в закрытые вопросы «да / нет / неприменимо» со ссылкой на пункт регламента: сообщаются ли жителям дневное и недельное меню; включает ли цикл меню альтернативные основные блюда, овощи и десерты на обед и ужин и альтернативные напитки; предлагаются ли и имеются ли в наличии запланированные блюда в каждый приём пищи; подаётся ли еда по блюдам, если житель не просил иного; достаточно ли времени, чтобы есть в своём темпе; помогает ли сотрудник одновременно не более чем одному-двум жителям, нуждающимся в полной помощи; подают ли еду жителю, которому нужна помощь, только когда помогающий свободен; рассматривал ли совет жителей время приёмов пищи и перекусов; сообщаются ли все замены в меню жителям и персоналу [117].

Российскому учреждению протокол полезен как готовый образец формулировок внутреннего контроля (п. 8.13): каждый вопрос наблюдаем за один приём пищи и привязан к конкретной норме.

6.6 Австралия: усиленные стандарты качества

С 01.11.2025, с вступлением в силу Закона об уходе за пожилыми 2024 г., в Австралии действуют усиленные стандарты качества; стандарт 6 посвящён питанию и включает право человека влиять на то, что, когда, где и как он ест [118]. До реформы федеральное правительство с 2021 г. выплачивало учреждениям надбавку к базовой суточной плате в размере 10 австралийских долларов на жителя в день при условии отчётности о расходах на питание [118]. В Австралии выбор в питании стал предметом государственного стандарта после серии исследований, показавших, как мало его на деле [81].

6.7 Германия и Австрия: стандарты профессиональных обществ

Стандарт качества Немецкого общества питания (DGE) для питания с доставкой на дом и в учреждениях для пожилых (DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung mit „Essen auf Rädern“ und in Senioreneinrichtungen; 1-е изд., исправленная перепечатка

2022 г.) — рекомендация профессионального общества, а не закон [119]. Для российской дискуссии он ценен тем, что описывает выбор не как принцип, а как набор проверяемых операционных требований:

- **несколько линий меню.** Стандарт исходит из того, что учреждение предлагает несколько «линий меню» (Menülinien), и требует, чтобы как минимум одна из них соответствовала критериям здорового и устойчивого питания, — «так клиенты и жители могут выбирать из соответствующего предложения» [119]. На плане меню несколько линий должны быть представлены наглядно, а рекомендуемая — выделена (первой строкой, цветом или символом) [119];
- **вегетарианский вариант ежедневно.** Ово-лакто-вегетарианское предложение должно быть доступно ежедневно на всех приёмах пищи и обеспечивать столь же разнообразный выбор, как обычное; простое удаление мясного компонента из блюда стандарт считает недостаточным [119];
- **цикл меню.** Цикл обеда повторяется не ранее чем через шесть недель в учреждениях для пожилых и не ранее чем через четыре недели при доставке на дом [119]. В предыдущей версии второй редакции доклада для учреждений было указано «не менее четырёх недель»; по тексту стандарта это значение относится к доставке на дом (исправлено, см. Приложение В);
- **тёплый компонент вне обеда.** Должна быть возможность выбрать тёплый компонент на завтрак или ужин [119];
- **понятность плана меню.** Основные компоненты блюда указываются в плане меню, если название их не раскрывает; для мясных и рыбных блюд указывается вид животного; рекомендуется дополнять план изображениями блюд, что облегчает выбор людям с когнитивными нарушениями [119];
- **учёт пожеланий.** Пожелания и критика жителей учитываются при планировании «насколько возможно»; канал — личные беседы, анкеты или совет жителей (Heimbeirat); для тех, кто едва может выразить пожелание, ориентиром служит пищевая биография (Essbiografie), которую рекомендуется собирать при поступлении [119];
- **еда по желанию в особых ситуациях.** При стойкой потере аппетита, недостаточности питания, тяжёлой болезни и в терминальной фазе стандарт предусматривает «полностью основанное на желаниях» питание (Wunschkost), выбор которого специалист по питанию согласовывает с жителем лично [119];
- **гибкость времени.** Жителям, пропустившим приём пищи, даётся возможность получить его позже; люди с инвертированным ритмом сна и бодрствования должны получать основные и промежуточные приёмы пищи по своему ритму [119];
- **контроль возвратов.** Учёт возвращённой еды (Speiserückläufe) служит основой для корректировки плана меню, приготовления и подачи и помогает выявлять непопулярные блюда и неверно рассчитанные порции [119];
- **время раздачи.** Время горячего удержания от окончания приготовления до выдачи последнему гостю — не более трёх часов [119], то есть то же ограничение, что в п. 32 СанПиН 4282-26 [3].

Из этого перечня российскому учреждению легче всего перенести четыре элемента (рекомендация): план меню с указанием основных компонентов и, где это нужно, с изображениями; пищевая биография при поступлении как основа решений за тех, кто не может выразить выбор; учёт возвратов по каждому блюду; выделение в плане меню варианта, который учреждение считает предпочтительным, вместо запрета других вариантов. Последний приём — «подталкивание» (nudging) — стандарт DGE прямо рассматривает как альтернативу ограничению выбора [119].

Австрийские стандарты качества питания в учреждениях ухода (2022) по аналогии рекомендуют учитывать предпочтения и избегать необоснованных ограничений рациона [120].

6.8 Швеция: национальные рекомендации и критерии влияния жителя

Национальное продовольственное агентство Швеции (Livsmedelsverket) выпустило национальные рекомендации по питанию в системе ухода за пожилыми в 2019 г. и обновило их в мае 2024 г. [121]. Их операционный слой складывается из нескольких элементов.

Ночной перерыв. Перерыв между последним вечерним и первым утренним приёмом пищи — не более 11 часов; приёмы пищи должны быть многочисленными, небольшими, насыщенными энергией и белком и распределёнными по суткам [121]. Это ориентир, а не обязательная норма; российскому учреждению он полезен в сопоставлении с американским пределом 14–16 часов и с рекомендацией постановления № 12 не допускать длительного перерыва между ужином и завтраком [29].

Приоритет съеденного над расчётным. Рекомендации формулируют принцип, прямо относящийся к спору о вариативном меню: поскольку еда приносит пользу, только если съедена, «важнее, чтобы еда была вкусной и возбуждала аппетит, чем чтобы она точно соответствовала нормам питания» [121]. Тезис обращён к планированию рациона для групп с плохим аппетитом и норм не отменяет, но задаёт иерархию, обратную российскому контролю по раскладке (толкование).

Критерии влияния жителя. Рекомендации воспроизводят критерии качества, разработанные Национальным советом здравоохранения и социального обеспечения (Socialstyrelsen) для руководства по закупкам услуг ухода (2013): житель сам ощущает, что влияет на ситуацию приёма пищи; может влиять на время приёма пищи; на обстановку; на то, какие блюда, перекусы и напитки подаются и доступны, исходя из индивидуальных привычек, традиций и пожеланий; персонал замечает индивидуальные потребности; ситуация приёма пищи похожа на домашнюю [121]. Здесь «выбор» переведён в формулировки, пригодные для договора и проверки, причём первым критерием стоит ощущение самого жителя.

Совет по питанию. Рекомендации предлагают создавать в учреждениях советы по питанию (måltidsråd) с участием персонала, жителей и родственников, которые могут предлагать, каким должно быть меню и как сделать приём пищи спокойным [121].

Базовое меню и закупка. Первый из пяти шагов планирования — создать «базовое меню» (grundmenu) из популярных блюд в небольших насыщенных порциях; при этом «может понадобиться несколько блюд на выбор, а также несколько альтернативных гарниров» как в основных приёмах пищи, так и в перекусах [121]. Базовое меню служит одновременно для расчёта пищевой ценности на уровне группы, для учёта потребления, для внутренних расчётов и для закупки [121]. Второй шаг — готовить в объёме, который реально съедается, и строить систему заказа так, чтобы минимизировать отходы [121]. Так снимается российский вопрос о совместимости выбора с нормами (п. 3.15) и с закупкой (п. 7.13): нормы проверяют по базовому меню на уровне группы, а выбор живёт внутри него.

Ресторан и стол. Общий ресторан в учреждении рекомендации рассматривают как способ расширить свободу выбора: более длинное время подачи, больше вариантов, возможность выбрать соседей по столу; но тут же отмечают, что большинство жителей предпочитает постоянный круг сотрапезников и небольшие помещения, особенно люди со сниженным слухом и деменцией [121].

6.9 Дания: право отказаться от отдельного приёма пищи

В датской модели питание в доме престарелых (plejehjem, plejebolig) оформлено как отдельно назначаемая и оплачиваемая услуга — «служба питания» (madservice) по § 83 Закона о социальных услугах, с законодательно ограниченным максимумом платы жителя [122]. В 2024 г. Апелляционное управление (Ankestyrelsen), рассматривая в порядке надзора стандарт качества коммуны Фредерисия, установило, что коммуна действует вопреки закону, когда позволяет жителям дома престарелых отказываться от питания только целыми днями (с уведомлением до 12 часов предыдущего дня) и не позволяет отказываться от отдельных приёмов пищи [122]. Опираясь на подготовительные материалы к законам 2009–2010 гг. и на заключение министерства, Ankestyrelsen исходило из того, что служба питания должна отличаться «высоким качеством и свободой выбора» и вниманием к индивидуальным пожеланиям, а отказ от отдельных приёмов пищи с соразмерным снижением платы предполагается законом; коммуна вправе лишь установить разумные сроки уведомления [122].

Здесь выбор понят не как выбор блюда, а как право не участвовать в общем питании в конкретный приём. В российском праве ближайшая конструкция — отказ от социальной услуги (ст. 18 442-ФЗ) [22], но он относится к услуге в целом, а не к отдельному приёму пищи, и плата за стационарное обслуживание не зависит от числа съеденных приёмов (толкование). Датский пример приведён не как образец для заимствования: он показывает, что в разных правовых порядках выбор в питании решают на уровне платы и договора, а не только меню.

6.10 Япония: управление питанием и «особое питание» по выбору

В Японии с 2005 г. в системе страхования длительного ухода оплачивается управление питанием (栄養マネジメント) в учреждениях, а с 2021 г. действует система сбора данных LIFE (Long-term care Information system For Evidence), в которую учреждения передают сведения о пищевом статусе жителей [123]. Это путь финансового стимула: платят за измерение и управление питанием.

Второй японский механизм прямо касается выбора. С 01.10.2005 плата за питание в учреждениях страхования ухода определяется по принципу «стоимость продуктов плюс стоимость приготовления», а плата за «особое питание, выбранное пользователем» (特別な食事), должна взиматься отдельно и чётко отделяться от обычной платы [124]. Критерии такого питания установлены приказом-уведомлением № 123 [125]:

- особое питание использует дорогие продукты или особое приготовление, которые невозможно обеспечить за обычную плату; взимается только разница между его стоимостью и обычной платой за питание;
- учреждение обеспечивает управление питанием каждого пользователя диетологом во взаимодействии с врачом и гигиену обстановки приёма пищи; предоставление особого питания **не должно ухудшать качества обычного питания**;
- особое питание предоставляется на основе свободного выбора и согласия пользователя после достаточного информирования, в определённые дни по предварительному выбору; его подача против воли пользователя не допускается;
- в учреждении и на его сайте вывешиваются сведения о том, что особое питание доступно ежедневно или в определённые дни, о его содержании и цене;
- требуется подтверждение врача, что особое питание не противопоказано пользователю по состоянию здоровья;
- договор заключается после ясного объяснения, что это дополнительная плата сверх обычной [125].

Японская конструкция разводит два вопроса, которые в российской дискуссии часто смешивают: базовое питание, качество которого гарантировано и не может ухудшаться, и выбор сверх базового уровня за дополнительную плату с процедурными гарантиями. Для российского учреждения прямой аналогии нет: питание в стационарной форме входит в социальную услугу, оплачиваемую в пределах 75 % среднедушевого дохода получателя (ч. 4 ст. 32 442-ФЗ) [22], а платные услуги сверх стандарта требуют отдельного правового основания (толкование). Ценен сам перечень гарантий: запрет ухудшения базового меню, информирование, согласие, медицинский фильтр и публичная цена.

6.11 Сводная таблица

Правопорядок	Акт	Формулировка выбора	Измеримые требования	Юридическая сила
Англия	Регламенты 2014 г., рег. 14 [110]	Разумные требования из предпочтений, религии, культуры — часть потребности в питании	Ограничение наилучшими интересами	Обязательна
Шотландия	Health and Social Care Standards 2017, 1.33–1.39 [112]	«Я могу выбирать... и участвовать в планировании меню»	Вода в любое время; ориентир 4 ч между приёмами	Стандарты, учитываются при инспекции
США	42 CFR § 483.60 [113]	Альтернатива сходной пищевой ценности по запросу	≤14 ч (16 ч с перекусом)	Обязательна для участников Medicare/Medicaid
Онтарио	O. Reg. 246/22, разд. 77 [116]	Выбор основных блюд, гарниров, напитков на каждом приёме; десертов и перекусов	Цикл ≥21 дня; рассмотрение советом жителей; индивидуальное меню	Обязательна
Австралия	Усиленные стандарты качества, стандарт 6 [118]	Влиять на что, когда, где и как есть	Отчётность о расходах на питание	Обязательна
Германия	Стандарт DGE [119]	Несколько линий меню; ежедневный вегетарианский вариант; пищевая биография; еда по желанию в особых ситуациях	Цикл обеда ≥6 недель (≥4 при доставке на дом); горячее удержание ≤3 ч; учёт возвратов	Рекомендация
Швеция	Рекомендации Livsmedelsverket [121]	Влияние на блюда, время и обстановку (критерии Socialstyrelsen); несколько блюд и гарниров в базовом меню	Ночной перерыв ≤11 ч; совет по питанию	Рекомендация
Дания	§ 83 Закона о социальных услугах; надзорное заключение Ankestyrelsen 2024 г. [122]	Отказ от отдельных приёмов пищи со снижением платы	Потолок платы; сроки уведомления устанавливает коммуна	Обязательна
Япония	Система страхования ухода; LIFE [123]; приказы-уведомления № 419 и № 123 [124, 125]	«Особое питание» по выбору за дополнительную плату	Без ухудшения обычного питания; согласие; врач; публичная цена	Обязательны

Правопорядок	Акт	Формулировка выбора	Измеримые требования	Юридическая сила
Россия	442-ФЗ, 935н, Сан-ПиН 4282-26, региональные нормы	Нет нормы о выборе блюд	Не менее 3 приёмов пищи; нормы в граммах	Обязательны

6.12 Выводы для российской дискуссии

Ни одна из рассмотренных систем, кроме Онтарио, не требует выбора на каждом приёме пищи; онтарийская норма при этом не фиксирует число вариантов. Общий знаменатель другой: учёт предпочтений как часть понятия адекватного питания (Англия, США), альтернатива эквивалентной пищевой ценности (США), участие жителей в планировании меню (Шотландия, США, Онтарио) и процедуры, в которых меню с выбором проверяет и утверждает диетолог (Онтарио, США), а питание измеряется и оплачивается как управляемый процесс (Япония). Расширенный обзор этой редакции добавляет три операционных приёма, для которых не нужно менять законы: несколько «линий меню» с выделением рекомендуемой вместо запрета остальных (Германия); базовое меню, по которому проверяются нормы на уровне группы, с вариантами внутри него (Швеция); и критерии влияния жителя на приём пищи, сформулированные для договора и проверки, где первым стоит субъективное ощущение самого жителя (Швеция). Датский и японский примеры показывают другой уровень вопроса — плату: право отказаться от приёма пищи со снижением платы и выбор сверх базового уровня за доплату при запрете ухудшать базовый уровень. Для российского нормотворца — если он решит регулировать выбор — американская формула «альтернатива сходной пищевой ценности» снимает основное возражение о несовместимости выбора с нормами, а онтарийская процедура утверждения цикла диетологом с участием совета жителей отвечает на опасение о вреде выбора (рекомендация автора; не позиция какого-либо органа).

7 Практика: шестнадцать операционных сценариев

7.1 Как читать раздел

Сценарии ниже описывают решения, которые учреждение вправе принять само, не выходя за действующие нормы. В конце каждого сказано, что в нём норма, что толкование, что рекомендация. Числовые примеры — иллюстративная арифметика автора на основе норм постановления № 1284 и таблицы замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26; это не расчёты конкретного учреждения и не данные о фактических затратах. Клинических решений (диеты, консистенции, назначения) сценарии не касаются: где такой вопрос возникает, сказано, что решает врач.

7.2 Сценарий 1. Два вторых блюда в пределах нормы № 1284

Задача. Ввести на обед три дня в неделю выбор между мясным и рыбным вторым блюдом, не нарушив нормы питания.

Что говорит норма. Постановление № 1284 устанавливает суточные количества по группам продуктов: для домов-интернатов общего типа мясо (говядина, свинина) — 90 г нетто, рыба — 41,8 г нетто, птица — 40 г нетто [31]. Норма суточная, но учреждения обычно контролируют её по среднему за период (неделя, декада, месяц) через накопительную ведомость. Способ контроля в постановлении не определён (п. 3.15).

Иллюстрация. Учреждение на 100 жителей. Недельная потребность по норме: мясо $90 \times 7 \times 100 = 63,0$ кг нетто, рыба $41,8 \times 7 \times 100 = 29,26$ кг нетто. Пусть в базовом меню все три дня на обед подают мясное второе с закладкой 75 г нетто мяса на порцию, а альтернативой вводят рыбу (треску). По таблице замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26 100 г говядины эквивалентны по пищевой ценности 125 г трески [3]; следовательно, 75 г говядины соответствуют примерно 94 г трески. Если рыбу выберут 40 % жителей, за неделю расход мяса уменьшится на $0,4 \times 100 \times 75 \text{ г} \times 3 = 9,0$ кг, расход рыбы увеличится на $0,4 \times 100 \times 94 \text{ г} \times 3 \approx 11,3$ кг. Итог недели: мясо 54,0 кг (85,7 % нормы), рыба 40,5 кг (138,6 % нормы).

Вывод из иллюстрации. По пищевой ценности замена эквивалентна; по групповой норме — нет: мясо недовыполнено на 14 %, рыба перевыполнена на 39 %. Проверяющий, который сверяет нормы по группам, это расхождение увидит. Снять его можно тремя способами:

1. Закрепить в локальном акте учреждения, что выполнение норм оценивается с учётом замен по утверждённой таблице (с прямой ссылкой на источник таблицы) и в накопительной ведомости показывать пересчёт заменённых количеств в базовый продукт.
2. Компенсировать отклонение в общем меню: сократить рыбный день или уменьшить закладку рыбы в другие дни.
3. Строить пару внутри одной группы (сценарий 2).

Первый способ опирается на аналогию: таблица замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26 нормативно относится к питанию детей (подп. 4 п. 59) [3], а для взрослых её применение — решение учреждения. Ближайший федеральный документ для взрослых — приложения № 7 и № 8 к рекомендациям, утверждённым постановлением № 12 [29]. Источник таблицы нужно назвать в самом локальном акте.

Классы. Норма — суточные количества № 1284. Толкование — допустимость контроля по среднему за период и применения таблицы замен по аналогии. Рекомендация — локальный акт о порядке учёта замен.

7.3 Сценарий 2. Пары внутри одной группы продуктов

Задача. Ввести выбор, не требующий никакого пересчёта норм.

Решение. Подбирать варианты из одной нормативной группы постановления № 1284 [31]:

Группа № 1284	Пары, не требующие пересчёта	Пример из практики
Крупы, бобовые	Гречка / рис / пшено / овсянка	«Рис или гречка» — Усть-Илимск [12]
Говядина, свинина	Котлета / тефтели / гуляш из одной заготовки	«Два мясных блюда на выбор» — Успенский ПНИ [7]
Овощи (все виды, включая консервированные и зелень)	Винегрет / салат из свёклы / салат из свежих овощей	Успенский ПНИ [7]
Чай, кофе, какао	Чай / какао / кофейный напиток	Болотнинский ПНИ [5]
Птица	Курица жареная / отварная	Болотнинский ПНИ, 2026 [6]

Пара «гуляш или печень по-строгановски» из усть-илимского меню [12] — между группами: печень в постановлении № 1284 не входит в группу «говядина, свинина». Для неё нужна таблица замен: по приложению № 11 к СанПиН 4282-26 100 г говядины эквивалентны 116 г говяжьей печени [3].

Вторая полезная граница проходит по технологическому потоку. Два варианта из одной заготовки (котлета и тефтели из одного фарша) не требуют дополнительной плиты и дополнительной закупки; два варианта из разных потоков (котлета и рыба) требуют второго технологического процесса, отдельных ТТК и, как правило, дополнительного оборудования или времени повара.

Классы. Норма — группы продуктов № 1284. Рекомендация — подбор пар внутри группы и потока.

7.4 Сценарий 3. Заказ накануне или выбор в момент еды

Два режима. При заказе накануне (М1) житель выбирает рацион следующего дня по листу заказа; кухня готовит под известные объёмы. Так устроена петербургская практика, описанная Комитетом по социальной политике [19]. При выборе в момент еды (М2) житель выбирает на линии раздачи; кухня готовит под прогноз. Так устроены новосибирские и усть-илимская практики [5, 7, 12].

Что говорят данные. По Wright и соавт., удовлетворённость выше, когда выбор ближе к приёму пищи [80]. По Wheeler и соавт., переход к выбору в момент еды увеличил производственные отходы с 55 до 90 г на жителя в день [78].

Санитарное ограничение. СанПиН 4282-26 запрещает реализовать готовые блюда на следующий день и замораживать нереализованные (п. 32) [3]. Всё, что приготовлено под прогноз и не роздано, уходит в отходы, поэтому выбор в момент еды требует прогноза объёмов.

Иллюстрация прогноза. Старт — 50/50 с небольшим резервом на каждый вариант. Каждый день фиксируется фактическое распределение выбора и число жителей, которым не хватило выбранного варианта. Через две-три недели пропорции поправляют по статистике. Качество прогноза показывает доля жителей, не получивших выбранного варианта; она должна стремиться к нулю. Потери показывает масса нерозданных порций.

Компромисс. Заказ накануне для маломобильных жителей, получающих пищу в комнатах (именно так это сделано в правилах внутреннего распорядка ДСО «Серафимовский» [26]), и выбор в момент еды в столовой.

Классы. Норма — п. 32 СанПиН 4282-26. Толкование — выводы из исследований. Рекомендация — прогноз, индикаторы, смешанный режим.

7.5 Сценарий 4. Раздача и персонал

Санитарные требования. Готовые блюда, требующие разогрева, не могут находиться на раздаче более трёх часов с момента изготовления; к приготовлению, порционированию и раздаче не допускаются посторонние лица, «включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности» (п. 32 СанПиН 4282-26) [3]. Работники, занятые изготовлением пищи и контактирующие с пищевой продукцией, должны проходить гигиеническую подготовку и медицинские осмотры (п. 24) и ежедневный осмотр с записью в гигиеническом журнале (п. 25) [3].

Следствие для вариативного меню. Если выбор организуется в отделениях (на подносах, в буфетных жилых корпусов), то санитары или младшие медицинские сёстры, которые порционируют второй вариант, должны иметь раздачу в должностных обязанностях и пройти гигиеническую подготовку. Проблема частая и незаметная: при едином меню в отделение привозят готовые порции, а с выбором порционировать начинает персонал отделения.

Раздача маломобильным. Выбор, существующий только в столовой, не доходит до жителей, которые в столовую не ходят. Работают два решения: лист заказа накануне (сценарий 3) или поднос с обоими вариантами малыми порциями и выбор на месте; во втором случае надо решить, что делать с остатком. Доклад «Не просто накормить» формулирует правило «два варианта на подносе, а не вторая линия в коридоре» [20] — это рекомендация.

Время. Если выбор в момент еды растягивает раздачу, надо проверить, укладывается ли последняя порция в три часа с момента изготовления; если нет — готовить партиями.

Классы. Нормы — п. 24, 25, 32 СанПиН 4282-26. Рекомендация — правка должностных инструкций, подносы для маломобильных.

7.6 Сценарий 5. Санитарный паспорт каждого варианта

Каждое блюдо, предложенное на выбор, — самостоятельный объект санитарного контроля. Для каждого варианта учреждение должно иметь:

- технологический документ (технологическую или технико-технологическую карту), утверждённый руководителем, причём наименование блюда в меню должно совпадать с наименованием в технологическом документе (п. 11 СанПиН 4282-26) [3];
- запись в журнале бракеража готовой продукции: блюдо не выдаётся до устранения нарушений технологии (подп. 13 п. 56) [3];
- суточную пробу. Для медицинских организаций подп. 4 п. 56 требует отбирать пробу «от каждой партии приготовленной пищевой продукции», отдельно каждое блюдо; для организаций социального обслуживания прямо предусмотрен отбор суточных проб при получении готовых блюд от сторонней организации (подп. 12 п. 56) [3]. Для собственного пищеблока организации социального обслуживания прямой нормы об отборе проб в разделе VII нет (п. 2.7). Учреждению, вводящему второй вариант, разумно отбирать пробу каждого (рекомендация): без пробы одного из вариантов при пищевом отравлении источник не установить;
- сведения об аллергенах, если блюдо содержит ингредиенты с аллергенными свойствами (п. 43) [3].

Классы. Нормы — п. 11, 43, подп. 12–13 п. 56. Рекомендация — проба каждого варианта на собственном пищеблоке.

7.7 Сценарий 6. Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ

Различие контуров. Бюджетное учреждение закупает продукты по 44-ФЗ; автономное учреждение — по 223-ФЗ и своему положению о закупке, за исключением случаев, когда закупка финансируется субсидией на капитальные вложения (ч. 4 ст. 15 44-ФЗ) [50, 51]. В Санкт-Петербурге ДСО «Серафимовский» (автономное учреждение) закупает по 223-ФЗ, а ДСО «Тесовый берег» (бюджетное) — по 44-ФЗ: извещение № 0372200070825000244 от 24.11.2025 о поставке продуктов питания размещено как открытый конкурс [57].

Выбор и контракт. С выбором объёмы отдельных продуктов колеблются: если 40 % жителей выбирают рыбу, рыбы нужно больше, мяса меньше (сценарий 1). Контракт с жёстко зафиксированными количествами по позициям этого не выдержит.

Инструменты 44-ФЗ. Если количество товара невозможно определить заранее, заказчик вправе указать в извещении цену единицы товара и максимальное значение цены контракта (ч. 24 ст. 22 44-ФЗ); количество в этом случае определяется заявками заказчика в пределах цены контракта [50]. Кроме того, если такая возможность предусмотрена извещением и контрактом, количество товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на 10 % с соразмерным изменением цены (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ) [50]. Для вариативного меню удобнее первый инструмент: он позволяет перераспределять заказ между позициями по фактическому спросу.

Инструменты 223-ФЗ. Положение о закупке учреждения само определяет способы закупки и порядок изменения договора [51]. Автономное учреждение может предусмотреть рамочные договоры с ценой единицы и заявочной поставкой. Поэтому 223-ФЗ для выбора гибче, но гибкость задаёт текст положения, а не закон.

Спецификация. Для обоих контуров выбор живёт в спецификации: группы взаимозаменяемых продуктов, пропорции по статистике выбора, допустимые замены. Избыточная детализация (конкретная торговая марка, необоснованные характеристики) может ограничить конкуренцию и стать предметом жалобы.

Аутсорсинг. Если питание передано стороннему организатору, выбор существует лишь тогда, когда он записан в техническом задании. Доклад «Не просто накормить» предлагает восемь строк ТЗ: группы взаимозаменяемых продуктов; пропорции по статистике выбора; обязательность не менее двух вариантов в определённых приёмах пищи; порядок замен с актом; требования к качеству для изменённых консистенций; приёмка и пробы; цикл меню с массой порций; ежемесячная отчётность о доле выбора и остатках [20]. Ответственность за суточные пробы, бракераж и учёт жителей с нарушениями глотания поставщику не передаётся (рекомендация).

Классы. Нормы — ч. 4 ст. 15, ч. 24 ст. 22, ст. 95 44-ФЗ; 223-ФЗ. Толкование — применимость к вариативному меню. Рекомендация — спецификация и ТЗ.

7.8 Сценарий 7. Комплект документов для проверяющего

Проверяющий оценивает документы и факты, а не намерения. До начала пилота разумно собрать следующий комплект (рекомендация):

1. Локальный акт (приказ или раздел правил внутреннего распорядка) о порядке организации вариативного питания, с определением выбора, перечнем приёмов пищи с выбором, порядком учёта и ответственными. Пример локальной формы — правила внутреннего распорядка ДСО «Серафимовский», утверждённые приказом № 124 [26]; это не образец для обязательного применения.
2. Утверждённое цикличное меню с указанием вариантов.
3. Таблица замен с указанием источника и расчёт выполнения норм за период с учётом замен.
4. Технологические документы на каждый вариант.
5. Журналы бракеража и суточных проб с записями по каждому варианту.
6. Учёт выбора: лист заказа (при заказе накануне) или ежедневная статистика распределения выбора.

7. Протоколы совета (комиссии) по питанию, если такой создан.
8. Письмо учредителю об изменении организации питания (если это требуется уставом или порядком взаимодействия с учредителем).

Типовые вопросы и ответы. «Почему подают не по меню?» — Варианты включены в утверждённое меню. «Где выполнение норм?» — Накопительная ведомость с пересчётом замен. «Кто разрешил?» — Локальный акт учреждения, принятый в пределах его компетенции по уставу. Ответ «так теперь везде» или «так рекомендует Минтруд» неверен: федеральной нормы о вариативном меню нет.

Роспотребнадзор оценивает соблюдение обязательных санитарных требований (температура, пробы, поточность, сроки), а оценка соблюдения рекомендательных норм СанПиН не может быть предметом федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (п. 3 СанПиН 4282-26) [3].

7.9 Сценарий 8. Экономика: что можно утверждать и как измерять

Что известно. Российских опубликованных расчётов стоимости вариативного меню нет (п. 4.11). Зарубежные данные: в исследовании Wheeler и соавт. стоимость выросла с 9,20–11,14 до 11,01–12,15 австралийского доллара на жителя в день, производственные отходы — с 55 до 90 г [78]. Средняя стоимость кейтеринга в австралийских учреждениях — 8,00 доллара в день, из них сырьё — 6,08 доллара [109].

Где возникают затраты (толкование). Сырьё при парах внутри группы перераспределяется, а не растёт (сценарий 2). Дополнительные затраты возникают в трёх местах: производственные отходы при выборе в момент еды; время персонала на раздаче и учёте; оборудование для второго технологического потока или для доставки в отделение. Петербургское сообщение называет оборудование и сотрудников [19].

Иллюстративная арифметика потерь. Если перенести на учреждение на 300 жителей прирост производственных отходов из исследования Wheeler и соавт. (+35 г на жителя в день), получится около 10,5 кг готовой пищи в день. Это не прогноз, а порядок величины, который стоит проверить собственным замером [78].

Масштаб в петербургских ценах (иллюстрация; открытый вопрос автора и РГ, см. ниже). Тариф 2026 г. на обеспечение питанием в стационарной форме для совершеннолетних — 581,33 руб. в день (кроме ПНИ и ДСО) и 574,43 руб. в день (ПНИ и ДСО) [69]. Если допустить, что организация выбора увеличит расходы на питание на 10–20 % — допущение, близкое к результату Wheeler и соавт. [78], — для ПНИ и ДСО это составит около 57–115 руб. на жителя в день, или 1,7–3,4 млн руб. в месяц на учреждение в 1 000 мест (иллюстративная арифметика: $574,43 \times 0,1...0,2 \times 1\,000 \times 30$). Это не прогноз: австралийский прирост включал производственные отходы и персонал в австралийских условиях, а российские кейсы (п. 4.11) показывают, что стартовый формат вводился и без публично названных дополнительных расходов. Для сравнения порядка величин: годовой рост тарифа ПНИ и ДСО с 2025 по 2026 г. составил 2,80 руб. в день ($571,63 \rightarrow 574,43$) [68, 69], то есть допущенный прирост в 20–40 раз больше годовой индексации. Арифметика показывает лишь одно: полный переход крупного учреждения — вопрос учредителя, а не только кухни. Сохранять ли эту ил-

люстрацию в итоговом тексте и в каком виде — открытый вопрос для автора и рабочей группы: она полезна как масштаб, но может быть прочитана как оценка затрат, которой не является.

Как измерять. Минимальная система учёта, доступная любому учреждению (рекомендация):

- отходы с тарелки — визуальная оценка по шкале «съедено всё / $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{4}$ / ничего» по выборке жителей или взвешивание остатков в течение 7 дней до запуска и 7 дней через месяц после;
- производственные отходы — масса нерозданных порций по каждому варианту ежедневно;
- распределение выбора — ежедневно;
- стоимость — фактические расходы на продукты на одного жителя в день за месяц до и месяц после.

7.10 Сценарий 9. Пилот на 90 дней

Конструкция. Доклад «Не просто накормить» предлагает пилот на одном отделении (20–35 жителей), в одном приёме пищи (обычно обед), 2–3 дня в неделю, с заказом накануне на старте [20]:

Дни	Действия
1–14	Приказ о пилоте; замер «до» (отходы, распределение предпочтений по опросу); инструктаж персонала; уведомление учредителя; при аутсорсинге — сверка контракта
15–75	Два варианта второго блюда 2–3 дня в неделю; журналы с первого дня; еженедельный разбор
76–90	Сводка показателей; обсуждение с жителями; решение: расширить, закрепить или свернуть с указанием причин

Что доказывает пилот. Что выбор исполним и безопасен в конкретном учреждении, но не то, как он влияет на пищевой статус: для этого нет контрольной группы и мало времени. Возможные систематические ошибки — эффект наблюдения в первые недели, сезонность, «своя» смена.

Критерии немедленной остановки (рекомендация): рост отказов от еды; санитарные нарушения на новой линии; противопоказание врача для конкретного жителя (в этом случае прекращается участие жителя, а не пилот).

Расхождение календарей. Предшествующая работа семинара предлагала дорожную карту на 12–24 месяца с пилотом на 11–14 месяцах [21]; доклад «Не просто накормить» сжимает старт до 90 дней на одном отделении [20]. Это разные масштабы задачи — перестройка всего дома против пилота, — а не ошибка одной из работ.

7.11 Сценарий 10. Невербальный выбор, отказ, пост и ночной интервал

Невербальный выбор. Вариативное меню, построенное на вопросе «что будете?», исключает тех, кто не может ответить словами. Исследование Abbey и соавт. показало, что реальный выбор особенно низок у жителей на протёртой пище [81]. Доклад «Не просто накормить» предлагает четыре канала выяснения предпочтений: показ двух реальных порций с фиксацией реакции; наблюдение за тем, что съедается, по серии записей; пищевую биографию периода, когда человек мог выразить предпочтения; сведения от близких и давних сотрудников [20]. В самом докладе есть внутреннее противоречие о порядке этих каналов: в одном месте приоритет отдан зафиксированной биографии, в другом — текущему выраженному предпочтению [20, 21]. В этой редакции автор его не снимает: решение требует этической и правовой проработки, в том числе с учётом дееспособности и роли законного представителя.

Отказ от еды. Доклад «Не просто накормить» предлагает проект правила: каждый отказ фиксируется; в тот же приём предлагается альтернатива; три отказа подряд — осмотр врача в тот же день; системный недоед (не менее 25 % порции в течение недели) — врач и пересмотр плана; отказ от воды — немедленно [20]. Это проект локального правила, а не норма российского права; клиническая часть — дело врача. Готовая альтернатива в вариативном меню облегчает второй шаг правила.

Пост и религиозные ограничения. Для ПНИ право соблюдать религиозные каноны, включая пост, если это не нарушает внутреннего распорядка, закреплено ч. 2 ст. 37 Закона № 3185-1 в силу ст. 43 [24]. С 01.09.2025 обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов возложена на все организации социального обслуживания подп. 15 п. 20 Правил, утверждённых приказом № 305н [25]. Организационно это три вопроса, на которые у учреждения должен быть письменный ответ: как житель заявляет о соблюдении поста (заявление, отметка в индивидуальной программе или устное сообщение, зафиксированное сотрудником); какие постные блюда входят в меню на период поста и по каким технологическим документам они готовятся; как выполнение норм по белоксодержащим группам (мясо, молоко, яйцо) обеспечивается заменой на рыбу в разрешённые дни, бобовые и другие продукты по утверждённой таблице замен (рекомендация). Вариативное меню обеспечивает это право без отдельной «постной кухни»: постное блюдо становится одним из вариантов. Если у жителя есть медицинские назначения, вопрос о посте согласуется с врачом.

Ночной интервал. Для взрослых в организациях социального обслуживания Сан-ПиН 4282-26 устанавливает только минимальную кратность — не менее трёх раз в день (подп. 11 п. 56) [3]. Рекомендации, утверждённые постановлением № 12, предписывают не допускать длительных перерывов, «особенно между ужином предыдущего и завтраком последующего дня», без числового предела [29]. Зарубежные ориентиры: не более 14 часов (16 часов при перекусе) в США [113], не более 11 часов в шведских рекомендациях [121]. Доклад «Не просто накормить» использует рабочий ориентир не более 13 часов [20] — это ориентир, а не норма. Выбор блюда не возмещает долгого ночного перерыва: если ужин подаётся в 17:30, а завтрак в 8:30, интервал составляет 15 часов, и это проблема организации режима, а не меню.

7.12 Сценарий 11. Один день меню по нормам № 1284: две точки выбора и проверка по таблице замен

Задача. Показать на одном дне, как учреждение (кроме ПНИ, 100 жителей) проверяет меню с двумя точками выбора и что именно попадает в накопительную ведомость. Арифметика иллюстративная; блюда и закладки условные, нормы — по постановлению № 1284 [31], коэффициенты замен — по приложению № 11 к СанПиН 4282-26 [3].

План дня (иллюстрация).

Приём пищи	Без выбора	Точка выбора	Группа № 1284	Нужна ли таблица замен
Завтрак	Хлеб, масло, чай	Каша овсяная или гречневая (крупа 40 г)	«Крупы, бобовые» — обе	Нет
Обед	Суп на мясном бульоне (мясо 15 г), салат	Котлета говяжья (мясо 75 г) или филе куриное (птица)	«Мясо» и «птица» — разные группы	Да
Обед	—	Гарнир: картофельное пюре или рис	«Картофель» и «крупы, бобовые» — разные группы	Да, но в таблице пары нет
Ужин	Треска запечённая (рыба 41,8 г), овощи	—	«Рыба»	—

Первая точка: мясо или птица. По приложению № 11 100 г говядины заменяются 97 г мяса птицы [3], поэтому порция варианта Б — $75 \times 0,97 \approx 72,8$ г птицы. Пусть 60 жителей выбрали котлету, 40 — птицу. Фактический расход за день: мясо $100 \times 15 + 60 \times 75 = 6,0$ кг; птица $40 \times 72,8 \approx 2,91$ кг. По группам это 60 г мяса на человека вместо запланированных 90 г и 29,1 г птицы при отсутствии птицы в плане дня. В пересчёте на базовый продукт 2,91 кг птицы эквивалентны $2,91 / 0,97 = 3,0$ кг говядины, и «мясо с учётом замен» составляет $6,0 + 3,0 = 9,0$ кг — ровно план дня (100×90 г). Эту строку — фактическое количество, эквивалент по таблице, итог с учётом замен — учреждение и показывает в ведомости, если локальный акт ввёл учёт с заменами (сценарий 1, способ 1).

Вторая точка: картофель или рис. Приложение № 11 содержит замены картофеля только на овощи и бобовые (капуста, морковь, свёкла, фасоль, горошек, кабачки) и не содержит замены картофеля на крупу [3]. Самая ходовая пара гарниров — «картофель или каша» — таблицей не покрыта. У учреждения три пути: оставить гарнирную пару внутри группы (пюре или отварной картофель; рис или гречка — именно так устроен выбор гарнира в Усть-Илимске [12]); рассчитать эквивалентность по химическому составу в технологических картах и закрепить расчёт локальным актом; или учитывать гарнирные группы отдельно и выравнивать их в остальные дни недели (сценарий 1, способ 2). Первый путь легче всего защитить при проверке (толкование).

Неделя, а не день. Проверять вариативное меню по одному дню бессмысленно: в день, когда птицы нет в плане, любой выбор птицы выглядит «перерасходом». Контроль ведётся по накопительной ведомости за неделю или декаду (п. 3.15). Если учреждение хочет, чтобы недельная ведомость сходилась без пересчёта, пары между группами (мясо — птица) должны чередоваться с днями, где птица и так заложена, а их доли — подтверждаться статистикой выбора за предыдущие недели (сценарий 3).

Классы. Норма — суточные количества № 1284; таблица замен прил. № 11 СанПиН 4282-26 (для детей; для взрослых — по аналогии). Толкование — отсутствие пары «картофель — крупа» как ограничение выбора гарнира. Рекомендация — строка «с учётом замен» в ведомости, гарнирные пары внутри группы.

7.13 Сценарий 12. Лоты и договоры по 223-ФЗ под вариативное меню

Исходные условия. Автономное учреждение закупает продукты по своему положению о закупке (п. 2.10) [51]. Закупка продуктов для питания проживающих — закупка для оказания услуги конкретным получателям, то есть для нужд самого учреждения; по логике постановления АС Дальневосточного округа № Ф03-3556/25 она остаётся в контуре 223-ФЗ (толкование; текст определения ВС № 303-ЭС25-15393 не проверен) [53, 56].

Шаг 1. Базовый объём от нормы, а не от прошлогоднего меню. Квартальная потребность по группе = норма × число жителей × число дней. Для 100 жителей на 91 день: мясо $90 \text{ г} \times 100 \times 91 = 819 \text{ кг}$ нетто, рыба $41,8 \text{ г} \times 100 \times 91 \approx 380 \text{ кг}$ нетто (иллюстративная арифметика по нормам № 1284 [31]). Если поставщик продаёт брутто, объём закупки пересчитывается учреждением по его собственным коэффициентам отходов; для иллюстрации по коэффициентам ленинградского приказа (мясо 0,705, рыба 0,550 [42]) это около 1 162 кг мяса и 692 кг рыбы брутто. Коэффициенты конкретного учреждения зависят от вида сырья и обработки.

Шаг 2. Коридор сдвига от статистики выбора. Если 40 % жителей три раза в неделю выбирают рыбу вместо мяса (сценарий 1), за квартал (13 недель) расход мяса уменьшится примерно на 117 кг нетто (–14,3 % от базового объёма), рыбы — увеличится примерно на 147 кг (+38,6 %) (иллюстративная арифметика: $13 \times 9,0 \text{ кг}$ и $13 \times 11,3 \text{ кг}$). Такой сдвиг не помещается в 10-процентный коридор изменения количества по 44-ФЗ (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95) [50]; это главный довод за то, чтобы закупочная документация автономного учреждения предусматривала иной механизм.

Шаг 3. Конструкция лотов. Разумная структура (рекомендация) повторяет группы региональной нормы, а не разделы меню: отдельные лоты (или отдельные спецификации внутри одного договора) по мясу, птице, рыбе, молочной продукции, овощам и фруктам, бакалее, хлебу. Внутри лота перечисляются взаимозаменяемые позиции группы (говядина и свинина в одной группе № 1284 [31]), и устанавливаются цена единицы и максимальная сумма договора; количество определяется заявками учреждения. Для групп, между которыми предполагается выбор, максимальные суммы рассчитываются с учётом коридора шага 2, а не по базовому объёму. Та же логика —

в шведских национальных рекомендациях: «базовое меню» с несколькими блюдами на выбор служит одновременно основой расчёта пищевой ценности на уровне группы и основой закупки [121].

Шаг 4. Что записать в положение о закупке. Возможность рамочного договора с ценой единицы и заявочной поставкой; порядок изменения количества по отдельным позициям в пределах цены договора; основание для закупки у единственного поставщика при срыве поставки (если положение это допускает). Без этих пунктов гибкость 223-ФЗ остаётся на бумаге: её задаёт текст положения, а не закон [51].

Риски. Объединение всех продуктов в один крупный лот сужает круг участников; в 2024–2025 гг. ФАС России выявляла картели на торгах по поставке социально значимых продуктов и школьного питания [61, 62]. Связь размера лота с риском сговора — толкование, но дробление лотов по группам продуктов служит сразу и вариативному меню, и конкуренции. Обратный риск — искусственное дробление для ухода от конкурентных процедур; критерии допустимого дробления устанавливает положение о закупке и практика контролирующих органов, в докладе не анализировавшаяся.

Классы. Норма — 223-ФЗ, положение о закупке, ст. 95 44-ФЗ для сравнения. Толкование — квалификация закупки продуктов как закупки для нужд учреждения. Рекомендация — лоты по группам нормы, коридор от статистики выбора.

7.14 Сценарий 13. Документальная цепочка одного дня: что меняется при двух вариантах

Исходная цепочка. Положение об организации питания нижегородского дома-интерната описывает типичную последовательность документов при едином меню [44]. Ниже показано, что меняет в каждом звене выбор между двумя вариантами (рекомендация; формы приведены так, как они названы в положении).

Звено	При едином меню [44]	При вариативном меню (рекомендация)
Порционник (ф. № 1-84), ежедневно	Число жителей на питании по отделениям	Число жителей и распределение по вариантам (заказ накануне) или прогноз (выбор в момент еды)
Сводные сведения о численности	Итог по учреждению	Итог по учреждению и по каждому варианту
Меню-раскладка (ф. 0504202) на следующий день	Одно блюдо на позицию, закладка на одну порцию и на все порции	Оба варианта отдельными строками с числом порций каждого
Требование на склад (ф. № 45-МЗ)	Сумма продуктов по раскладке	Сумма продуктов обоих вариантов
Закладка в котёл в присутствии диетической сестры	По раскладке	По раскладке каждого варианта
Карточка-раскладка (ф. № 1-85)	На каждое блюдо	На каждое блюдо, включая альтернативные

Звено	При едином меню [44]	При вариативном меню (рекомендация)
Бракераж	Каждое блюдо перед выдачей	Каждый вариант перед выдачей (подп. 13 п. 56 СанПиН 4282-26 [3])
Взвешивание порций	10 порций, отклонение $\leq 3\%$	10 порций каждого варианта
Суточная проба	«От каждой партии», отдельно каждое блюдо, 48 ч	Каждый вариант как самостоятельная партия (вопрос о норме — открыт, см. ниже)
Учёт остатков	—	Масса нерозданных порций каждого варианта (п. 32 СанПиН 4282-26 запрещает реализацию на следующий день [3])
Накопительная ведомость	Фактический расход по группам	Фактический расход, эквивалент по таблице замен, итог с учётом замен (сценарий 11)

Что спросит проверяющий (по предметам контроля, гл. 8). Роспотребнадзор: технологические документы на каждый вариант (п. 11), бракераж (подп. 13 п. 56), время с момента изготовления до раздачи (п. 32), отсутствие реализации остатков (п. 32) [3]. Роструд — для государственной организации субъекта, орган субъекта — для негосударственного поставщика (п. 8.3–8.4): выполнение норм питания по ведомости, условия для соблюдения поста (подп. 15 п. 20 Правил, утверждённых приказом № 305н), соответствие организации питания порядку предоставления услуг (вопросы 64, 75, 65 проверочного листа) [25, 35]. Учредитель: обоснование расхода продуктов и закупок.

Что находят финансовые проверки. Акт Контрольно-счётной палаты Иркутской области (2023) по одному дому-интернату показывает, в каких звеньях этой цепочки находят нарушения даже при едином меню [18]: численность жителей в меню-требовании не совпадала с приказами о движении жителей (за 2021–2023 гг. — 560 человеко-дней в одну сторону и 8 в другую, неправомерно списано продуктов на 942,9 руб.); на часть блюд технологические карты утверждены только в ходе проверки, на омлет существовали две карты с разной рецептурой; при закладке не докладывали продукты (маргарин в омлет, сахар в какао) и заменяли их без отражения в документах (цыплёнок-бройлер вместо окорока в солянке, томаты в собственном соку вместо томатного пюре сверх нормы); локальные акты не предусматривали закладку продуктов на суточную пробу, хотя она влияет на норму отпуска [18]. Вывод для вариативного меню прост: замена, не оформленная по таблице и не отражённая в меню-требовании, при финансовой проверке окажется не «вариантом», а нарушением технологии и учёта (толкование).

Открытый вопрос для автора и РГ. Отбирать ли суточную пробу каждого варианта на собственном пищеблоке организации социального обслуживания, при том что прямой нормы об этом для таких организаций в разделе VII СанПиН 4282-26 нет (п. 2.7, сценарий 5), — оставлено открытым по решению автора. Нижегородское положение отвечает на него положительно для единого меню («от каждой партии... отдельно каждое блюдо») [44]; если вариант рассматривается как самостоятельное блюдо, тот же локальный принцип распространяется на него без новой нормы.

Классы. Нормы — п. 11, 32, подп. 13 п. 56 СанПиН 4282-26; подп. 15 п. 20 Правил (305н). Локальная форма — положение нижегородского дома-интерната. Рекомендация — изменения в каждом звене.

7.15 Сценарий 14. Персонал и время раздачи: расчёт для одного отделения

Ограничения. Блюда, требующие разогрева, могут находиться на раздаче не более трёх часов с момента изготовления (п. 32 СанПиН 4282-26) [3]; то же ограничение времени горячего удержания — в стандарте DGE [119]. Порционирование в отделении допускается только для персонала, в обязанности которого оно входит и который прошёл гигиеническую подготовку (сценарий 4) [3].

Ориентиры из источников. Типичный режим дома-интерната с единым меню — две смены по 30 минут на каждый приём пищи [44]. В Успенском ПНИ после перехода на самообслуживание время обеда, по сообщению учреждения, сократилось с 2,5 часа до 50 минут [11]; способ измерения не описан. Время помощи при еде, дававшей рост потребления в американских исследованиях, — 35–42 минуты на жителя за приём пищи против 5–9 минут при обычном уходе; перекус между приёмами — 12–13 минут [105–108].

Иллюстрация (условное отделение на 60 жителей). 40 жителей едят самостоятельно и подходят к линии; 14 нуждаются в подсказке и присутствии сотрудника; 6 нуждаются в кормлении. Для 40 самостоятельных выбор в момент еды не требует дополнительного персонала, если линия рассчитана на их поток (успенский пример показывает, что самообслуживание может сокращать время [11]). Для 20 остальных протокол уровня Simmons потребовал бы $20 \times 35\text{--}42 = 700\text{--}840$ минут, то есть 11,7–14 часов рабочего времени сотрудников на один обед, против 100–180 минут при «обычном уходе» тех исследований (иллюстративная арифметика по [105–108]). В трёхчасовое окно п. 32 при этом укладываются 4–5 сотрудников, занятых только помощью при еде (иллюстративная арифметика: $700\text{--}840 \text{ мин} / 180 \text{ мин}$). Это не норматив, а проверка реализма: если у отделения такого ресурса нет, выбор для этих 20 жителей сведётся к выбору, сделанному за них.

Норматив времени в региональном стандарте. Иркутский стандарт социальной услуги «помощь в приёме пищи» отводит на каждое кормление до 15 минут [18] — меньше половины нижней границы времени помощи (35 минут), при которой в американских исследованиях рос объём съеденного [105–108]. Сопоставление условно: исследования измеряли иное вмешательство и иную группу жителей (толкование). Но если региональный стандарт закладывает в тариф и штатный расчёт 15 минут, на выбор блюда для жителя, которого кормят, времени в нём не остаётся вовсе.

Решения, вытекающие из расчёта (рекомендация). Разделить приём пищи на поток самостоятельных жителей и поток жителей, получающих помощь, со сдвигом во времени и с приготовлением партиями так, чтобы каждая партия укладывалась в три часа. Для жителей, которых кормят, выбор переносить в момент, когда на него есть время: показ двух вариантов перед кормлением (п. 7.16), перекусы с выбором между приёмами пищи, которые по американским данным требуют втрое-вчетверо

меньше времени, чем помощь во время еды [106, 108]. Штатные нормативы российских учреждений доклад не анализировал; расчёт показывает лишь, что выбор для зависимых жителей — вопрос кадров, а не кулинарии.

Классы. Норма — п. 24, 25, 32 СанПиН 4282-26. Толкование — перенос американских данных о времени. Рекомендация — два потока, партии, перекусы с выбором.

7.16 Сценарий 15. Жители, которые не могут выразить выбор

Почему это отдельный сценарий. Выбор, построенный на вопросе «что будете?», достаётся тем, кто способен ответить и настоять: в лондонских домах ухода широта выбора зависела от способности и готовности жителя попросить альтернативу [86]; в австралийских — выбор был особенно низок у жителей на протёртой пище [81]. Для ПНИ и ДСО, где многие жители не говорят или говорят с трудом, это вопрос не второстепенный.

Источники предпочтения. Зарубежные стандарты и российские материалы называют одни и те же источники, расходясь лишь в порядке:

Источник	Где описан	Ограничение
Пищевая биография при поступлении	Стандарт DGE: ориентир для тех, кто «едва может сообщить» пожелания [119]; лондонские дома — сбор предпочтений при поступлении [86]; доклад «Не просто накормить» [20]	Фиксирует прошлое; вкусы меняются
Показ двух реальных порций с фиксацией реакции	Доклад «Не просто накормить» [20]	Требует времени (сценарий 14) и обученного наблюдателя
Наблюдение за тем, что съедается	Доклад «Не просто накормить» [20]; учёт возвратов по DGE [119]	Съеденное зависит и от помощи, и от самочувствия
Сведения близких и давних сотрудников	Доклад «Не просто накормить» [20]	Опосредованное знание
Критерий «персонал замечает индивидуальные потребности»	Критерии Socialstyrelsen [121]	Сформулирован для оценки, а не как метод

Пример записи (локальная форма, рекомендация). Карта предпочтений жителя: источник сведений и дата (биография — родственник, 03.2026); наблюдение (за 10 обедов с показом двух вариантов — выбор рыбного блюда 7 раз, отказ от второго блюда 1 раз); вывод на ближайший месяц; дата пересмотра. Карта прикладывается к документам индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ст. 16 442-ФЗ) [22] как сведения о предпочтениях, а не как медицинское назначение; если у жителя есть назначения врача, карта действует только в их пределах.

Чего делать нельзя. Японские критерии «особого питания» содержат формулу, применимую и здесь: питание не должно подаваться против воли человека [125]. Наблюдаемый отказ (отодвинутая порция, сжатые губы) — тоже выражение предпочтения; по правилу об отказах (сценарий 10) его фиксируют, а как реагировать, решает врач.

Открытые вопросы для автора и РГ. По решению автора остаются открытыми и явно помеченными: (1) кто принимает решение о выборе за жителя, который не может выразить предпочтение, — сотрудник по карте, законный представитель или комиссия, и как это соотносится с дееспособностью и ролью опекуна; (2) как формулировать в локальных актах пределы вмешательства при отказе от еды, чтобы исключить и оставление без помощи, и кормление против воли. В докладе «Не просто накормить» по первому вопросу содержится внутреннее противоречие о приоритете биографии и текущего предпочтения (сценарий 10) [20]; оно не снимается и здесь.

Классы. Норма — ст. 16 442-ФЗ (индивидуальная программа). Рекомендация — карта предпочтений, показ двух порций, пересмотр. Открытые вопросы — субъект решения и формулировки об отказе.

7.17 Сценарий 16. Пост по Правилам № 305н: неделя с таблицей замен

Норма. С 01.09.2025 организации социального обслуживания обязаны обеспечивать условия для соблюдения постов (подп. 15 п. 20 Правил, утверждённых приказом № 305н) [25]; для ПНИ право соблюдать религиозные каноны, включая пост, если это не нарушает внутреннего распорядка, закреплено ч. 2 ст. 37 Закона № 3185-1 [24]. Какие ограничения соблюдать, решает сам житель; учреждение не решает за него, какой пост и как строго он держит (толкование).

Иллюстрация. Учреждение (кроме ПНИ) на 100 жителей; 12 жителей заявили о посте. В неделю у них четыре постных обеда: в два дня допускается рыба, в два дня — без продуктов животного происхождения. Базовое второе блюдо обеда — мясное, 75 г мяса на порцию.

- **Рыбные дни.** По приложению № 11 100 г говядины заменяются 125 г трески [3]; порция трески — $75 \times 1,25 \approx 94$ г. За неделю: $-1,8$ кг мяса, $+2,25$ кг рыбы (12×75 г $\times 2$ и 12×94 г $\times 2$). Это замена, предусмотренная таблицей, и она отражается в ведомости строкой «с учётом замен» (сценарий 11).
- **Дни без продуктов животного происхождения.** В приложении № 11 нет заменителя мяса растительного происхождения: для говядины указаны только продукты животного происхождения (кролик, печень, птица, треска, творог, баранина, конина, лосятина, оленина, мясные консервы) [3]. Бобовое блюдо в норме № 1284 входит в группу «крупы, бобовые» [31], то есть увеличивает её расход, а группа «мясо» недовыполняется на 1,8 кг в неделю (12×75 г $\times 2$) без табличного эквивалента. Методические рекомендации 2002 г. содержат собственные нормы взаимозаменяемости (прил. № 7) [29], но в открытой версии справочной системы они не опубликованы и для доклада не прочитаны.
- **Масштаб.** Всего за неделю расход мяса по учреждению снизится на 3,6 кг из 63,0 кг недельной нормы, то есть на 5,7 % (иллюстративная арифметика: 12×75 г $\times 4 / (90$ г $\times 100 \times 7)$). Отклонение видно в ведомости, и его придётся объяснить.

Как оформить (рекомендация). В локальном акте о питании — пункт о порядке заявления жителем о соблюдении поста и о перечне постных вариантов; в меню периода — постные блюда как варианты, а не как отдельная «постная кухня» (сценарий 10); в ведомости — отдельная строка «отклонение по группе „мясо“ в связи с соблюдением поста получателями по их заявлениям (подп. 15 п. 20 Правил № 305н)» с числом заявивших; для бобовых блюд, заменяющих мясо, — технологические карты с расчётом белка, поскольку табличного эквивалента нет. Если у жителя есть медицинские назначения, вопрос о посте согласуется с врачом (сценарий 10).

Пробел, который вскрывает сценарий. Федеральной таблицей замен, на которую ссылаются учреждения, нельзя сбалансировать обязанность по 305н для жителей, держащих пост без продуктов животного происхождения. Это не противоречие норм, а их несогласованность: обязанность обеспечить условия для поста введена в 2025 г., а инструмент эквивалентной замены, к которому отсылает практика, создан для детского питания и растительных эквивалентов мяса не содержит (толкование; вынесено в гл. 9).

Классы. Нормы — подп. 15 п. 20 Правил (305н); ч. 2 ст. 37 Закона № 3185-1; прил. № 11 СанПиН 4282-26. Толкование — отсутствие растительного эквивалента как пробел. Рекомендация — заявление, постные варианты, строка в ведомости, расчёт белка в ТТК.

7.18 Инструменты измерения: что существует и что из этого применимо

Сценарии 8 и 9 требуют измерений, а российские кейсы (п. 4.11) их не публикуют. Отчасти потому, что в отечественном социальном обслуживании нет общепринятых инструментов, оценивающих питание глазами жителя. В зарубежной литературе они есть; ниже — те, чьи свойства проверены по публикациям, с оценкой применимости. Валидированных русскоязычных версий этих инструментов найти не удалось, поэтому их использование в российском учреждении — адаптация, а не готовая методика (рекомендация).

Четыре объекта измерения. Вариативное меню затрагивает четыре разных предмета, и путать их нельзя: что житель выбрал (распределение выбора), что он съел (потребление и отходы с тарелки), как он оценивает питание (удовлетворённость) и в какой обстановке происходит приём пищи (среда). Учреждение, которое измеряет только первое, знает, что популярно, но не знает, что съедено; учреждение, которое измеряет только удовлетворённость, не увидит, если жители довольны, но недоедают.

Отходы с тарелки. Это самый изученный показатель. В обзоре Roulston и соавт. из 14 источников, измерявших отходы с тарелки в учреждениях длительного ухода, 10 использовали взвешивание и 6 — визуальную оценку [98]. Взвешивание точнее, но требует весов на этаже, маркировки подносов и времени персонала; визуальная оценка быстрее, но зависит от наблюдателя. В одной из включённых в обзор работ (Hansen и Derdowski, 2020) визуальная оценка проводилась по парным фотографиям тарелки до и после еды, и уже сам цвет посуды был связан с разной долей не-

съеденного: от 26 % на белой тарелке до 9 % на белой тарелке с жёлтым ободком и красным кольцом [98]. Результат приведён не как совет покупать цветную посуду, а как напоминание: при сравнении «до» и «после» внедрения выбора посуды, порция и способ подачи должны оставаться прежними, иначе изменение отходов нельзя приписать выбору.

Обзор больничных вмешательств, направленных на снижение отходов с тарелки (Manimaran и соавт., 2023), включил девять исследований и разделил вмешательства на пять групп: изменение меню, обслуживание по заказу (room service), оформление меню, система подачи и инструменты мониторинга питания [126]. Вариативное меню затрагивает сразу три из этих групп, поэтому эффект его внедрения нельзя отделить от сопутствующих изменений подачи без специального дизайна.

Производственные отходы. Это масса блюд, приготовленных, но не розданных. В исследовании Wheeler и соавт. именно этот показатель вырос при переходе к выбору в момент еды (с 55 до 90 г на жителя в день) [78]. Российскому учреждению его измерить проще всего: остаток каждого варианта взвешивается при списании, а сама запись сочетается с требованием п. 32 СанПиН 4282-26 о запрете реализации остатков на следующий день [3]. Без этого показателя невозможно отличить «вариант Б непопулярен» от «вариант Б готовится в избытке».

Удовлетворённость. Для домов престарелых разработаны специальные опросники. Пересмотренный опросник Food Expectations — Long-Term Care (FoodEx-LTC) содержит 28 вопросов в пяти доменах; при первичной проверке на 61 жителя коэффициент α по доменам составил 0,65–0,82, ретестовая надёжность — 0,79–0,88 [127]. Wright и соавт. использовали Resident Foodservice Satisfaction Questionnaire и связали удовлетворённость с числом вариантов и со временем между выбором и подачей [80]. Wheeler и соавт. обошлись пятибалльной шкалой Лайкерта [78]. Для российского учреждения, где значительная часть жителей не может заполнить многостраничную анкету, реалистичны короткая шкала по нескольким вопросам, которую заполняет сам житель или сотрудник со слов жителя, и структурированное наблюдение за теми, кто не может ответить (рекомендация). Успенский интернат перед внедрением провёл опрос и анкетирование и расставил блюда «по балльной системе в зависимости от степени спроса» [7] — пример упрощённого инструмента изучения предпочтений; сама анкета и её результаты не опубликованы. Изучение спроса до запуска и оценка удовлетворённости после него — разные задачи, и вторая в российских сообщениях не описана.

Мнение семьи. Для жителей, которые не могут ответить сами, удовлетворённость можно оценивать через родственников. Yaxley и соавт. (2024) разработали первый валидированный опросник удовлетворённости питанием для членов семей жителей домов престарелых: из 40 исходных пунктов по данным 414 родственников сформирована шкала из 24 пунктов в двух факторах — еда и блюда (11 пунктов, $\alpha = 0,960$) и обстановка приёма пищи (13 пунктов, $\alpha = 0,907$); устойчивость при повторном заполнении (101 человек) — от умеренной до почти полной (взвешенная каппа 0,461–0,875) [128]. Опросник дополняет анкеты для жителей и для персонала, разработанные той же университетской группой [128]. Русскоязычной версии нет; для учреждения ценна сама идея — спрашивать родственников отдельно и отдельно о еде и об обстановке (рекомендация).

Субъективное влияние. Шведские национальные рекомендации предлагают первым критерием качества то, что житель «сам ощущает, что влияет на ситуацию приёма пищи», и лишь затем — его возможность влиять на время, обстановку и блюда [121]. Эти пять-шесть формулировок пригодны как основа короткого опроса из 3–5 вопросов, предусмотренного в минимальном наборе ниже (рекомендация).

Возвраты как источник для меню. Стандарт DGE рассматривает учёт возвращённой еды (Speiserückläufe) не только как показатель отходов, но и как основу корректировки меню, приготовления и порций и как средство учёта съеденного при недостаточности питания [119]. При этом расчёт фактически съеденного по меню и отходам систематически завышает потребление: в японском исследовании CLEVER — в среднем на 232 ккал в сутки (15,3 %) по сравнению с методом дважды меченой воды [100]. Снижение возвратов после введения выбора — довод в пользу выбора, но не доказательство того, что жители стали есть больше (толкование).

Среда приёма пищи. Канадская группа M3 разработала протокол наблюдения Mealttime Scan, который заполняет обученный наблюдатель по ходу приёма пищи. Во вторичном анализе данных M3 (32 дома, 82 отделения, наблюдение 4–6 приёмов пищи в каждом отделении) большее число сотрудников в зале было связано с более ориентированными на отношения практиками в общих отделениях, но не в отделениях для людей с деменцией; авторы предполагают, что там решающую роль играет подготовка персонала [129]. Программа CHOICE+ с внешним сопровождением в течение 12 месяцев в трёх домах, оценённая по расширенной версии протокола (Mealttime Scan+; пять приёмов пищи каждые четыре месяца), дала статистически значимое улучшение физической и социальной среды и общего качества приёма пищи во всех трёх домах [130]. Вывод для российского ДСО простой: изменения среды приёма пищи поддаются наблюдению по чек-листу, и его можно вести силами учреждения, если наблюдатель не участвует в раздаче (рекомендация).

Минимальный набор для учреждения (рекомендация автора, не норма):

Показатель	Метод	Периодичность	Кто ведёт
Распределение выбора	Журнал заказа или учёт розданных порций по вариантам	Ежедневно	Пищеблок или отделение
Производственные отходы	Взвешивание нерозданного остатка каждого варианта	Ежедневно	Пищеблок
Отходы с тарелки	Визуальная оценка по пятиуровневой шкале или взвешивание по выборке	7 дней до и 7 дней через месяц после изменения	Обученный сотрудник, не участвующий в раздаче
Удовлетворённость	Короткий опрос (3–5 вопросов) со слов жителя; для не отвечающих — опрос родственников	До запуска и ежеквартально	Специалист по социальной работе
Масса тела	По медицинской документации	В порядке, установленном врачом	Медицинская служба
Среда приёма пищи	Чек-лист наблюдения	Ежемесячно	Наблюдатель вне смены раздачи

Масса тела включена потому, что учреждение её уже ведёт; толкует её врач. Научного исследования эти показатели не составляют: без контрольной группы и при малой выборке они показывают направление изменений и позволяют заметить вред, но не доказывают эффект выбора.

8 Контроль: кто и что проверяет

8.1 Различие предметов контроля

Вариативное меню попадает в поле зрения нескольких контролирующих органов, и каждый смотрит на своё. Большинство конфликтов при проверках рождается из путаницы предметов: учреждение отвечает санитарному инспектору о качестве социальной услуги, а ведомственному контролёру — о санитарных нормах.

8.2 Санитарно-эпидемиологический надзор

Предмет — соблюдение обязательных требований СанПиН 4282-26 и других санитарных правил: приём продукции, условия хранения, поточность, температуры, сроки раздачи, бракераж, суточные пробы, медицинские осмотры персонала [3]. СанПиН прямо указывает, что оценка соблюдения содержащихся в нём рекомендательных норм не может быть предметом федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (п. 3) [3]. Число блюд на выбор, их набор и сам факт выбора в предмет санитарного надзора не входят, но каждое блюдо проверяется по общим правилам (сценарий 5). Ответственность — ст. 6.6 КоАП (п. 2.11).

8.3 Государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания: кто проверяет государственный дом-интернат

Разделение по форме собственности. С 2021 г. ст. 33 442-ФЗ в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ разделяет государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания на два вида по кругу проверяемых [22]. Федеральный государственный контроль (надзор) распространяется на организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, **и на организации социального обслуживания субъекта Российской Федерации**; региональный государственный контроль (надзор) — только на негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальных предпринимателей (ч. 2 ст. 33) [22]. Федеральный контроль осуществляет Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) по Положению, утверждённому постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 999, которое вступило в силу 01.07.2021 [131]. Предмет контроля в обоих случаях один: соблюдение требований 442-ФЗ, иных федеральных актов и актов субъекта, регулирующих социальное обслуживание, — то есть и региональных норм питания (ч. 2 ст. 33 442-ФЗ; п. 2 Положения) [22, 131].

Исправление. В предыдущей версии этой главы региональный государственный контроль был описан как надзор за государственными домами-интернатами субъекта. Для государственных учреждений это неверно с 01.07.2021: проверяющий орган — Роструд, а орган субъекта выступает учредителем (п. 8.5). Для Санкт-Петербурга то же следует из постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2021 № 985: предмет регионального контроля Комитета по социальной политике — соблюдение требований негосударственными поставщиками и индивидуальными предпринимателями (п. 1.2 Положения); тем же постановлением с 01.01.2022 признано

утратившим силу постановление от 29.12.2014 № 1291, приложение № 2 к которому с 2016 г. наделяло Управление социального питания полномочием регионального контроля «в части, касающейся соблюдения норм питания» (п. 6, 7) [132]. Расхождение внесено в перечень противоречий (гл. 9).

Что спрашивает проверочный лист Роструда. С 24.02.2026 применяется форма проверочного листа, утверждённая приказом Роструда от 02.02.2026 № 18 (опубликован 13.02.2026; заменила форму по приказу от 15.12.2021 № 389) [35]. Из 79 вопросов к питанию прямо относятся четыре:

№ вопроса	Формулировка (сокращённо)	Основание, указанное в листе
17	Обеспечена открытость информации о материально-техническом обеспечении, в том числе об условиях питания	П. 6 ч. 2 ст. 13 442-ФЗ
64	«Поставщиком социальных услуг соблюдаются нормы питания в организациях социального обслуживания?»	П. 1 ч. 1 ст. 12 442-ФЗ
73	Созданы комфортные безопасные условия пребывания, в том числе в помещениях для принятия пищи	Подп. 13 п. 20 Правил по приказу № 305н
75	Обеспечены условия для исполнения религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов, в том числе постов	Подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н

Источник: [35]. Косвенно к питанию относятся вопросы 65 (соблюдение порядка предоставления социальных услуг) и 70 (услуги в объёмах не менее установленных стандартом) [35].

Выводы для вариативного меню (толкование). Во-первых, вопрос 64 сформулирован через нормы питания, то есть через количества продуктов по региональному акту; ни выбор блюд, ни число вариантов, ни учёт предпочтений в питании в листе не упоминаются. Предпочтения названы один раз — в вопросе 46, применительно к размещению по спальням [35]; это та же асимметрия, что в самих Правилах по приказу № 305н (п. 2.4). Во-вторых, вопрос 75 делает соблюдение постов предметом федеральной проверки каждого государственного дома-интерната субъекта: учреждение должно быть готово показать, как житель, соблюдающий пост, получает питание (п. 8.15). В-третьих, проверочный лист не ограничивает проверку: приказ прямо оговаривает, что выездные проверки не сводятся к вопросам листа [35].

8.4 Региональный государственный контроль: только негосударственные поставщики

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляют органы субъектов по положениям, утверждённым высшим исполнительным органом субъекта (п. 2 ч. 1 ст. 33 442-ФЗ) [22]. Его предмет — те же обязательные требования, включая региональные нормы питания, но в отношении негосударственных организаций и инди-

видуальных предпринимателей [22, 132]. Для вариативного меню это различие важно в двух случаях: когда питание в негосударственной организации, включённой в реестр поставщиков, оплачивается по региональному тарифу, и когда субъект передаёт часть стационарного обслуживания негосударственным поставщикам. В обоих случаях региональные нормы питания и порядок предоставления услуги проверяет орган субъекта, а не Роструд (толкование).

8.5 Учредитель

Учредитель государственного учреждения контролирует выполнение государственного задания и финансово-хозяйственную деятельность. Вариативное меню касается учредителя постольку, поскольку меняет структуру расходов на питание, штат или оборудование. Для государственного дома-интерната субъекта учредитель — тот же орган, который в отношении негосударственных поставщиков осуществляет региональный контроль: в Санкт-Петербурге — Комитет по социальной политике (п. 1.3 Положения по постановлению № 985) [132]. Петербургское сообщение о вариативном меню прозвучало на заседании рабочей группы при Комитете по социальной политике [19]; такой формат — учредителя извещают и с ним обсуждают — снижает риск, что практику примут за самовольное отступление от порядка.

8.6 Санкт-Петербург: оценка уровня организации социального питания

В Санкт-Петербурге после отмены полномочия Управления социального питания по региональному контролю за соблюдением норм питания (п. 8.3) [132] у Управления осталась другая процедура — оценка уровня организации социального питания в государственных учреждениях здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления, социального обслуживания и спортивной подготовки по постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873; порядок и методика оценки утверждены распоряжением Управления от 29.11.2023 и применяются с 01.01.2024 [133]. Это не государственный контроль (надзор) по 248-ФЗ, а оценка с рекомендациями и мониторингом их исполнения (толкование по тексту отчёта).

Критерии. Оценка складывается из трёх критериев по 100-балльной шкале: обязательные документы (наличие прав на помещения и оборудование пищеблока, производственный контроль на основе ХАССП, подготовка сотрудников, информирование о питании) — 20 % веса; организация производственного процесса (оснащение, приёмка и хранение продуктов, приготовление блюд) — 40 %; соответствие сырья, продукции и блюд нормативам качества по лабораторным испытаниям подведомственной лаборатории «СОЦПИТ» — 40 % [133]. Учреждению присваивается категория: высшая (100 баллов), 1-я (85–99), 2-я (60–84), 3-я (30–59), 4-я (менее 30) [133].

Результаты. За первое полугодие 2025 г. проведено 418 оценок; в учреждениях социального обслуживания населения — 15, из них 7 получили 1-ю категорию и 8 — 2-ю; средний балл учреждений социального обслуживания (83,83) — самый низкий среди всех типов учреждений при общем среднем 88,02 [133]. По всем учреждениям выдано 1 564 рекомендации; 232 из них связаны с технологией приготовления, и среди

оснований названы ошибки в технологической документации и бракеражном журнале и «факты несоответствия ежедневных меню цикличному меню» [133]. Учреждения по итогам претензионной работы выставили поставщикам штрафы на 1 754 034,89 руб. за полугодие [133].

Для вариативного меню из этой процедуры следуют два вывода (толкование). Первый: критерии оценки не содержат ни показателей выбора, ни показателей съеденного, ни удовлетворённости получателей; родительский контроль качества питания в учреждениях образования методика выделяет особо, а аналогичного механизма участия жителей учреждений социального обслуживания отчёт не описывает [133]. Второй: несоответствие ежедневного меню цикличному фиксируется как недочёт. Поэтому учреждению, вводящему выбор, надо оформить варианты внутри утверждённого цикличного меню (оба — позициями цикла), а не как отступление от него, иначе в отчёте вариативность предстанет нарушением (рекомендация; противоречие внесено в гл. 9).

8.7 Контрольно-счётные органы

Контрольно-счётная палата субъекта проверяет законность и эффективность расходования бюджетных средств, в том числе на питание в подведомственных учреждениях. Пример — проверка Контрольно-счётной палатой Иркутской области расходов на питание в учреждениях министерства социального развития за 2021–2023 гг. (акт от 07.07.2023 по Ново-Ленинскому дому-интернату) [18]. Предмет такой проверки — не выбор и не качество, а соответствие учётных документов фактам: численность жителей на питании по приказам и по меню-требованию, наличие и соблюдение технологических карт, обоснованность списания продуктов; акт рекомендует министерству определить момент, на который «фиксируется» численность жителей для выдачи продуктов, поскольку продукты на госпитализированных выдаются накануне [18]. Для вариативного меню это ещё один контролёр, перед которым у каждой замены должно быть документальное основание (сценарий 13).

8.8 Прокуратура

Прокуратура проверяет соблюдение законов, в том числе прав проживающих, и применяет меры прокурорского реагирования, включая возбуждение дел об административных правонарушениях; примером служит дело по ст. 6.6 КоАП в отношении социально-реабилитационного центра в Кашине [59]. Прокурорский контроль может работать в обе стороны: проверить качество питания и проверить, соблюдаются ли права жителей, предусмотренные ст. 9 442-ФЗ и (для ПНИ) ст. 37 Закона № 3185-1.

8.9 Антимонопольный контроль

ФАС России и территориальные органы контролируют закупки и выявляют картели на торгах продуктами (п. 2.11) [61, 62]. Для вариативного меню риск в том, что спецификацию, составленную под конкретный вариант блюда, сочтут ограничивающей конкуренцию.

8.10 Независимая оценка и общественный контроль

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания проводится по ст. 23.1 442-ФЗ, общественный контроль — по ст. 34 442-ФЗ [22]. Санкций эти механизмы не влекут, но создают учреждению публичную репутацию, а для вариативного меню служат каналом обратной связи от жителей и семей. Уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка в субъектах рассматривают жалобы и готовят доклады; в докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 г. описан пилотный проект «Вариативное меню» в образовательных организациях [70], а не в организациях социального обслуживания взрослых (п. 3.2).

8.11 Внутренний контроль

Внутренний контроль учреждения — бракеражная комиссия, совет (комиссия) по питанию, производственный контроль на основе принципов ХАССП (п. 4 СанПиН 4282-26) [3] — единственный уровень, который видит вариативное меню каждый день. Опыт Усть-Илимска и «Доброго дома „Солнечногорский“» показывает, что коллегиальный орган по питанию берёт на себя пересмотр меню, рассмотрение пожеланий и привлечение внешнего специалиста [12, 27].

Образец локальной формы. Положение об организации питания нижегородского дома-интерната закрепляет внутренний контроль с конкретными параметрами: проверка готовой пищи директором раз в месяц и ежедневно — старшей и диетической медицинскими сёстрами; контрольное взвешивание порционных блюд по 10 порций с допустимым отклонением средней массы не более 3 %; суточная проба от каждой партии; раздача не позднее двух часов после приготовления [44]. Все эти процедуры переходят на вариативное меню без изменения сути, только умножаются на число вариантов (сценарий 13). Ни одна процедура положения не проверяет, что жители съели и довольны ли они: контроль построен на входе (продукты, масса, безопасность), а не на результате (локальная форма; толкование).

Признаки фиктивной вариативности. Рабочая база проекта выделяет признаки разрыва между документом и фактической раздачей: журнал выбора заполнен одной рукой за неделю; более 90 % «стандартных» выборов; жители не помнят, что выбирали; второй вариант «закончился» без записи о срыве; выбор только каши при заявленной полной вариативности [21]. Это рекомендательный чек-лист внутреннего контроля, а не критерий какого-либо надзорного органа.

Учёт возвратов. Стандарт DGE рассматривает учёт возвращённой еды как основу корректировки плана меню, приготовления и подачи и как способ выявлять непопулярные блюда и неверно рассчитанные порции [119]. Для внутреннего контроля вариативного меню это естественный показатель: возвраты по каждому варианту показывают, что выбирают и не доедают. Предел показателю ставит японское исследование CLEVER: расчёт потребления по рецептурам и отходам превышал фактическое потребление в среднем на 15,3 % [100], поэтому низкие возвраты не доказывают достаточности питания конкретного жителя (п. 5.9).

8.12 Как выбор проверяют за рубежом

Зарубежные процедуры проверки отличаются от российских не строгостью, а предметом: проверяют, как учреждение отвечает на волю жителя, — и смотрят это в реальном приёме пищи.

- **США.** Инспектор наблюдает раздачу с первого приёма пищи после прибытия и при отказе жителя от блюда устанавливает, предложена ли замена; опрашивает жителей о соответствии еды их предпочтениям и персонал — о том, как сведения о предпочтениях доходят до кухни; при выявлении нарушения проверяет, учтены ли предпочтения в оценке и плане ухода [114, 115].
- **Онтарио.** Протокол наблюдения за приёмом пищи состоит из закрытых вопросов, привязанных к пунктам регламента: сообщается ли меню, есть ли альтернативы, предлагаются ли запланированные блюда, хватает ли времени, помогает ли сотрудник не более чем одному-двум жителям, рассматривал ли совет жителей время приёмов пищи, сообщаются ли замены [117].
- **Англия.** Руководство CQC связывает выбор с оценкой потребностей в питании и допускает уголовное преследование за нарушение регламента 14, повлёкшее предотвратимый вред [111].
- **Швеция.** Критерии Socialstyrelsen для закупок услуг ухода сформулированы как ощущения и возможности жителя (влияет ли он на время, обстановку, блюда) и пригодны для договора и проверки [121].
- **Дания.** Апелляционное управление в порядке надзора оценило не практику дома, а локальный стандарт качества коммуны и признало незаконным запрет отказываться от отдельных приёмов пищи [122].
- **Япония.** Для «особого питания» по выбору проверяемы формальные гарантии: публичное объявление содержания и цены, согласие, подтверждение врача, отсутствие ухудшения обычного питания [125].

Ни одна из этих процедур не требует определённого числа блюд. Общий знаменатель — наблюдение приёма пищи, опрос жителя и проверка связи между записанным предпочтением и тем, что подали (толкование).

8.13 Чек-лист наблюдения за приёмом пищи для внутреннего контроля

В российских проверочных листах вопросов о выборе нет (п. 8.3), и такой инструмент учреждению придётся сделать самому. Ниже — вопросы, составленные по образцу американской формы CMS-20053 и онтарийского протокола [115, 117] и привязанные к российским основаниям там, где они есть (рекомендация; не является формой какого-либо органа).

№	Вопрос (наблюдение одного приёма пищи)	Источник образца	Российская опора
1	Вывешено ли меню дня с вариантами там, где жители его видят?	[117]	Вопрос 17 проверочного листа Роструда — открытость информации об условиях питания [35]
2	Предложены ли оба варианта каждому, включая жителей, которые едят в комнате?	[115, 117]	—
3	Что сделал персонал, когда житель отказался от блюда?	[114, 115]	—
4	Есть ли запись о срыве, если вариант закончился до конца раздачи?	[21]	—
5	Сидит ли помогающий рядом и помогает ли одновременно не более чем одному-двум жителям, нуждающимся в полной помощи?	[115, 117]	—
6	Подают ли еду жителю, которому нужна помощь, только когда помогающий свободен?	[117]	—
7	Дают ли время доест, не убирают ли тарелки, пока за столом едят?	[115]	—
8	Сообщены ли замены (продукт отсутствует, блюдо заменено) жителям и персоналу?	[117]	Замены по таблице (п. 2.6, сценарий 11)
9	Совпадает ли поданное с картой предпочтений жителя, не способного выбрать вербально?	[114]	Открытый вопрос автора и РГ (сценарий 15)
10	Получил ли житель, соблюдающий пост, постный вариант?	—	Подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н; вопрос 75 проверочного листа [25, 35]

Ответы фиксируются по одному наблюдению на отделение в неделю (рекомендация). Чек-лист дополняет, а не заменяет бракераж, взвешивание порций и суточную пробу.

8.14 Документы для проверяющего: кто что смотрит

Документальная цепочка одного дня вариативного меню (сценарий 13) отвечает разным контролёрам. Ниже — какое звено на чей вопрос отвечает (толкование; формы — по нижегородскому положению [44]).

Звено	Роспотребнадзор	Роструд (государственная организация) / орган субъекта (негосударственная)	Учредитель	Внутренний контроль
Утверждённое цикличное меню с вариантами	Пищевая ценность, наличие ТТК (п. 11 СанПиН 4282-26) [3]	Выполнение норм питания (вопрос 64) [35]	—	Отклонения от цикла как вариант, а не нарушение (п. 8.6)
Порционник и сводка по вариантам	—	—	Обоснование числа порций	Распределение выбора
Меню-раскладка и требование на склад	—	Норма по группам продуктов	Расход продуктов, закупка	Сверка с порционником
Технологические карты каждого варианта	Да (п. 11) [3]	—	—	—
Бракеражный журнал	Каждый вариант (подп. 13 п. 56) [3]	—	—	Да
Журнал контрольного взвешивания	—	—	—	10 порций, ≤3 % [44]
Суточная проба	Открытый вопрос (сценарий 13)	—	—	—
Накопительная ведомость с замечаниями	—	Нормы за период с учётом замен	Фактический расход	Эквиваленты по таблице
Учёт остатков и возвратов	Запрет реализации на следующий день (п. 32) [3]	—	Списания	Возвраты по вариантам [119]
Запись о постном питании	—	Условия для соблюдения постов (вопрос 75) [35]	—	Да
Протоколы совета по питанию	—	Порядок предоставления услуги (вопрос 65) [35]	—	Пересмотр меню

8.15 Пост как предмет проверки

С 01.09.2025 обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов закреплена в подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н [25], а с 24.02.2026 она прямо включена в проверочный лист Роструда как вопрос 75 [35]. Проверяющий вправе спросить, как житель, соблюдающий пост, получает питание; учреждение без вариативного или индивидуального постного варианта должно показать иной способ (толкование). Одновременно вопрос 64 того же листа проверяет выполнение региональных норм питания [35], а в проанализированных региональных актах положений о замене продуктов животного происхождения растительными нет, как нет растительного эквивалента мяса и в таблице замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26 (п. 2.6, сценарий 16). Выходит, что два вопроса одного проверочного листа могут требовать от учреждения трудно совместимого: постного питания и выполнения норм по мясу и молоку за тот же период. Противоречие внесено в гл. 9; предложение — в гл. 10.

Минимальный комплект на время поста (рекомендация): список жителей, заявивших о соблюдении поста (с датой и подписью или отметкой о способе выражения воли); постный вариант в утверждённом меню; накопительная ведомость с отражением замен и пояснительной запиской о невыполнении норм по отдельным группам продуктов, если оно возникло; протокол совета по питанию, согласовавшего постное меню.

8.16 Сводка

Контролёр	Предмет	Что спросит о вариативном меню	Основание
Роспотребнадзор	Обязательные санитарные требования	ТТК, бракераж, пробы, сроки раздачи каждого варианта	СанПиН 4282-26; ст. 6.6 КоАП
Роструд (организации субъекта)	Требования 442-ФЗ, федеральных актов и актов субъекта	Нормы питания; условия для соблюдения постов; условия в помещениях для приёма пищи; информация об условиях питания	Ст. 33 442-ФЗ; пост. № 999; проверочный лист по приказу № 18
Орган субъекта (негосударственные поставщики)	То же	То же	Ст. 33 442-ФЗ; региональное положение о контроле
Учредитель	Госзадание, финансы	Расходы, штат, оборудование	Устав, госзадание
Управление социального питания (СПб)	Оценка уровня организации питания	Документы, производство, лабораторные показатели; соответствие ежедневного меню цикличному	Пост. СПб № 873; распоряжение УСП 2023 г.
Контрольно-счётный орган субъекта	Законность и эффективность расходов	Численность на питании, технологические карты, списание продуктов, оформление замен	Закон о КСП субъекта; акт [18]

Контролёр	Предмет	Что спросит о вариативном меню	Основание
Прокуратура	Законность, права жителей	Качество питания; права на выбор и уважение	Закон о прокуратуре; 442-ФЗ; 3185-1
ФАС	Конкуренция на торгах	Спецификации, картели	44-ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ
Независимая оценка, общественный контроль	Качество условий	Удовлетворённость	Ст. 23.1, 34 442-ФЗ
Внутренний контроль	Всё перечисленное, ежедневно	Реальность выбора; съеденное; возвраты	Локальные акты; п. 4 СанПиН 4282-26

9 Противоречия и нерешённые вопросы

9.1 Принцип

Материалы семинара 2026 г. — первая редакция обзора, доклад «Не просто накормить», предшествующие аналитические записки и рабочая база знаний проекта — писались в разное время, разными методами и при разном доступе к источникам, и расхождения между ними неизбежны. Ниже они перечислены без сглаживания: в чём расхождение, как его разрешает первоисточник и что остаётся открытым. Номера в скобках — пункты перечня противоречий рабочей базы знаний [21], где он есть.

9.2 Перечень

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
1	Нормы взаимозаменяемости к постановлению № 12: «приложение 6» (первая редакция [1]) против «приложение 7»	В действующей редакции — приложение № 7; кроме того, есть приложение № 8 «Замена продуктов по белку и углеводам» [29]	Снято
2	Таблица замен приложения № 11 к СанПиН как основание для взрослых (первая редакция, канон, отраслевые материалы)	Нормативно таблица относится к питанию детей (подп. 4 п. 59 СанПиН 4282-26; п. 8.1.4 СанПиН 3590-20) [2, 3]; для взрослых — аналогия	Снято как норма, остаётся как рекомендация
3	Приказ № 520н отсутствует в первой редакции; федеральный блок построен на постановлении № 12 [1]	Действующие рекомендуемые нормы — приказ № 520н [30]; № 12 не отменено	Снято
4	СанПиН 3590-20 «действует до 01.01.2027» (первая редакция [1]) (7)	Утратил силу с 01.09.2026 в связи с введением СанПиН 4282-26 [3]; первоначальный срок действия действительно был установлен до 01.01.2027	Снято
5	Ст. 6.3 КоАП (первая редакция) против ст. 6.6 КоАП (канон) (15)	Общая и специальная нормы; для организации питания — ст. 6.6 [58]	Снято
6	Плата не более 75 %: ч. 4 ст. 32 442-ФЗ (канон) против п. 35 приказа № 935н (первая редакция) (14)	Обе ссылки верны: норма закона воспроизведена в примерном порядке [22, 23]	Снято

№	Расхождение	Разрешение по перво- источнику	Статус
7	Приказ «№ 774н» как акт о нормах питания (академический слой) (13)	По открытым источникам не подтверждён	Не используется
8	Болотнинский ПНИ: модель 1 и модель 4 одновременно в первой редакции (10)	По тексту сообщения — М1 по шкале раздачи; деталь «выбор накануне» в источнике отсутствует [5]	Снято для v2
9	«Без существенного роста затрат» против «объективно дороже» в первой редакции (17)	Ни одно утверждение не основано на расчётах; зарубежные данные — рост на 9–20 % [78]; петербургский кейс называет оборудование и сотрудников [19]	Открыто: нужны российские данные
10	Пилот «Вариативное меню» в Санкт-Петербурге как пример практики ДСО (первая редакция) (20)	Пилот относится к образовательным организациям [70]	Снято
11	«Практика стран СНГ» без источников (первая редакция)	Источников не найдено	Исключено
12	Закон № 3185-1 отсутствует в первой редакции (16)	Для ПНИ применяются ст. 37 и 43 [24]	Снято
13	Hugo и соавт.: 8 австралийских долларов как стоимость «сырья» (канон [20])	8,00 — весь кейтеринг; сырьё — 6,08 [109]	Снято
14	Нормы СПб для ПНИ: одна норма с СБКС (первая редакция)	В постановлении № 1284 две нормы для ПНИ — с СБКС и без неё [31]	Снято
15	Суточная проба на собственном пищеблоке организации социального обслуживания	Подп. 4 п. 56 СанПиН 4282-26 говорит о медицинских организациях, подп. 12 — о готовых блюдах от сторонней организации [3]; для собственного пищеблока прямой нормы нет	Открыто; рекомендация — отбирать
16	«Субсидия на госзадание нередко остаётся в 44-ФЗ» для автономного учреждения (рабочая база)	По ч. 4 ст. 15 44-ФЗ автономное учреждение применяет 44-ФЗ при закупках за счёт субсидий на капитальные вложения, а не на госзадание [50]	Уточнено; применение к конкретному учреждению — вопрос его положения о закупке

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
17	Иерархия каналов воли: биография первой (канон, гл. 15.4) против текущего предпочтения первым (гл. 15.9) (2)	Первоисточник права не даёт ответа	Открыто; решение автора
18	«Принудительное кормление запрещено» (канон) против «прямого запрета не найдено» (аудиторский слой) (9)	Прямого запрета в проверенных актах не найдено; ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1 гарантирует гуманное отношение, исключающее унижение достоинства [24]	Открыто; требует правовой экспертизы
19	Календарь пилота: 90 дней (канон) против 12–24 месяцев (предшествующая записка)	Разные задачи — пилот и перестройка	Не противоречие
20	Определение вариативности: в момент еды (канон) / на приём или заказ заранее (первая редакция) / на период (предшествующая записка) (6)	Определения разных слоёв; v2 использует каноническое как рабочее, остальные описывает	Не сводится
21	Успенский ПНИ: «М2, шведской линии нет» (рабочая база)	Верно для сообщения 2024 г. [7]; в 2025 г. — «Шведский стол» в части отделений [8]	Снято с указанием дат
22	Усть-Илимский ДСО отнесён к ПНИ (рабочая база)	По сообщениям — бывший дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» [12]	Снято
23	Распоряжение Московской области № 19РВ-32 как медицинский «мостик» к лечебному питанию (рабочая база)	По сайту учреждения — нормы питания в ПНИ; ссылка на приказ № 330 относится к совету по питанию [27]	Снято
24	Нормы питания Москвы: приказ ДТСЗН № 228 (первая редакция) против постановления № 1068-ПП (библиография канона)	№ 1068 — приказ Департамента социальной защиты населения Москвы от 24.12.2014, а не постановление «-ПП» [71]; в приказе № 228 прочитаны п. 1–2.1, в том числе допуск ± 5 % калорийности по приёмам пищи при соблюдении среднего за неделю [63]	Частично снято: соотношение двух приказов не установлено
25	Псковская область: приказ Комитета № 206 (первая редакция) против «постановления администрации № 206» (библиография канона)	Реквизиты по первой редакции и международной базе FAOLEX — приказ [74]	Вероятно снято; требует сверки

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
26	Иркутская область: «два первых, два вторых, гарниры» в регионе	Министр подтвердил запуск вариативного питания в 2025 г. и планы элементов шведского стола [17]; формат «два первых, два вторых» известен только из пересказа агрегатора, первоисточник министерства не найден [13]	Частично снято: факт запуска подтверждён, формат — нет
27	Объём первой редакции: 82 с. (PDF) против «83 страницы» (презентация) (18)	Техническое расхождение	Не влияет на содержание
28	Федеральная основа права на пост: только ст. 37, 43 Закона № 3185-1 для ПНИ (материалы семинара, первая редакция обзора)	С 01.09.2025 подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н обязывает все организации социального обслуживания обеспечивать условия для соблюдения постов [25]; приказ в материалах семинара не упоминался	Снято: пробел восполнен
29	Самообслуживание («шведский стол» в Успенском ПНИ, линия самообслуживания в «Солнечногорском») против санитарного контура раздачи	СанПиН 4282-26 специальных требований к самообслуживанию в организациях социального обслуживания не содержит (поиск по тексту); общие требования п. 32 — предел трёх часов для блюд, требующих разогревания, запрет реализации остатков на следующий день — применяются к блюдам на линии [3]. Сообщения учреждений не описывают, как эти требования выполняются [8, 27]	Открыто: нарушение не установлено, но и соблюдение не показано

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
30	Какой санитарный акт применим: СП 2.4.3648-20 (предшествующая записка), СанПиН 2.1.3684-21 (академический слой), СанПиН 3590-20 «до 01.01.2027» и СанПиН 1.2.3685-21 (первая редакция) (7)	СП 2.4.3648-20 регулирует организации для детей и молодёжи; СанПиН 2.1.3684-21 (содержание территорий, водоснабжение, помещения) и СанПиН 1.2.3685-21 (гигиенические нормативы факторов среды) к организации питания относятся косвенно. Организацию питания регулировал СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026) и регулирует СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026) [2, 3]	Снято: в докладе указан слой времени для каждой ссылки
31	Нормы Ленинградской области: «постановление Правительства Ленинградской области № 458» (материалы семинара [20])	Акт не найден; действующие нормы — приказ комитета по социальной защите населения от 30.12.2021 № 04-58, приложение 3 [42]	Снято
32	Кто проверяет государственный дом-интернат субъекта: «региональный государственный контроль» (предыдущая версия гл. 8 настоящего доклада)	С 01.07.2021 по ст. 33 442-ФЗ в ред. № 170-ФЗ организации субъекта подлежат федеральному государственному контролю (Роструд); региональный контроль — только негосударственные поставщики [22, 131]; в Санкт-Петербурге полномочие Управления социального питания по контролю норм питания отменено с 01.01.2022 [132]	Снято: исправлено в гл. 2, 7, 8, 10
33	Определение ВС РФ № 303-ЭС25-15393 как «окончательная точка»: закупки по госзаданию — только 44-ФЗ, критерий — источник денег (отраслевой блог [54])	Постановление округа ставит критерием цель закупки, а не источник денег [53]; комментарий ГАРАНТ.РУ делает более узкий вывод [56]; блог неверно излагает предмет договора и позицию апелляции; под этим номером в открытой базе найдено только определение об отсрочке госпошлины [55]	Открыто: определение по существу не найдено; вывод п. 2.10 — толкование

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
34	Тарифы на питание в Санкт-Петербурге при неизменных нормах № 1284: разница «с СБКС / без СБКС» в ПНИ 90,77 руб. (2025) и 43,21 руб. (2026); тариф ПНИ выше общего в 2025 г. и ниже в 2026 г.	Нормы с 27.06.2022 не менялись [31]; тарифы — [68, 69]; методика расчёта не опубликована	Открыто: причина изменения не установлена (п. 3.2)
35	Цикл обеда в стандарте DGE: «не менее 4 недели» (предыдущая версия гл. 6 настоящего доклада)	Для учреждений — не менее 6 недель; 4 недели — для доставки на дом [119]	Снято: исправлено
36	Место специализированной белковой смеси (СБКС) в нормах: по медицинским показаниям (Новосибирская обл.) против включения в общую норму (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., ХМАО — Югра)	Разные региональные модели [31, 42, 43, 65]	Не противоречие; препятствие для прямого сравнения норм (п. 3.14)
37	Пост против норм: обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов (подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н; вопрос 75 проверочного листа Роструда) против выполнения норм питания по мясу и молоку (вопрос 64 того же листа)	Растительного эквивалента мяса нет ни в таблице замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26, ни в проанализированных региональных актах [3, 25, 35]	Открыто: требуется разъяснение (гл. 10, предложение 6)
38	Вариативное меню против оценки Управления социального питания Санкт-Петербурга, где «несоответствие ежедневных меню циклическому меню» фиксируется как недочёт	Методика оценки не содержит критериев выбора [133]	Открыто; разрешимо оформлением вариантов внутри цикла (п. 8.6)
39	Сопоставление граммов региональных норм между собой и с № 520н	Нормы Красноярского края и Новосибирской области выражены в брутто, Санкт-Петербурга, ХМАО и Нижегородской области — в нетто, Ленинградской области — в обеих величинах [31, 41–43, 64, 65]	Снято методически: прямое сравнение без пересчёта некорректно (п. 3.12)

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
40	Номер дела в определении ВС от 29.12.2025 № 303-ЭС25-15393: «А32-55513/2024» в тексте против А73-20917/2024 на странице базы и в постановлении округа	Вероятна опечатка в тексте определения; стороны и суды совпадают с делом А73-20917/2024 [53, 55]	Техническое расхождение

9.3 Что из этого следует для читателя

Пункты 1–6, 10, 12–14, 21–23, 28, 30–32 и 35 — исправленные факты или восполненные пробелы; вторая редакция пользуется исправленными версиями. Два из них (32 и 35) исправляют ошибки самой второй редакции, найденные при дополнении: правило называть расхождения явно доклад распространяет и на себя. Пункты 9, 15, 17, 18, 24, 26, 29, 33, 34, 37 и 38 — открытые вопросы; сверх установленного доклад по ним ничего не утверждает. Пункты 19, 20 и 36 отражают разные задачи, определения или региональные модели и выбирать между ними не требуется; пункты 39 и 40 — методические и технические.

10 Предложения

Все предложения этого раздела — рекомендации автора как директора учреждения и участника профессиональной дискуссии. Они не выражают позицию Минтруда России, рабочей группы или иного органа и не являются нормами. При каждом предложении сказано, на какую проблему из глав 2–9 оно отвечает и на какой образец опирается; где образца нет, это оговорено.

10.1 Федеральный уровень

1. **Определение.** В методическом документе федерального уровня (без изменения закона) закрепить рабочее определение вариативного питания и разграничить его с цикличным меню, таблицей замен и персонализацией (п. 1.2). Без общего словаря одну и ту же практику разные проверяющие оценивают по-разному.
2. **Таблица замен для взрослых.** Утвердить таблицу замен пищевой продукции для взрослых в организациях социального обслуживания или прямо распространить на них приложение № 11 к СанПиН 4282-26. Пока учреждения применяют детскую таблицу по аналогии (п. 2.6).
3. **Учёт норм по периоду.** Разъяснить, что выполнение норм питания в организациях социального обслуживания оценивается по среднему за период с учётом замен по утверждённой таблице, по образцу подп. «в» подп. 2 п. 59 СанПиН 4282-26 для детей [3]. Единственная найденная региональная опора для взрослых — п. 2.1 московского приказа № 228, допускающий отклонение калорийности по приёмам пищи на $\pm 5\%$ при соблюдении среднего за неделю [63]; она годится как образец формулировки.
4. **Суточная проба.** Устранить пробел о суточной пробе на собственном пищеблоке организации социального обслуживания (гл. 9, позиция 15) и отдельно указать, отбирается ли проба каждого варианта блюда (сценарий 13; вопрос оставлен открытым по решению автора).
5. **Формула альтернативы.** При возможном регулировании выбора опираться не на число блюд, а на формулу «альтернатива сходной пищевой ценности по запросу», известную по американскому праву [113], и на онтарийскую модель цикла меню с выбором, утверждаемого диетологом при участии совета жителей [116]. Американское руководство для инспекторов показывает, что такая формула проверяема: предмет проверки — ответ учреждения на отказ конкретного жителя от блюда [114]. Предложение первой редакции обзора закрепить «не менее двух вариантов на основные приёмы пищи» [1] исполнимо не во всех учреждениях и ничего не даёт жителям, не способным выбрать слова-ми.
6. **Постное питание.** Разъяснить, как обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов (подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н) [25] выполняется в пределах региональных норм питания: какие замены мяса и молочных продуктов допустимы и по какой таблице. Сейчас в проверочном листе Роструда соседствуют вопрос 64 о соблюдении норм питания и вопрос 75 об условиях

для соблюдения постов [35], а растительного эквивалента мяса нет ни в таблице замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26, ни в проанализированных региональных актах (сценарий 16; гл. 9, позиция 37). Без разъяснения учреждение, исполняя одну федеральную обязанность, рискует получить претензию за невыполнение норм по отдельным группам продуктов. Хватило бы дополнить таблицу замен строками растительных источников белка с коэффициентами по белку (предложение 2).

7. **Брутто и нетто.** В рекомендуемых нормах (приказ № 520н) и в методических материалах для субъектов прямо указывать, в каких единицах (брутто или нетто) выражена каждая позиция, и рекомендовать субъектам делать то же. Из шести прочитанных региональных актов два выражены в брутто, три в нетто, один в обеих величинах, и сравнивать граммы между ними и с № 520н напрямую нельзя (п. 3.12; гл. 9, позиция 39).
8. **Показатели результата.** В методических материалах о вариативном питании предусматривать не только описание формата, но и минимальный набор измеряемых показателей — распределение выбора, производственные отходы, отходы с тарелки, удовлетворённость (п. 7.18). Зарубежный опыт показывает, что учреждение способно измерить их само [78, 98]; пределы отходов как меры съеденного показало исследование CLEVER [100].
9. **Вопрос о выборе в проверочном листе.** При пересмотре формы проверочного листа федерального контроля рассмотреть вопрос, сформулированный по образцу американского и онтарийского: «предлагается ли получателю, отказавшемуся от блюда, замена в пределах норм питания?» [114, 117]. Действующий лист содержит 79 вопросов, из которых ни один не касается учёта предпочтений в питании; предпочтения упомянуты только применительно к размещению в спальнях (вопрос 46) [35]. Такой вопрос не требует от учреждения определённого числа блюд и совместим с действующими нормами.
10. **Совет по питанию с участием жителей.** В методических материалах описать коллегиальный орган по питанию с участием жителей и родственников по образцу шведских советов по питанию (måltidsråd) [121] и онтарийского требования о рассмотрении времени приёмов пищи советом жителей [117]. Российские учреждения уже создают такие органы по локальному решению [12, 27], а петербургская методика оценки организации питания выделяет родительский контроль для учреждений образования, но не описывает аналогичного механизма для учреждений социального обслуживания [133].

10.2 Региональный уровень

1. **Нормы группами.** При пересмотре региональных норм формулировать позиции группами продуктов с допустимыми заменами внутри группы и указывать источник таблицы замен между группами (п. 3.15). Образец локальной формы — таблицы взаимозаменяемости и замены по белкам и углеводам, утверждённые положением нижегородского дома-интерната [44].
2. **Раскрытие методики тарифа.** Публиковать вместе с тарифом на обеспечение питанием методику расчёта или хотя бы стоимость набора по группам про-

дуктов. В Санкт-Петербурге при неизменных нормах № 1284 разница между двумя ПНИ-тарифами за год уменьшилась с 90,77 до 43,21 руб., а соотношение тарифов ПНИ и общего поменяло знак; по опубликованным документам нельзя установить, что изменилось — цены или методика (п. 3.2; гл. 9, позиция 34). Без методики учреждение не может доказать учредителю ни того, что выбор стоит денег, ни того, что не стоит.

3. **Организационная составляющая выбора.** При расчёте тарифа учитывать не только продуктовый набор, но и организационную составляющую выбора, если субъект поддерживает вариативное питание как политику (п. 3.2). Порядок величины этой составляющей показывают сценарии 8 и 14 (иллюстративно) и опубликованные российские кейсы: дополнительная линия раздачи в Успенском ПНИ обошлась более чем в 3 млн руб. [10].
4. **Оценка организации питания.** В субъектах, где действует процедура оценки организации питания вне государственного контроля (как в Санкт-Петербурге [133]), дополнить критерии показателями выбора и результата (распределение выбора, возвраты, опрос жителей) и прямо указать, что варианты блюд, предусмотренные утверждённым циклическим меню, не являются «несоответствием ежедневного меню циклическому» (гл. 9, позиция 38).
5. **Методическая площадка.** Использовать опыт межрегиональных методических площадок (Вологодская область, 2026 г. [16]) и требовать от участников публикации измерений (отходы, распределение выбора, удовлетворённость), а не только описаний.

10.3 Уровень учреждения

1. **Начинать с пары внутри группы** в одном приёме пищи одного отделения (сценарии 2, 9 и 11).
2. **Варианты — внутри цикла.** Вносить оба варианта в утверждённое циклическое меню как его позиции, а не оформлять выбор как ежедневное отклонение от цикла (п. 8.6, сценарий 13).
3. **Закрепить порядок локальным актом** до начала и подготовить комплект документов для проверяющего с распределением звеньев документальной цепочки по контролёрам (сценарии 7 и 13, п. 8.14).
4. **Лоты по группам продуктов.** В положении о закупке и документации по 223-ФЗ формировать лоты и спецификации по группам продуктов с коридором объёмов внутри группы, а не под конкретное блюдо (сценарий 12); закупки бюджетного учреждения по 44-ФЗ планировать с учётом ограничения изменения объёма (сценарий 6).
5. **Пищевая биография при поступлении.** Собирать сведения о привычках и предпочтениях в питании при поступлении, в том числе со слов родственников, по образцу Essbiografie стандарта DGE [119] и опроса семьи у Yaxley и соавт. [128]; эти сведения — основа решений за тех, кто не может выразить выбор (сценарий 15).

6. **Измерять до и после** хотя бы отходы с тарелки, возвраты по каждому варианту и распределение выбора (сценарий 8, п. 7.18), помня, что низкие возвраты не доказывают достаточности питания конкретного жителя [100].
7. **Наблюдать приём пищи.** Еженедельно проводить в каждом отделении наблюдение одного приёма пищи по чек-листу, построенному по образцу американской и онтарийской форм (п. 8.13) [115, 117].
8. **Включать неговорящих и маломобильных** с первого этапа, а не после «отладки на ходячих» (сценарии 4, 10 и 15).
9. **Публиковать результаты** с датами и числами, включая неудачи. Пока российские сообщения — это описания без измерений (п. 4.11), спор о пользе и вреде выбора останется спором мнений.

11 Заключение

Исследование сводится к десяти выводам. Класс каждого утверждения указан в соответствующем разделе; ссылки, уже приведённые в тексте, здесь повторяются не везде.

- 1. Право не предписывает и не запрещает выбор блюд.** Закон № 442-ФЗ требует обеспечивать питание по нормам, утверждённым субъектом Российской Федерации, и закрепляет за получателем право на уважительное и гуманное отношение и на участие в составлении индивидуальной программы (ст. 9) [22]. Ни приказ № 935н, ни приказ № 520н, ни Правила организации деятельности организаций социального обслуживания (приказ № 305н), ни санитарные правила не устанавливают числа блюд на выбор [2, 3, 23, 25, 30, 35, 36, 131]. Для жителей ПНИ к этому добавляются гарантии Закона № 3185-1, включая право соблюдать религиозные каноны (ч. 2 ст. 37 в силу ст. 43) [24], а с 01.09.2025 обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов возложена на все организации социального обслуживания (подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н) [25]. Поэтому постный вариант блюда в пост — исполнение обязанности, а не инициатива кухни.
- 2. Смена санитарных правил не изменила ответа на вопрос о выборе, но изменила его цену.** С 01.09.2026 действует СанПиН 4282-26; СанПиН 3590-20 применяется к документам и событиям до 31.08.2026 [2, 3]. Новый акт, как и прежний, о числе вариантов молчит, но требованиями к технологическому документу на каждое блюдо (п. 11), трёхчасовым пределом на раздаче и запретом реализовать остатки на следующий день (п. 32), бракеражем каждого блюда (подп. 13 п. 56) превращает каждый дополнительный вариант в отдельный объект производственного контроля.
- 3. Главный правовой пробел — механизм эквивалентной замены для взрослых.** Таблица замен СанПиН (приложение № 11) адресована разделу о питании детей; для взрослых в социальном обслуживании её применяют по аналогии, а единственный федеральный документ о замене, адресованный этим учреждениям, — приложение № 7 к рекомендациям 2002 г. — носит рекомендательный характер. Положений о замене не содержат ни постановление Санкт-Петербурга № 1284, ни прочитанные полностью акты Новосибирской и Нижегородской областей, Красноярского края и Ленинградской области; растительного эквивалента мяса нет и в таблице СанПиН, что делает постное питание уязвимым перед проверкой норм. Поэтому выбор между мясом и рыбой юридически уязвимее выбора между гречкой и рисом, хотя по пищевой ценности обе пары могут быть равноценны.
- 4. Региональные нормы дают выбору больше простора, чем принято считать.** Нормы № 1284 сформулированы по группам продуктов; внутри группы (крупы, овощи, мясо разных видов) учреждение вправе составлять пары блюд без обращения к таблице замен. Выполнение нормы по среднему за период прямо закреплено только для детей (подп. «в» подп. 2 п. 59 СанПиН 4282-26); для взрослых это толкование, требующее закрепления в локальном акте.

5. **Российская практика выросла, но не измерена.** За 2024–2026 гг. найдены сообщения восьми учреждений и одного регионального органа, а министр социального развития Иркутской области подтвердил запуск вариативного питания в регионе в 2025 г. [17]: от выбора в момент еды из двух вторых блюд (Болотнинский, Каменский, Успенский, Усть-Илимский) до самообслуживания («шведский стол» в Успенском, линия раздачи в Солнечногорском) и заказа на кануне (Серафимовский). С июня 2026 г. в Вологодской области работает межрегиональная площадка. Ни одно учреждение не опубликовало данных о потреблении или отходах; единственные опубликованные ресурсные цифры — стоимость линии раздачи (более 3 млн руб.) и сокращение времени обеда с 2,5 ч до 50 мин в Успенском ПНИ [10, 11]. Сообщения учреждений — самоотчёты, а не результаты проверки.
6. **Научные данные не подтверждают главного опасения.** В исследованиях домов престарелых выбор связан с более высокой удовлетворённостью; в работе Wheeler и соавт., где сопоставлен состав съеденного при старой и новой системе, блюда из меню с выбором содержали чуть больше белковых продуктов и овощей [78]. Те же данные показывают цену выбора в момент еды: рост производственных отходов и стоимости примерно на 9–20 % [78]. Систематические обзоры оценивают эффект вмешательств в организацию питания на пищевой статус как небольшой и плохо измеренный [90, 91]. Исследований вариативного меню в психиатрических учреждениях длительного пребывания нет; опасение, что жители ПНИ будут систематически выбирать «вредное», опирается на данные о потреблении вне учреждений [93] и в условиях нормированного набора не проверено.
7. **Зарубежное право регулирует не число блюд, а альтернативу и участие.** Регламент CQC в Англии требует учитывать предпочтения, федеральные требования США — предлагать альтернативу сходной пищевой ценности, регламент Онтарио — цикл меню с выбором, согласованный с советом жителей [110, 113, 116]; немецкий стандарт DGE — несколько линий меню, пищевую биографию и учёт возвратов, шведские рекомендации — влияние жителя на блюда, время и обстановку, японское право — выбор сверх базового питания с гарантией, что базовое не ухудшится [119, 121, 125]. Ни один из изученных актов не устанавливает минимального числа вторых блюд. Перенести эти формулы в российское право можно только актом федерального или регионального уровня.
8. **Выбор, недоступный жителю, не является выбором.** И австралийские данные о низком выборе для получающих протёртую пищу [81], и канадские данные о том, что пища изменённой консистенции назначена 47 % жителей [101], показывают: вариативное меню, рассчитанное на ходячих и говорящих, может не дойти до значительной части дома. Включить маломобильных и невербальных жителей — условие, а не следующий этап.
9. **Проверка смотрит на нормы, а не на выбор.** С 01.07.2021 государственные организации социального обслуживания субъектов подлежат федеральному государственному контролю Роструда, а региональный контроль распространяется только на негосударственных поставщиков [22, 131]. Проверочный лист 2026 г. спрашивает о соблюдении норм питания и об условиях для соблюдения

постов, но ни об учёте предпочтений в питании, ни о замене блюда при отказе [35]. Зарубежные процедуры, напротив, проверяют ответ учреждения на волю жителя, наблюдаемый в реальном приёме пищи [114, 115, 117]. Пока у нас этого нет, проверить, реален ли выбор, может только внутренний контроль учреждения.

- 10. Противоречия не устранены, а названы.** Глава 9 перечисляет 40 расхождений между нормами, толкованиями, кейсами и предшествующими материалами семинара, включая исправленные в этой редакции фактические ошибки. Часть из них снимет только орган, уполномоченный разъяснять или издавать нормы.

Для руководителя учреждения практический итог — четыре требования, обоснованные в главе 7: закрепить порядок вариативного питания и источник таблицы замен локальным актом до начала; обеспечить каждый вариант технологическим документом, бракеражем и пробой; оформлять варианты как позиции утверждённого циклического меню, а не как отклонения от него; измерять результат — хотя бы распределение выбора и отходы с тарелки — до и после изменений. Предложения главы 10 — рекомендации автора; позицию какого-либо органа они не выражают.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Пометка [н] — источник, впервые привлечённый во второй редакции; [о] — источник, использованный и в первой редакции [1].

1. [о] Вариативное меню: НПА. Нормативно-правовое регулирование и региональная практика: доклад (литературная редакция 29.08.2026). 82 с. — Репозиторий qlolp/seminar-variable-food-2026, папка raw/sources/variativnoe-menu-npa-2026/.
2. [о] СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; утратил силу с 01.09.2026). — URL: <https://base.garant.ru/74891586/> (дата обращения: 05.10.2026).
3. [н] СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18; зарег. в Минюсте России 02.06.2026 № 86854; действует с 01.09.2026 до 01.09.2032). — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/414229257/> (дата обращения: 05.10.2026).
4. [н] Как устроены ПНИ в России: исследование / Проект «Если быть точным». 09.04.2026. — URL: <https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym> (дата обращения: 23.07.2026).
5. [о] Вариативное питание / ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат». 16.08.2024. — URL: <https://bpni.nso.ru/news/2312> (дата обращения: 05.10.2026).
6. [н] Вариативное питание — выбор за вами! / ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат». 03.09.2026. — URL: <https://bpni.nso.ru/news/8993> (дата обращения: 05.10.2026).
7. [н] Наше стремление — сделать питание не только вкусным и разнообразным, но и комфортным... / ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат». 13.08.2024. — URL: <https://upni.nso.ru/news/1916> (дата обращения: 05.10.2026).
8. [н] Разумная Т. Успенский интернат расширяет «Шведский стол»: теперь и в третьем отделении проживающие сами выбирают блюда // ЧС-ИНФО. 23.10.2025. — URL: <https://4s-info.ru/2025/10/23/uspenskij-internat-rasshiryayet-shvedskij-stol-teper-i-v-tretem-otdelenii-prozhivayushhie-sami-vybirayut-blyuda/> (дата обращения: 05.10.2026).
9. [н] Вариативное питание означает наличие нескольких вариантов меню в столовой / ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат». 19.08.2024. — URL: <https://kpi.nso.ru/news/395> (дата обращения: 05.10.2026).
10. [н] Софин Р. Шведский стол за 3 млн приучил к аккуратности жильцов психинтерната НСО // Прецедент TV. 27.07.2026. — URL: <https://precedent.tv/shvedskij-stol-za-3-mln-priuchil-k-akkuratnosti-zhiltsov-psihinternata-nso> (дата обращения: 05.10.2026).

11. [н] Наша главная задача — не просто накормить, а создать домашнюю атмосферу / ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат». 27.07.2026. — URL: <https://upni.nso.ru/news/5804> (дата обращения: 05.10.2026).
12. [н] ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания». Публикации: «Что за „зверь“ такой? Вариативное питание» (27.09.2024); «Четыре месяца — время анализов и результатов» (17.12.2024); «Что у Вас сегодня на ужин?» (13.02.2025); «Совет по питанию» (09.02.2026). — URL: <https://ui-ogbuso.ru/novosti/> (дата обращения: 05.10.2026).
13. [н] Вариативное питание в стационарных учреждениях социального обслуживания Иркутской области (пересказ сообщения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) // Безформата. 14.02.2025. — URL: <https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/> (дата обращения: 23.07.2026; при повторном обращении 05.10.2026 доступ ограничен).
14. [н] В Чунском доме соцобслуживания завершается строительство двух модульных жилых корпусов / Пресс-служба Правительства Иркутской области // Областная газета. 26.11.2025. — URL: <https://www.ogirk.ru/2025/11/26/v-chunskom-zavershaetsja-stroitelstvo-dvuh-modulnyh-zhilyh-korpusov/> (дата обращения: 05.10.2026).
15. [н] Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 193-мпр «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». — URL: <https://base.garant.ru/34763286/> (дата обращения: 05.10.2026).
16. [н] Вариативное меню появляется в домах соцобслуживания Вологодчины // СеверИнфо. 05.07.2026. — URL: <https://www.severinfo.ru/society/91519-variativnoe-menju-rojavljaetsja-v-domah-socobsluzhivanija-vologodchiny.html> (дата обращения: 05.10.2026).
17. [н] Шагунова Л. Владимир Родионов: На приёме в службах соцзащиты нет очередей [интервью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области] // Областная газета. 04.02.2026. № 11 (2949). — URL: <https://www.ogirk.ru/2026/02/04/vladimir-rodionov-na-prieme-v-sluzhbah-soczashhity-net-ocheredej/> (дата обращения: 05.10.2026).
18. [н] Контрольно-счётная палата Иркутской области. Акт № 22/41-а от 07.07.2023 по результатам проверки... средств на организацию питания в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (объект — ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»). — URL: <http://nldi.ru/files/8983.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
19. [н] Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается / Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 22.07.2025. — URL: <https://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/> (дата обращения: 05.10.2026).
20. [н] Не просто накормить: доклад к семинару 25–27.08.2026. — Репозиторий [qlolp/seminar-variable-food-2026](https://qlolp.seminar-variable-food-2026), папка raw/sources/ne-prosto-nakormit/doklad/.

21. [н] Рабочая база знаний проекта (wiki/, в том числе wiki/gaps.md, wiki/entities/, wiki/concepts/) и предшествующие аналитические записки (raw/sources/related/). — Репозиторий [qlolp/seminar-variable-food-2026](https://github.com/qlolp/seminar-variable-food-2026).
22. [о] Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения: 05.10.2026).
23. [о] Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». — URL: <https://base.garant.ru/70829256/> (дата обращения: 05.10.2026).
24. [н] Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (дата обращения: 05.10.2026).
25. [н] Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (зарег. в Минюсте России 02.06.2025 № 82485; действует с 01.09.2025 до 01.09.2031). — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_506945/ (дата обращения: 05.10.2026).
26. [н] Правила внутреннего распорядка СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» (утв. приказом от 10.03.2026 № 124). Архивная копия сайта учреждения от 15.04.2026. — URL: <https://web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/> (дата обращения: 21.08.2026).
27. [н] Питание / ГАСУСО МО «Добрый дом „Солнечногорский“». — URL: <https://ddsol.ru/about/pitanie/> (дата обращения: 05.10.2026).
28. [н] Nijs K. A. N. D., de Graaf C., Kok F. J., van Staveren W. A. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial // *BMJ*. 2006. Vol. 332. P. 1180–1184. DOI: 10.1136/bmj.38825.401181.7C.
29. [о] Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 04.06.2007 № 397). — URL: <https://base.garant.ru/184396/> ; первоначальная редакция: <https://base.garant.ru/5365902/> (дата обращения: 05.10.2026).
30. [н] Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». — URL: <https://base.garant.ru/405707433/> ; <https://mintrud.gov.ru/docs/2466> (дата обращения: 05.10.2026).
31. [о] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» (в ред. постановлений от 27.07.2017 № 616, от 19.12.2019 № 929, от 27.06.2022 № 561). — URL: <https://base.garant.ru/22921449/> (дата обращения: 05.10.2026).

32. [о] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 05.10.2026).
33. [н] Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006; ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ). — URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 05.10.2026).
34. [н] Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law. CRPD/C/GC/1. — URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/031/20/pdf/g1403120.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
35. [н] Приказ Роструда от 02.02.2026 № 18 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» (зарег. в Минюсте России 13.02.2026 № 85322; опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 13.02.2026, номер опубликования 0001202602130013; вступил в силу 24.02.2026), вопросы 17, 64, 70, 73, 75. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202602130013> ; <https://pravo.ppt.ru/prikaz/rostrud/n-18-326901> ; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_526542/ (дата обращения: 05.10.2026).
36. [н] Агафонов И. Что изменится в жизни подопечных ПНИ с сентября // Милосердие.ru. 20.06.2025. — URL: <https://www.miloserdie.ru/news/novye-pravila-i-novye-vozmozhnosti-chto-izmenitsya-v-zhizni-podopечnyh-pni-s-sentyabrya/> (дата обращения: 05.10.2026).
37. [н] Постановление Минтруда России от 25.12.2003 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по организации диетического (лечебного) питания в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (реквизиты по справке к [15] в системе «Гарант»; текст не анализировался).
38. [н] Горелик С. Г. и др. Оценка нутритивного статуса и коррекция питания лиц пожилого возраста в учреждении социального обслуживания // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2020. № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 05.10.2026).
39. [н] МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (утв. Роспотребнадзором 22.07.2021). — URL: https://www.rospotrebнадzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=18979 (дата обращения: 05.10.2026).
40. [о] Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП (нормы питания в организациях социального обслуживания). — URL: <https://base.garant.ru/405688359/> (дата обращения: 05.10.2026).
41. [н] Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального обслуживания» (ред. от 14.10.2021 № 730-п; изменения 2024–2025 гг. — постановления № 74-п и № 892-п). Текст воспроизведён на сайте КГБУ СО «КЦСОН „Тонус“» вместе

- со сведениями об организации питания учреждения. — URL: https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx (дата обращения: 05.10.2026).
42. [н] Приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 30.12.2021 № 04-58 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарём при предоставлении социальных услуг и норм питания в организациях социального обслуживания Ленинградской области...» (приложение 3; следующие изменения не проверялись). — URL: https://luga-pni.ru/f/prikazom_komiteta_po_socialnoj_zashchite_naseleniya_leningradskoj_oblasti_no04_ot_30122021_ (дата обращения: 05.10.2026).
43. [н] Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 06.10.2014 № 1164 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Новосибирской области» (с изменениями на 25.05.2023, приказ № 769-НПА). — URL: https://vencson.nso.ru/sites/vencson.nso.ru/wodby_files/files/document/2023/07/documents/ob_utverzhenii_norm_pitaniya_v_organizaciyah_socialnogo_obslyzhivaniya_novosibirskoy_obla (дата обращения: 05.10.2026).
44. [н] Положение об организации питания в государственном бюджетном учреждении «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Нижний Новгород; дата утверждения на странице не указана). — URL: <https://soc52.ru/sorm-di-documents/statement/item/447-statement-food> (дата обращения: 05.10.2026).
45. [о] Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». — URL: <https://base.garant.ru/12133007/> (дата обращения: 05.10.2026).
46. [о] Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания». — URL: <https://base.garant.ru/70412098/> (дата обращения: 05.10.2026).
47. [о] Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием». — URL: <https://base.garant.ru/74703746/> (дата обращения: 05.10.2026).
48. [н] Ткачёва О. Н., Тутельян В. А., Шестопалов А. Е. и др. Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста. Клинические рекомендации // Российский журнал гериатрической медицины. 2021. № 1. С. 15–34. DOI: 10.37586/2686-8636-1-2021-15-34.
49. [о] Организация питания: страницы сайтов учреждений социального обслуживания Омской области. — URL: <http://www.ditavrich55.ru/pitanie> ; <https://pni55.ru/perechen-zapreshchennyh-produktov> (дата обращения: 16.07.2026, по первой редакции обзора).
50. [н] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 05.10.2026).

51. [н] Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 05.10.2026).
52. [н] Письмо Минфина России от 29.12.2014 № 02-02-08/68298. — URL: <https://base.garant.ru/70853116/> (дата обращения: 05.10.2026).
53. [н] Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.12.2025 № Ф03-3556/25 по делу № А73-20917/2024. — URL: <https://base.garant.ru/37266612/> ; https://www.garant.ru/files/6/0/2049606/postanovlenie_arbitragnogo_suda_dalnevostochnogo_okruga_ot_5_dekabrya_2025_g_n_f0.pdf (дата обращения: 05.10.2026).
54. [н] Красавин Е. Верховный Суд: закупки по госзаданию автономные учреждения обязаны проводить по 44-ФЗ. Определение № 303-ЭС25-15393 // Блог pro-ability.ru. 25.02.2026. — URL: <https://www.pro-ability.ru/tpost/sbdtgydex1-verhovnii-sud-zakupki-po-gos zadaniyu-avt> (дата обращения: 05.10.2026).
55. [н] Определение судьи Верховного Суда РФ от 29.12.2025 № 303-ЭС25-15393 (об отсрочке уплаты государственной пошлины; дело № А73-20917/2024; в тексте определения номер дела указан как «А32-55513/2024», на странице базы — А73-20917/2024). — URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/aZCIdQcDpC5v/> (дата обращения: 05.10.2026).
56. [н] Когда автономные учреждения не вправе контрактаться по Закону № 223-ФЗ / ГАРАНТ.РУ; воспроизведено: Информационный портал закупок. 2026. — URL: <https://www.zakupki-portal.ru/novosti/main-news/kogda-avtonomnye-uchrezhdeniya-ne-vprave-kontraktovat-sya-po-zakonu-223-fz/> (дата обращения: 05.10.2026).
57. [н] Извещение № 0372200070825000244 «Поставка продуктов питания» (заказчик — СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“», ИНН 7827661874; опублик. 24.11.2025). — URL: <https://www.tenderguru.ru/tender/90473908> (дата обращения: 05.10.2026).
58. [о] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Ст. 6.3, 6.6, 6.7. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 05.10.2026).
59. [н] Новости прокуратуры: привлечение к ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ руководителя социально-реабилитационного центра (2022) // Кашин.инфо. — URL: <https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121> (дата обращения: 23.07.2026).
60. [н] Постановление Верховного Суда РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/> (дата обращения: 05.10.2026).
61. [н] ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов // Российская газета. 25.07.2024. — URL: <https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html> (дата обращения: 23.07.2026).
62. [н] Челябинское УФАС: картель на 27 тендерах школьного питания // Про-Госзаказ. 2025. — URL: <https://pro-goszakaz.ru/news/116068> (дата обращения: 05.10.2026).

63. [о] Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.03.2021 № 228 «Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания города Москвы» (вступает в силу с 01.04.2021; открытая часть текста: п. 1–2.1). — URL: <https://base.garant.ru/405012407/> (дата обращения: 05.10.2026).
64. [н] Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2019 № 617 «О внесении изменения в нормы питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2014 г. № 709» (вступило в силу 01.01.2020). — URL: <https://nn-gov.ru/doc/123332> (дата обращения: 05.10.2026).
65. [н] Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 22.08.2014 № 306-п «О нормах питания...» (в ред. постановления от 06.09.2014 № 327-п; актуальная редакция для совершеннолетних не проверялась). — URL: <https://lawmix.ru/zakonodatelstvo/1941538> (дата обращения: 05.10.2026).
66. [н] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 929 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284». — URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/peterburg/1318583/> (дата обращения: 05.10.2026).
67. [н] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге». — URL: <https://base.garant.ru/22921910/> (дата обращения: 05.10.2026).
68. [н] Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13.12.2024 № 1366-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2025 год». — URL: <https://base.garant.ru/411120324/> (дата обращения: 05.10.2026).
69. [н] Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 15.12.2025 № 1155-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2026 год» (опубликовано в виде графического образа; значения прочитаны распознаванием текста и сверены визуально). — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/7801202512190004> (дата обращения: 05.10.2026).
70. [о] Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 год. — URL: https://spbdeti.org/upload/iblock/357/f10ncjwqcpqic00z1kiskc8zw7jy26ow/ZAKS_2025.pdf (дата обращения: 16.07.2026, по первой редакции обзора).
71. [н] Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24.12.2014 № 1068 «Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы» (по цитированию в: Условия жизни в ПНИ / Правовой навигатор фонда «Обнажённые сердца»). — URL: <https://navigator.osoboepravo.ru/explanation/417.html> (дата обращения: 05.10.2026).

72. [о] Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214; постановление Правительства Нижегородской области от 20.10.2014 № 709 (по первой редакции обзора [79]). — URL: <https://base.garant.ru/404606671/> (дата обращения: 05.10.2026).
73. [о] Приказ от 11.11.2014 № 171-п (нормы питания в организациях социального обслуживания Омской области). — URL: <https://base.garant.ru/15588873/> (дата обращения: 05.10.2026).
74. [о] Приказ Комитета по социальной защите населения Псковской области от 14.07.2020 № 206 (нормы питания). — URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203529.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
75. [н] Постановления Правительства Красноярского края от 06.02.2024 № 74-п (вступило в силу 09.02.2024; опубликовано на pravo.gov.ru 12.02.2024, № 2400202402120004) и от 14.10.2025 № 892-п (вступает в силу 01.01.2026; опубликовано на pravo.gov.ru 17.10.2025, № 2400202510170023) «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п...»; приложение к постановлению № 607-п в публичной версии ГАРАНТ (с изменениями от 30.10.2015 и 29.11.2016; разделы 1 и 2). — URL: <https://base.garant.ru/408512695/>; <https://base.garant.ru/412848299/>; <https://base.garant.ru/29905144/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 05.10.2026).
76. [н] Приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 04.08.2025 № 04-81 «О внесении изменений в приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 04-58...» (опубликован на pravo.gov.ru 06.08.2025, № 4701202508060002; текст изменений не прочитан). — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/4701202508060002> (дата обращения: 05.10.2026).
77. [о] Отчёт о результатах контрольного мероприятия по организации питания в государственном автономном учреждении здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница» / Счётная палата Республики Татарстан. 2025. — URL: https://sprt.tatar/files/Otchet_Psih_2025.pdf (дата обращения: 16.07.2026, по первой редакции обзора).
78. [н] Wheeler M., Abbey K. L., Capra S. M. Choice on the menu: Increasing meal choice for people living in residential aged care, a pilot study // *Journal of Human Nutrition and Dietetics*. 2025. Vol. 38, № 1. e13401. DOI: 10.1111/jhn.13401.
79. [н] Cereda E., Pedrolli C., Klersy C. et al. Nutritional status in older persons according to healthcare setting: A systematic review and meta-analysis of prevalence data using MNA® // *Clinical Nutrition*. 2016. Vol. 35, № 6. P. 1282–1290. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.03.008.
80. [н] Wright O. R. L., Connelly L. B., Capra S., Hendrikz J. Determinants of foodservice satisfaction for patients in geriatrics/rehabilitation and residents in residential aged care // *Health Expectations*. 2013. Vol. 16, № 3. P. 251–265. DOI: 10.1111/j.1369-7625.2011.00711.x.
81. [н] Abbey K. L., Wright O. R. L., Capra S. Menu Planning in Residential Aged Care — The Level of Choice and Quality of Planning of Meals Available to Residents // *Nutrients*. 2015. Vol. 7, № 9. P. 7580–7592. DOI: 10.3390/nu7095354.

82. [H] Wheeler M., Abbey K. L., Capra S. M. Choice on the menu in residential aged care: An underrated tool for maintaining resident autonomy // *Nutrition & Dietetics*. 2025. Vol. 82, № 3. P. 327–336. DOI: 10.1111/1747-0080.70002.
83. [H] McCray S., Maunder K., Krikowa R., MacKenzie-Shalders K. Room Service Improves Nutritional Intake and Increases Patient Satisfaction While Decreasing Food Waste and Cost // *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. 2018. Vol. 118, № 2. P. 284–293. DOI: 10.1016/j.jand.2017.05.014.
84. [H] Wang D., Everett B., Brunero S. et al. Perspectives of residents and staff regarding food choice in residential aged care: A qualitative study // *Journal of Clinical Nursing*. 2020. Vol. 29, № 3–4. P. 626–637. DOI: 10.1111/jocn.15115.
85. [H] Bailey A., Bailey S., Bernoth M. 'I'd rather die happy': residents' experiences with food regulations, risk and food choice in residential aged care. A qualitative study // *Contemporary Nurse*. 2017. Vol. 53, № 6. P. 597–606. DOI: 10.1080/10376178.2017.1361334.
86. [H] Mondkar A., Murdoch M., Gallagher J. E., Patel R. What's on the menu? A qualitative study on the views of care home staff and residents on nutritional practices and implications for oral health // *BDJ Open*. 2025. Vol. 11. Art. 33. DOI: 10.1038/s41405-025-00325-9.
87. [H] Crogan N. L., Dupler A. E., Short R., Heaton G. Food choice can improve nursing home resident meal service satisfaction and nutritional status // *Journal of Gerontological Nursing*. 2013. Vol. 39, № 5. P. 38–45. DOI: 10.3928/00989134-20130313-02.
88. [H] Divert C., Laghmaoui R., Crema C. et al. Improving meal context in nursing homes. Impact of four strategies on food intake and meal pleasure // *Appetite*. 2015. Vol. 84. P. 139–147. DOI: 10.1016/j.appet.2014.09.027.
89. [H] Kenkmann A., Price G. M., Bolton J., Hooper L. Health, wellbeing and nutritional status of older people living in UK care homes: an exploratory evaluation of changes in food and drink provision // *BMC Geriatrics*. 2010. Vol. 10. Art. 28. DOI: 10.1186/1471-2318-10-28.
90. [H] Abbott R. A., Whear R., Thompson-Coon J. et al. Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: a systematic review and meta-analysis // *Ageing Research Reviews*. 2013. Vol. 12, № 4. P. 967–981. DOI: 10.1016/j.arr.2013.06.002.
91. [H] Herke M., Fink A., Langer G. et al. Environmental and behavioural modifications for improving food and fluid intake in people with dementia // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2018. № 7. CD011542. DOI: 10.1002/14651858.CD011542.pub2.
92. [H] Roos C., Alam M., Swall A. et al. Factors associated with older persons' perceptions of dignity and well-being over a three-year period. A retrospective national study in residential care facilities // *BMC Geriatrics*. 2022. Vol. 22. Art. 515. DOI: 10.1186/s12877-022-03205-1.
93. [H] Teasdale S. B., Ward P. B., Samaras K. et al. Dietary intake of people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis // *British Journal of Psychiatry*. 2019. Vol. 214, № 5. P. 251–259. DOI: 10.1192/bjp.2019.20.

94. [H] Özdemir A., Chapman H., Hall R., Ellahi B. Eating Well When Living With an Intellectual Disability — Exploring the Carer: Client Relationship in Residential Settings // *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*. 2025. Vol. 38, № 6. e70157. DOI: 10.1111/jar.70157.
95. [H] Pfister F., Uhlmann K., Olalia L., Kaufmann B. Institutional and interpersonal determinants of dietary practices of persons with intellectual disability in institutional accommodation in Switzerland: a qualitative study // *BMC Public Health*. 2026. Vol. 26. Art. 1100. DOI: 10.1186/s12889-026-26794-7.
96. [H] Volkert D., Beck A. M., Cederholm T. et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics // *Clinical Nutrition*. 2022. Vol. 41, № 4. P. 958–989. DOI: 10.1016/j.clnu.2022.01.024.
97. [H] Volkert D., Beck A. M., Faxén-Irving G. et al. ESPEN guideline on nutrition and hydration in dementia — Update 2024 // *Clinical Nutrition*. 2024. Vol. 43, № 6. P. 1599–1626. DOI: 10.1016/j.clnu.2024.04.039.
98. [H] Roulston M., Thompson C., Pelly F., Cave D. Food waste in residential aged care: A scoping review // *Nutrition & Dietetics*. 2026. Vol. 83, № 1. P. 56–73. DOI: 10.1111/1747-0080.70034.
99. [H] Williams P., Walton K. Plate waste in hospitals and strategies for change // *e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism*. 2011. Vol. 6, № 6. P. e235–e241. DOI: 10.1016/j.eclnm.2011.09.006.
100. [H] Nishida Y., Tanaka S., Nakae S. et al. Energy Gap between Doubly Labeled Water-Based Energy Expenditure and Calculated Energy Intake from Recipes and Plate Waste, and Subsequent Weight Changes in Elderly Residents in Japanese Long-Term Care Facilities: CLEVER Study // *Nutrients*. 2020. Vol. 12, № 9. Art. 2677. DOI: 10.3390/nu12092677.
101. [H] Vucea V., Keller H. H., Morrison J. M. et al. Prevalence and Characteristics Associated with Modified Texture Food Use in Long Term Care: An Analysis of Making the Most of Mealtimes (M3) Project // *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*. 2019. Vol. 80, № 3. P. 104–110. DOI: 10.3148/cjdpr-2018-045.
102. [H] Porter J., Ottrey E., Huggins C. E. Protected Mealtimes in hospitals and nutritional intake: Systematic review and meta-analyses // *International Journal of Nursing Studies*. 2017. Vol. 65. P. 62–69. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2016.11.002.
103. [H] Hamasaki Y., Sakata N., Jin X. et al. Facility staffing associated with potentially avoidable hospitalizations in nursing home residents in Japan: a retrospective cohort study // *BMC Geriatrics*. 2023. Vol. 23. Art. 566. DOI: 10.1186/s12877-023-04278-2.
104. [H] Keller H. H., Syed S., Dakkak H. et al. Reimagining Nutrition Care and Mealtimes in Long-Term Care // *Journal of the American Medical Directors Association*. 2022. Vol. 23, № 2. P. 253–260.e1. DOI: 10.1016/j.jamda.2021.12.021.
105. [H] Simmons S. F., Osterweil D., Schnelle J. F. Improving food intake in nursing home residents with feeding assistance: a staffing analysis // *The Journals of Gerontology. Series A*. 2001. Vol. 56, № 12. P. M790–M794. DOI: 10.1093/gerona/56.12.m790.
106. [H] Simmons S. F., Schnelle J. F. Individualized feeding assistance care for nursing home residents: staffing requirements to implement two interventions // *The*

- Journals of Gerontology. Series A. 2004. Vol. 59, № 9. P. M966–M973. DOI: 10.1093/gerona/59.9.m966.
107. [Н] Simmons S. F., Schnelle J. F. Feeding assistance needs of long-stay nursing home residents and staff time to provide care // Journal of the American Geriatrics Society. 2006. Vol. 54, № 6. P. 919–924. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2006.00812.x.
108. [Н] Simmons S. F., Keeler E., Zhuo X. et al. Prevention of unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance // Journal of the American Geriatrics Society. 2008. Vol. 56, № 8. P. 1466–1473. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.01801.x.
109. [Н] Hugo C., Isenring E., Sinclair D., Agarwal E. What does it cost to feed aged care residents in Australia? // Nutrition & Dietetics. 2018. Vol. 75, № 1. P. 6–10. DOI: 10.1111/1747-0080.12368.
110. [Н] The Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014 (SI 2014/2936). Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs. — URL: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2936/regulation/14> (дата обращения: 05.10.2026).
111. [Н] Care Quality Commission. Regulations for service providers and managers. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs (guidance; page last updated 16.05.2025). — URL: <https://www.cqc.org.uk/guidance-providers/regulations/regulation-14-meeting-nutritional-hydration-needs> (дата обращения: 05.10.2026).
112. [Н] Scottish Government. Health and Social Care Standards: my support, my life. 2017. Standards 1.33–1.39; Care Inspectorate. Eating and drinking well in care: good practice guidance. — URL: <https://www.gov.scot/publications/health-social-care-standards-support-life/> ; <https://www.careinspectorate.com/> (дата обращения: 05.10.2026).
113. [Н] 42 CFR § 483.60. Food and nutrition services. — URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60> (дата обращения: 05.10.2026).
114. [Н] Centers for Medicare & Medicaid Services. State Operations Manual. Appendix PP — Guidance to Surveyors for Long Term Care Facilities (Rev. 225, issued 08.08.2024). F806 «Resident Allergies, Preferences and Substitutes» (Rev. 173, effective 28.11.2017). — URL: <https://www.cms.gov/medicare/provider-enrollment-and-certification/guidanceforlawsandregulations/downloads/appendix-pp-state-operations-manual.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
115. [Н] Centers for Medicare & Medicaid Services. Form CMS-20053 «Dining Observation» (8/2015). — URL: <https://www.cms.gov/files/document/cms-20053-diningpdf> (дата обращения: 05.10.2026).
116. [Н] Ontario Regulation 246/22 (General) under the Fixing Long-Term Care Act, 2021. Section 77: Menu planning (воспроизведено по: OSNAC Menu Evaluation & Approval Tool for LTC, July 2022). — URL: <https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246> ; https://www.osnac-fnat.com/_files/ugd/666b77_dd887e8092914e799e758624ed767e8e.pdf (дата обращения: 05.10.2026).
117. [Н] Ministry of Health and Long-Term Care (Ontario), Long-Term Care Inspections Branch. Inspection Protocol «Dining Observation» (May 2019; составлен по Long-Term Care Homes Act, 2007 и O. Reg. 79/10, впоследствии заменённым Fixing Long-Term Care Act, 2021 и O. Reg. 246/22; на 05.10.2026 по этому адресу на порта-

- ле министерства размещена та же редакция мая 2019 г.). — URL: <https://www.ltchomes.net/LTCHPORTAL/Content/Snippets/Dining%20Observation.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
118. [н] Australian Government, Department of Health, Disability and Ageing. Strengthened Aged Care Quality Standards (Standard 6: Food and nutrition), в силе с 01.11.2025; Basic Daily Fee supplement. — URL: <https://www.health.gov.au/> (дата обращения: 05.10.2026).
 119. [н] Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung mit „Essen auf Rädern“ und in Senioreneinrichtungen. 1. Auflage, 1. korrigierter Nachdruck. Bonn, 2022. — URL: https://www.dge.de/fileadmin/dok/gemeinschaftsgastronomie/dge-qualitaetsstandards/DGE-Qualitaetsstandard_Essen_auf_Raedern_Senioreneinrichtungen_aktualisiert.pdf (дата обращения: 05.10.2026).
 120. [н] Österreichische Gesellschaft für Ernährung / Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Qualitätsstandard für die Verpflegung in Pflegeeinrichtungen (2022). — URL: <https://www.sozialministerium.at/> (дата обращения: 05.10.2026).
 121. [н] Livsmedelsverket. Bra måltider i äldreomsorgen: nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Uppsala, 2019 (uppdaterad maj 2024). ISBN 978-91-7714-262-1. — URL: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf (дата обращения: 05.10.2026).
 122. [н] Ankestyrelsen. Tilsynsudtalelse om Fredericia Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens § 83), 17.05.2024 (воспроизведено: DanmarkC TV, 07.06.2024). — URL: <https://danmarkc.tv/afgoerelse-ankestyrelsen-vurderer-at-fredericia-kommune-handler-i-strid-med-lovgivningen/> (дата обращения: 05.10.2026).
 123. [н] Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Long-term care insurance: nutrition management; LIFE (Long-term care Information system For Evidence), 2021. — URL: <https://www.mhlw.go.jp/> (дата обращения: 05.10.2026).
 124. [н] 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針 (Указания о плате за проживание и питание; приказ-уведомление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии от 07.09.2005 № 419, с изм.). — URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7416&dataType=0&pageNo=1 (дата обращения: 05.10.2026).
 125. [н] 厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等 (Критерии предоставления особых комнат и особого питания по выбору пользователя; приказ-уведомление Министерства здравоохранения и благосостояния Японии от 30.03.2000 № 123, с изм.), разд. 2. — URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0441&dataType=0&pageNo=1 (дата обращения: 05.10.2026).
 126. [н] Manimaran S., Razalli N. H., Abdul Manaf Z. et al. Strategies to Reduce the Rate of Plate Waste in Hospitalized Patients: A Scoping Review // *Nutrients*. 2023. Vol. 15, № 2. Art. 301. DOI: 10.3390/nu15020301.

127. [н] Crogan N. L., Evans B. C. The shortened food expectations — long-term care questionnaire: assessing nursing home residents' satisfaction with food and food service // *Journal of Gerontological Nursing*. 2006. Vol. 32, № 11. P. 50–59. DOI: 10.3928/00989134-20061101-08.
128. [н] Yaxley A., Pankhurst M., Morgillo S., Miller M. A world-first food service satisfaction questionnaire for use with family members of nursing home residents // *The Journal of Nutrition, Health and Aging*. 2024. Vol. 28, № 1. Art. 100015. DOI: 10.1016/j.jnha.2023.100015.
129. [н] Trinca V., Chaudhury H., Slaughter S. E. et al. Making the Most of Mealtimes (M3): Association Between Relationship-Centered Care Practices, and Number of Staff and Residents at Mealtimes in Canadian Long-Term Care Homes // *Journal of the American Medical Directors Association*. 2021. Vol. 22, № 9. P. 1927–1932.e1. DOI: 10.1016/j.jamda.2020.11.020.
130. [н] Keller H. H., Wu S. A., Iraniparast M. et al. Relationship-Centered Mealtime Training Program Demonstrates Efficacy to Improve the Dining Environment in Long-Term Care // *Journal of the American Medical Directors Association*. 2021. Vol. 22, № 9. P. 1933–1938.e2. DOI: 10.1016/j.jamda.2020.11.008.
131. [н] Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 999 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания» (вступило в силу 01.07.2021), п. 2 постановления, п. 2–3 Положения. — URL: <https://pravo.ppt.ru/postanovlenie/pravitelstvo/n-999-251824> (дата обращения: 05.10.2026).
132. [н] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2021 № 985 «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания в Санкт-Петербурге» (ред. от 28.02.2022), п. 6, 7; п. 1.2, 1.3 Положения. — URL: <https://base.garant.ru/403267034/> (дата обращения: 05.10.2026).
133. [н] Управление социального питания Санкт-Петербурга. Отчёт об оценке уровня организации социального питания в государственных учреждениях Санкт-Петербурга... за 2 квартал 2025 года (нарастающим итогом за 1 полугодие 2025 года) (размещён 20.01.2026). — URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/kachestvo-prodovolstvennogo-obespecheniya-socialnyh-uchrezhdenij/> (дата обращения: 05.10.2026).
134. [о] Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (дата обращения: 05.10.2026).
135. [о] Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». — URL: <https://base.garant.ru/12117866/> (дата обращения: 05.10.2026).
136. [о] Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 05.10.2026).

Приложение А. Реестр нормативных и иных актов

Классы: Н — норма (обязательна); Р — рекомендация (рекомендательный акт); МР — методический документ; Л — локальная форма; С — судебный акт; И — иностранный акт или документ (в России не действует). Статус — на 05.10.2026.

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
1	Конституция РФ, ст. 7, 21, 39, 41	Н	Социальное государство, достоинство, социальное обеспечение, охрана здоровья	[32]
2	Конвенция о правах инвалидов, ст. 19, 25, 28	Н (междунар.)	Самостоятельный образ жизни, здоровье, достаточный уровень жизни	[33]
3	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ	Н	Права получателей, индивидуальная программа, плата до 75 %	[22]
4	Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1, ст. 5, 37, 43	Н	Для ПНИ: гуманное отношение, религиозные каноны и пост	[24]
5	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ	Н	Основание санитарных правил	[134]
6	Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ	Н	Качество и безопасность пищевых продуктов; диетическое питание	[135]
7	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ	Н	Медицинская помощь, лечебное питание	[136]
8	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ч. 4 ст. 15, ч. 24 ст. 22, ст. 95	Н	Закупки бюджетных учреждений; цена единицы; изменение количества	[50]
9	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ	Н	Закупки автономных учреждений	[51]
10	КоАП РФ, ст. 6.3, 6.6	Н	Санитарная ответственность	[58]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
11	Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н (Правила организации деятельности), п. 15, подп. 10, 13, 15 п. 20, п. 29; прил. № 2	Н (прил. № 2 — Р)	Нормы питания — акт субъекта; условия для соблюдения постов во всех организациях; помещение для приготовления пищи получателями	[25]
12	Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н	Р (примерный порядок)	Питание как социально-бытовая услуга	[23]
13	Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н	Р	Рекомендуемые нормы питания	[30]
14	Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 (ред. 04.06.2007)	МР	Продуктовые наборы, меню-раскладки, нормы взаимозаменяемости (прил. 7), замена по белку и углеводам (прил. 8)	[29]
15	Постановление Минтруда России от 25.12.2003 № 90	МР	Диетическое (лечебное) питание в учреждениях соцобслуживания	[37]
16	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ от 27.10.2020 № 32)	Н, утратил силу с 01.09.2026	Применялся до 31.08.2026	[2]
17	СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ от 02.06.2026 № 18)	Н, с 01.09.2026 до 01.09.2032	Действующие санитарные требования; п. 3, 11, 24, 25, 32, 43, 56, 59	[3]
18	МР 2.3.1.0253-21	МР	Нормы физиологических потребностей	[39]
19	Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330	Н (для медорганизаций)	Лечебное питание; совет по питанию	[45]
20	Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н	Н (для медорганизаций)	Нормы лечебного питания	[46]
21	Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н	Н (для медорганизаций)	Порядок обеспечения лечебным питанием	[47]
22	Пост. Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 (ред. 27.06.2022 № 561)	Н	Нормы питания СПб; две нормы для ПНИ	[31]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
23	Пост. Правительства СПб от 29.12.2014 № 1283	Н	Порядки предоставления социальных услуг в СПб	[67]
24	Распоряжение КСП СПб от 13.12.2024 № 1366-р; от 15.12.2025 № 1155-р	Н	Тарифы на 2025 и 2026 гг.	[68, 69]
25	Пост. Правительства СПб от 19.12.2019 № 929	Н	Новая редакция норм с 01.01.2020	[66]
26	Приказ ДТСЗН г. Москвы от 22.03.2021 № 228	Н	Нормы питания Москвы	[63]
27	Пост. Правительства Свердловской обл. от 10.11.2022 № 765-ПП	Н	Нормы питания; ссылка на прил. 11 СанПиН	[40]
28	Пост. Правительства Нижегородской обл. от 20.10.2014 № 709 (ред. пост. от 30.08.2019 № 617, с 01.01.2020)	Н	Нормы питания для взрослых в нетто; положений о выборе и замене нет	[64, 72]
29	Приказ Омской обл. от 11.11.2014 № 171-п	Н	Нормы питания	[73]
30	Приказ КСЗН Псковской обл. от 14.07.2020 № 206	Н	Нормы питания	[74]
31	Пост. Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п (ред. 14.10.2021; изм. № 74-п от 06.02.2024, № 892-п от 14.10.2025)	Н	Нормы питания в брутто; отдельный раздел для ПНИ (с 2026 г. — ДСО); положений о замене нет	[41, 75]
32	Распоряжение минсоцразвития Московской обл. от 13.04.2017 № 19РВ-32	Н	Нормы питания в ПНИ Московской обл. (по [27])	[27]
33	Приказ минсоцразвития Иркутской обл. от 11.12.2014 № 193-мпр	Н	Порядок предоставления услуг в стационарной форме	[15]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
34	Приказ СПб ГАСУ-СОН «ДСО „Серафимовский“» от 10.03.2026 № 124	Л	Правила внутреннего распорядка; заказное питание	[26]
35	Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014, reg. 14	И	Предпочтения как часть потребности в питании	[110]
36	Health and Social Care Standards (Scotland), 2017	И	Право выбирать и участвовать в планировании меню	[112]
37	42 CFR § 483.60	И	Альтернатива сходной пищевой ценности; ≤14 ч	[113]
38	O. Reg. 246/22 (Ontario), s. 77	И	Цикл ≥21 дня с выбором на каждом приёме	[116]
39	Пост. Правительства РФ от 25.06.2021 № 999	Н	Федеральный госконтроль в сфере соцобслуживания (Роструд), в том числе за организациями субъектов	[131]
40	Приказ Роструда от 02.02.2026 № 18	Н	Проверочный лист: нормы питания (в. 64), посты (в. 75); вопроса о выборе нет	[35]
41	Пост. Правительства СПб от 14.12.2021 № 985	Н	Региональный контроль только за негосударственными поставщиками; отмена пост. № 1291	[132]
42	Приказ ДСЗН г. Москвы от 24.12.2014 № 1068	Н	Нормы питания в стационарной форме (соотношение с № 228 не установлено)	[71]
43	Приказ КСЗН Ленинградской обл. от 30.12.2021 № 04-58, прил. 3 (изм. приказом от 04.08.2025 № 04-81, текст изменений не прочитан)	Н	Нормы питания в брутто и нетто; коэффициенты пересчёта	[42, 76]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
44	Пост. Правительства ХМАО — Югры от 22.08.2014 № 306-п (ред. № 327-п)	Н	Нормы питания в нетто	[65]
45	Приказ МСР Новосибирской обл. от 06.10.2014 № 1164 (ред. № 769-НПА от 25.05.2023)	Н	Нормы питания в брутто; СБКС по медицинским показаниям; положений о замене нет	[43]
46	Положение об организации питания ГБУ «Сормовский дом-интернат»	Л	Документальная цепочка единого меню; таблицы замен; внутренний контроль	[44]
47	Пост. АС Дальневосточного округа от 05.12.2025 № Ф03-3556/25	С	Критерий цели закупки для автономного учреждения (223-ФЗ / 44-ФЗ)	[53]
48	Определение судьи ВС РФ от 29.12.2025 № 303-ЭС25-15393	С	Только отсрочка госпошлины; определение по существу не найдено	[55]
49	СQC, руководство к регламенту 14 (ред. 16.05.2025)	И	Выбор рациона, время и место еды, перекусы	[111]
50	CMS, State Operations Manual, App. PP, F806; форма CMS-20053	И	Проверка замены при отказе; наблюдение приёма пищи	[114, 115]
51	Ontario, Inspection Protocol «Dining Observation» (2019)	И	Закрытые вопросы проверки меню, выбора и помощи	[117]
52	DGE-Qualitätsstandard (2022)	И (Р)	Цикл ≥6 недель; несколько линий; пищевая биография; учёт возвратов	[119]
53	Livsmedelsverket, национальные рекомендации (2019, обновл. 2024)	И (Р)	Критерии влияния жителя; совет по питанию; базовое меню	[121]
54	Serviceoven § 83 (Дания); заключение Ankestyrelsen от 17.05.2024	И	Отказ от отдельных приёмов пищи	[122]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
55	Приказы-уведомления МЗТБ Японии № 419 и № 123	И	«Особое питание» по выбору с гарантиями	[124, 125]
56	Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обл. от 28.11.2014 № 184-мпр (по акту КСП)	Н	Нормы питания в домах-интернатах (43 наименования); текст приказа не прочитан	[18]
57	Акт Контрольно-счётной палаты Иркутской обл. от 07.07.2023 № 22/41-а	Акт финансового контроля	Нарушения в документальной цепочке питания; стандарт «помощь в приёме пищи» — до 15 мин	[18]

Приложение Б. Нормы постановления № 1284: все столбцы для взрослых

Нетто, граммы на человека в сутки, если не указано иное [31]. Столбцы: (1) учреждения, кроме ПНИ; (2) ПНИ, норма с СБКС; (3) лица с сахарным диабетом; (4) лица с заболеваниями ЖКТ; (5) ПНИ, норма без СБКС; (6) рекомендуемая норма приказа № 520н для лиц 18 лет и старше [30].

Продукт	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 520н
Хлеб ржаной	150	150	250	150	200	150
Хлеб пшеничный	100	200	10	150	250	150
Мука пшеничная	45	45	17	40	45	15
Мука картофельная (крахмал)	2,5	3	—	3	3	5
Макаронные изделия	20	25	16	24	25	20
Крупы, бобовые	80	49,6	111	53	70	80
Овощи (все группы)	318	380	402	233,6	380	394,5 ¹
Картофель	168	268	44	126,2	268	200
Фрукты и ягоды свежие	200	100	385	200	100	150
Сухофрукты, шиповник	10	16	81	10	16	20 + 15 ²
Соки	60	60	66 ³	74	60	100 мл
Мясо (говядина, свинина)	90	70,5	55	57,8	85,2	90
Птица	40	36,5	40	42,7	35	22,2
Колбаса, колбасные изделия	25	25	21	21	25	12
Рыба, рыбопродукты	41,8	46,7	30,8	26,4	46,7	32,5
Сыр	14	9,3	6,5	12,1	9,3	15
Яйцо	4 шт./нед	4 шт./нед	3,5 шт./нед	4 шт./нед	4 шт./нед	½ шт./сут
Молоко	200	200	240	213	200	200 мл
Кисломолочные продукты	200	200	200	200	200	121 мл

Продукт	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 520н
Творог	40	50	80	42	50	20
Масло сли- вочное	20	20	23	24	23	20
Масло рас- тительное	20	20	21	14	23	20 мл
Маргарин	10	10	—	—	4	—
Сметана	10	15	24	17	15	15
Кондитер- ские изде- лия	15	15	—	14	15	50 ⁴
Сахар	57	57	15 ⁵	53	57	(в составе 50 ⁴)
Сахарозаме- нитель	—	—	4	—	—	—
Чай	2	2	2	2	2	2
Кофе, ко- фейный на- питок, какао	1,5	2	1	1,5	2	1,4
Соль	10	10	4	4	10	8
СБКС	27	27	—	—	—	27 по мед. показаниям
Витаминно- минераль- ные ком- плексы	1 драже 3 раза в неде- лю	1 драже 3 раза в неде- лю	—	—	1 драже 3 раза в неде- лю	50–100 % фи- зиол. нормы по мед. по- казаниям

¹ Сумма: свежие 340 + солёные и маринованные 15 + зелень 14,8 + консервированные 24,7. ² Сухофрукты 20 и шиповник 15 указаны в приказе № 520н отдельно. ³ Для лиц с сахарным диабетом — «сок без сахара». ⁴ В приказе № 520н — единая позиция «сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия». ⁵ Для лиц с сахарным диабетом сахар не входит в рецептуру блюд и выдаётся отдельно (примечание к постановлению № 1284).

Приложение В. Изменения по сравнению с первой редакцией

Раздел первой редакции	Что изменено во второй редакции	Основание
Введение	Добавлены классы утверждений и указание на действующую редакцию СанПиН	Переход на СанПиН 4282-26 с 01.09.2026 [3]
Понятийный аппарат	Разграничены цикличное меню, вариативное меню, таблица замен, персонализация; три шкалы (раздача, участие, модели обзора)	Рабочая база проекта [21]
Федеральный уровень	Добавлены приказ № 305н (Правила организации деятельности, с 01.09.2025), приказ № 520н, Закон № 3185-1, постановление № 90 (2003); исправлен номер приложения норм взаимозаменяемости (7 вместо 6), добавлено приложение № 8; ст. 6.6 КоАП как специальная норма	[24, 29, 30, 58]
Санитарные правила	СанПиН 3590-20 заменён на СанПиН 4282-26 с хронологией перехода; установлено, что таблица замен прил. 11 нормативно детская	[2, 3]
Региональный уровень	Петербургская норма проверена по тексту; выявлена вторая норма для ПНИ (без СБКС); добавлены тарифы 2025 г. и постановление № 1283; удалены неподтверждённые характеристики практик Москвы и Нижегородской области; пилот детского омбудсмана отнесён к школам	[31, 67, 68, 70]
Практика регионов	Вместо одного кейса — восемь учреждений и региональное сообщество; удалены детали, отсутствующие в источнике (выбор накануне в Болотнинском ПНИ)	[5–19, 26, 27]
Зарубежный опыт	Раздел о странах СНГ удалён как неподтверждённый; добавлены первоисточники Англии, Шотландии, США, Онтарио, Австралии, Германии, Швеции, Японии	[110–123]
Научная база	Добавлен раздел о научных данных (выбор, удовлетворённость, пищевой статус, отходы, стоимость, люди с психическими расстройствами)	[28, 38, 48, 78–83, 87, 88, 90, 91, 96–99, 101–103, 109]

Раздел первой редакции	Что изменено во второй редакции	Основание
Модели и рекомендации	Модели внедрения заменены шестнадцатью операционными сценариями с указанием классов; предложения помечены как рекомендации автора	—
Риски и экономика	Сняты взаимоисключающие утверждения о затратах; приведены зарубежные данные и иллюстративная арифметика с петербургскими тарифами	[19, 68, 78, 109]
Приложения	Образцы положения, модели меню и чек-лист не воспроизводятся (доклад не содержит раздаточных материалов); добавлены реестр актов с классами, полная таблица норм № 1284 и перечень изменений	—

Дополнение второй редакции (октябрь 2026 г.)

После первой сборки второй редакции текст расширен только за счёт новых источников; число позиций в списке источников выросло с 98 до 132 (по данным сборки), а в третьем проходе — до 136. Ниже — что добавлено и что исправлено.

Глава	Добавлено	Исправлено
2	Ход дела № А73-20917/2024 по тексту постановления округа; проверка сведений об определении ВС № 303-ЭС25-15393; постные обязанности — в связке с проверочным листом Роструда	Определение ВС описывалось по блогу; теперь указано, что под этим номером найдено только определение об отсрочке госпошлины, а пересказ блога расходится с делом в проверяемых деталях
3	Полные тексты норм Новосибирской области, Красноярского края, Ленинградской области, ХМАО — Югры; московский приказ № 228 (п. 2.1, ± 5 % калорийности за неделю) и приказ № 1068; нижегородское положение об организации питания; тарифы Санкт-Петербурга на 2026 г.; раздел о брутто и нетто	Реквизит «постановление Ленинградской области № 458» заменён на приказ № 04-58; «постановление № 1068-ПП» — на приказ ДСЗН Москвы № 1068; формулировка о причине изменения тарифов смягчена до установленного
4	Ресурсные данные Успенского ПНИ (2026); высказывание министра Иркутской области (2026)	Статус иркутского формата «два первых, два вторых» — не подтверждён
5	Качественные исследования выбора; достоинство при приёме пищи; время помощи при еде; исследование CLEVER о точности расчёта съеденного	—

Глава	Добавлено	Исправлено
6	Швеция, Дания, Япония; руководство СЭС (2025); процедуры проверки США (F806, CMS-20053) и Онтарио	Цикл обеда по стандарту DGE: не менее 6 недель в учреждениях (ранее ошибочно — 4)
7	Сценарии 11–16: день меню по № 1284 с таблицей замен, лоты по 223-ФЗ, документальная цепочка дня, время персонала, жители без вербального выбора, пост по № 305н; тарифы 2026 г. в сценарии 8 (иллюстрация)	Указание на проверяющий орган (Роструд или орган субъекта)
8	Федеральный госконтроль (Роструд) и проверочный лист 2026 г.; оценка Управления социального питания Санкт-Петербурга; зарубежные процедуры проверки; чек-лист наблюдения приёма пищи; распределение документов по контролёрам; пост как предмет проверки	Государственные дома-интернаты субъектов проверяет не орган субъекта в порядке регионального контроля, а Роструд (ст. 33 442-ФЗ в ред. № 170-ФЗ)
9	Позиции 31–40; обновлены позиции 24 и 26	—
10	Предложения 7, 9, 10, 12, 14, 17–22	Ссылки на пункты глав 4 и 7 приведены в соответствие с нумерацией

Третий проход: литературная правка и дополнительные источники (октябрь 2026 г.)

Весь текст, от аннотации до приложений, вычитан и переписан литературно: убраны канцелярские связки и пустые обороты, длинные абзацы о деле № А73-20917/2024 разбиты, формулировки сокращены. Каждое утверждение с источником, числа, ссылки, классы утверждений, словарь различений, 40 противоречий, 16 сценариев и 24 предложения сохранены; сверка ссылок и чисел до и после правки проведена по каждой главе. Новые факты внесены только с источниками.

Глава	Добавлено	Исправлено
3	Нормы Нижегородской области в ред. пост. № 617 (нетто) [64]; изменения красноярского акта постановлениями № 74-п (2024) и № 892-п (2025) и отдельный раздел норм для ПНИ (с 2026 г. — ДСО) [75]; изменение ленинградского приказа от 04.08.2025 № 04-81 [76]	Красноярская норма описывалась как единая для всех стационаров; нижегородские нормы — «нет данных» о единицах
4	Нормативная рамка Иркутской области по акту КСП: приказ № 184-мпр, стандарт услуги «помощь в приёме пищи» — до 15 мин [18]	—

Глава	Добавлено	Исправлено
6	Статус онтарийского протокола 2019 г.: на портале министерства на 05.10.2026 размещена та же редакция [117]	—
7	Сценарий 13 — что находят финансовые проверки [18]; сценарий 14 — норматив 15 мин против 35–42 мин [18, 105–108]	Ссылка на п. 4.10 заменена на п. 4.11; утверждение о том, что у Wright и соавт. время выбора «сильнее» характеристик еды, заменено формулировкой, совпадающей с гл. 5
8	Раздел «Контрольно-счётные органы»; дата официального опубликования проверочного листа Роструда (13.02.2026) [35]	Пометка «по данным публикации» о вступлении в силу 24.02.2026 снята после сверки с Официальным интернет-порталом правовой информации
Аннотация, 11	Нижегородская область в числе прочитанных актов	«Шести российских кейсах» → «восьми»

Открытые вопросы, оставленные автором для решения. Кто решает за жителя, не способного выразить выбор (сценарий 15); формулировка о принудительном кормлении (гл. 9, позиция 18); отбор суточной пробы каждого варианта (сценарий 13); тарифная иллюстрация в сценарии 8 сохранена и помечена как иллюстративная.